INSURANCE COVERAGE GUIDE 2026

한 권으로 끝내는 보험 보장 가이드

증권 읽는 법부터 암·뇌·심장, 수술비, 간병, 운전자보험,
그리고 5세대 실손 전환까지 — 내 보험을 스스로 점검하는 실전서

보장분석 · 사망·장해 · 암·뇌·심장 · 수술비 · 장기요양·치매·간병 · 노후준비(종신·연금·상속·변액) · 운전자보험 · 치아보험 · 화재보험 · 실손 1~5세대 · 정부지원제도 · 질병분류코드



지은이 **박혜경** · 보험친구 · (주)뉴니케 보험자산관리전문회사(GA)

2026년 10월 개정판 · 본문 기준일 2026.10

PROLOGUE

머리말 — 보험은 '가입'보다 '이해'가 먼저입니다

대한민국 가구의 보험 가입률은 90%를 훌쩍 넘습니다. 한 사람이 여러 건의 보험을 가진 것은 흔한 일이고, 매달 빠져나가는 보험료를 합치면 생활비에서 적지 않은 비중을 차지합니다. 그런데 정작 "내 보험이 무엇을, 얼마나, 언제까지 보장하는지" 정확히 설명할 수 있는 사람은 많지 않습니다. 지인의 권유로, 전화 한 통으로, 혹은 '좋다더라'는 말만 듣고 가입한 보험이 서랍 속 증권으로만 남아 있는 경우가 대부분입니다.

문제는 보험의 진짜 가치가 **사고가 났을 때** 비로소 드러난다는 점입니다. 막상 암 진단을 받고, 수술을 받고, 교통사고를 내고 나서야 "이건 보장이 안 된다", "한도가 너무 작다", "갱신 보험료가 감당이 안 된다"는 사실을 알게 됩니다. 그때는 이미 늦습니다. 병력이 생긴 뒤에는 새로 가입하기 어렵거나, 가입하더라도 훨씬 비싼 보험료를 내야 하기 때문입니다.

이 책은 그런 일을 막기 위해 썼습니다. 보험 상품을 팔기 위한 책이 아니라, **내가 가진 보험을 스스로 읽고, 부족한 부분과 넘치는 부분을 판단할 수 있게 돕는 책**입니다. 통계청·국립암센터·국민건강보험공단·보험개발원 등 공공기관의 공개 통계와 현행 제도를 바탕으로, 보험 현장에서 가장 자주 받는 질문들을 주제별로 정리했습니다.

이 책의 구성

PART 1 · 보험 기초 다지기

증권 읽는 법, 보장분석이 필요한 이유, 갱신형과 비갱신형, 계약 전 알릴의무(표준체·간편체)를 다룹니다.

PART 2 · 사망과 장해

사망의 범주, 생명보험과 손해보험의 차이, 사망원인 통계, 후유장해 지급률을 정리합니다.

PART 3 · 3대 질병(암·뇌·심장)

CI와 GI, 암 통계·병기·치료법, 종수술, 산정특례, 뇌혈관·심장질환의 보장 범위와 질병코드를 해부합니다.

PART 4 · 수술비

수술의 세대 변화, 질병수술비·N대수술비·1~5종·ADRG 종수술비의 차이와 수술 통계를 봅니다.

PART 5 · 장기요양·치매·간병

노인장기요양보험의 대상과 등급·비용, 치매 척도(CDR), 요양병원과 요양원, 간병보험을 한데 묶어 정리합니다.

PART 6 · 노후 준비(종신·연금·상속재원·변액)

종신보험의 연금전환과 사망보험금 유동화, 연금 3층과 세액공제, 상속세와 증여 활용, 변액보험의 구조와 최저보증을 한데 묶었습니다.

PART 7 · 자동차·운전자보험

자동차보험 6대 담보, 부상등급, 형사책임과 12대 중과실, 운전자보험 변천사와 2026년 변화를 다룹니다.

PART 8 · 치아보험

치과 치료비의 급여·비급여 구조, 치아보험 알릴의무와 가입 요령, 치료 종류별 비용을 설명합니다.

PART 9 · 화재보험

실화책임법 개정 이후의 배상 책임, 세입자 구상권, 주택화재보험 담보와 가입금액 정하는 법을 다룹니다.

PART 10 · 실손의료보험 1~5세대

세대별 변천사, 보상하지 않는 손해, 4세대 특징과 차등제, 5세대 실손 전환 손익 계산법까지 담았습니다.

마지막 **PART 11**에서는 몰라서 못 받는 정부 의료비 지원제도를, **부록**에서는 진단서의 질병분류코드(KCD) 읽는 법과 보장분석 워크시트, 보험 용어 사전을 제공합니다.

이 책을 읽는 방법

1. **먼저 내 보험증권을 모두 꺼내 놓으세요.** 보험사 앱이나 '내보험다보여(생명·손해보험협회 통합조회)'와 '내보험찾아줌' 서비스에서 가입 내역을 한 번에 조회할 수 있습니다.
2. **PART 1을 읽으며 증권의 기본 항목을 표시하세요.** 상품 종류, 납입·보장기간, 갱신 여부, 주요 담보와 가입금액을 적어 두면 이후 장을 읽을 때 바로 비교할 수 있습니다.
3. **관심 있는 위험부터 읽어도 됩니다.** 각 장은 독립적으로 구성했습니다. 장마다 '핵심 요약', '현장 Q&A', '점검 체크리스트'가 있으니 체크리스트만 먼저 훑어보는 것도 좋은 방법입니다.
4. **부록의 보장분석 워크시트를 채우세요.** 책을 다 읽은 뒤 워크시트를 완성하면 내 보험의 과부족이 한눈에 보입니다.

일러두기

- 본문의 통계·제도·금액은 2026년 10월 집필 시점에 확인 가능한 공개 자료를 기준으로 하며, 출처와 기준 연도를 함께 표시했습니다. 통계는 매년 갱신되므로 최신 수치는 각 기관 발표를 확인하세요.
- 보험금 지급 여부와 금액은 **가입 시점의 약관과 보험증권**에 따라 결정됩니다. 이 책의 설명은 일반적인 구조를 이해하기 위한 것이며, 개별 계약의 보장 판단을 대신하지 않습니다.
- 특정 보험사·상품의 가입을 권유하지 않습니다. 사례에 나오는 금액은 이해를 돕기 위한 가정이며 실제 보험료는 나이·성별·건강상태·상품에 따라 달라집니다.
- 보험 계약을 해지하거나 갈아타기 전에는 반드시 새 보험의 가입 승인(인수 확정)을 먼저 받으세요. 기존 계약을 먼저 해지하면 보장 공백이 생길 수 있습니다.

AUTHOR

지은이 소개 — 보험친구 박혜경



보험이 쉬워지는 시간

박혜경

(주)뉴니케 보험자산관리전문회사(GA)
보험설계사 · 등록번호 NK301239

"어려운 보험은 쉽게, 필요한 보장은 제대로"

대구에서 천연비누·천연화장품 공방 '엔비솝'을 운영하며 아로마테라피스트로 10년 넘게 일했습니다. 초등학교 방학 특강, 대학 진로체험, 여성인력개발센터 16주 과정까지, 처음 해 보는 분들 눈높이에 맞춰 차근차근 설명하는 일을 오래 해 왔습니다.

지금은 (주)뉴니케 보험자산관리전문회사(GA)에서 보험설계사로 새 출발했습니다. 2026년 여름에는 요양보호사 자격을 취득하며 장기요양과 간병을 더 깊이 이해하게 되었습니다.

보험을 잘 아는 사람을 위한 상담이 아니라, 보험을 잘 모르는 고객님이 이해할 수 있는 상담을 하고 싶습니다. 이 책도 그런 마음으로 썼습니다.

상담할 때 지키는 세 가지

고객의 언어로

주계약, 특약, 면책기간, 감액기간… 어려운 말은 쉬운 말로 바꿔서 설명합니다.

'많이'보다 '제대로'

보험료를 많이 낸다고 좋은 보험이 아닙니다. 지금 소득과 가족 상황에 맞는지부터 봅니다.

가입보다 점검이 먼저

기존 보험에 좋은 보장이 있다면 바꿀 이유가 없습니다. 지금 가진 보험부터 함께 살펴봅니다.

책을 읽다가 궁금한 점이 생기면

보험증권 사진 한 장만 보내 주세요(주민번호·계좌번호는 가려 주세요). 부족한 보장과 겹치는 보장을 함께 살펴봐 드립니다.

전화	010-3112-3533
카카오톡 채널	pf.kakao.com/_AGxlFX
블로그	blog.naver.com/lake1448 (보험이 쉬워지는 시간)
상담 시간	평일 09:00~18:00 · 카톡 상담은 24시간 접수

카톡 상담 QR

차례

PART 1 · 보험 기초 다지기

01 보험증권 읽는 법과 보장분석
02 갱신형 vs 비갱신형, 무엇이 유리할까
03 계약 전 알릴의무 — 표준체·간편체·간편실손

PART 2 · 사망과 장해

04 사망의 범주와 사망보험금
05 통계로 보는 사망 위험 — 한국인은 무엇으로 사망하는가
06 상해·질병 후유장해와 지급률

PART 3 · 3대 질병 — 암·뇌·심장

07 CI보험 vs GI보험
08 암의 발생 원인과 통계
09 암의 검사·진단과 병기(TNM)
10 암 치료의 진화와 암보험 트렌드
11 수술의 분류 — 종수술 표 읽는 법
12 산정특례 제도
13 뇌혈관질환 — 진단·치료와 보장 범위
14 심장질환 — 보장 범위와 상병코드

PART 4 · 수술비

15 수술 트렌드의 변화와 수술비 담보의 종류
16 통계로 보는 주요 수술 — 건수·진료비·입원일수

PART 5 · 장기요양 · 치매 · 간병

17 공적 장기요양보험과 노인성 질환
18 장기요양 등급과 비용, 치매 척도(CDR)
19 장기요양 이용 현황, 요양병원과 요양원, 간병보험

PART 6 · 노후 준비 — 종신 · 연금 · 상속재원 · 변액

20 종신보험으로 준비하는 노후 — 종류, 연금전환, 사망보험금 유동화
21 노후자금과 연금 3층 보장
22 세제적격 연금 — 연금저축과 IRP 세액공제
23 상속재원 마련 — 수익자 지정, 상속세, 증여 활용
24 변액보험 — 구조, 최저보증, 비용과 주의점

PART 7 · 자동차보험 · 운전자보험

25 자동차보험의 주요 담보와 부상등급

26 운전자보험 — 사고 후 세 가지 책임과 12대 중과실

27 운전자보험 변천사 — 2009년부터 2024년까지

28 2026년의 변화 — 경찰조사 단계와 변호사 현물급부

PART 8 · 치아보험

29 치아보험 — 급여·비급여 구조와 가입 전 주의사항

30 치과 치료의 종류와 비용

PART 9 · 화재보험

31 주택화재보험과 실화책임법

PART 10 · 실손의료보험 1~5세대

32 의료실비 변천사 — 1세대부터 4세대까지

33 실손에서 보상하지 않는 사항

34 4세대 실손의 주요 특징 — 일반·유병자·노후

35 보험료 차등제와 구실손 vs 4세대 유불리

36 5세대 실손보험, 무엇이 달라지나

37 5세대 전환 손익 계산 — BEP로 판단하기

38 5세대 전환 평가 주요 포인트

PART 11 · 몰라서 못 받는 정부 지원제도

39 본인부담상한제와 재난적 의료비 지원

40 산정특례·노인장기요양·임플란트와 틀니 지원

41 보험금 청구 실전 가이드

부록 · 실무 자료 모음

부록 A 질병분류코드(KCD) 읽는 법과 실무 분류

부록 B 보험 실무 질병코드 요약표

부록 C 보험 용어 사전

부록 D 우리 가족 보장분석 워크시트

PART 1

보험 기초 다지기

보험은 '어떤 상품이냐'보다 '어떻게 설계되어 있느냐'가 중요합니다. 같은 이름의 암보험이라도 납입기간·보장기간·갱신 여부·담보 구성에 따라 실제 가치는 완전히 달라집니다. 이 파트에서는 모든 보험 점검의 출발점인 증권 읽는 법과 갱신 구조, 그리고 가입 단계에서 가장 많은 분쟁을 낳는 알릴의무를 다룹니다.

01 보험증권 읽는 법과 보장분석

02 갱신형 vs 비갱신형, 무엇이 유리할까

03 계약 전 알릴의무 — 표준체·간편체·간편실손

CHAPTER 01

보험증권 읽는 법과 보장분석

보험증권은 계약의 '설계도'입니다. 다섯 가지 항목만 읽을 줄 알아도 내 보험의 80%를 이해할 수 있습니다.

보험증권이란 무엇인가

보험증권은 **보험계약이 성립했다는 사실과 그 내용을 증명하는 문서**입니다. 상법은 보험계약이 성립하면 보험자(보험회사)가 지체 없이 보험증권을 작성해 보험계약자에게 교부하도록 정하고 있습니다. 증권에는 계약자·피보험자·수익자, 보험기간, 보험료와 납입 방법, 보장 내용과 보험금액 등 계약의 핵심이 압축되어 있습니다.

많은 사람이 보험증권을 '받고 나서 한 번도 열어보지 않는 서류'로 여깁니다. 하지만 보험금을 청구할 때, 보험을 리모델링할 때, 다른 보험과 중복 여부를 따질 때 가장 먼저 확인해야 하는 것이 바로 증권입니다. 약관이 '법전'이라면 증권은 '내 계약서'입니다. 약관은 수백 쪽이지만 증권은 몇 장에 불과하므로, 증권부터 읽는 습관을 들이는 것이 좋습니다.

■ 증권에 등장하는 세 사람

구분	의미	점검 포인트
계약자	보험회사와 계약을 맺고 보험료를 납입할 의무를 지는 사람. 계약 해지·변경 권한을 가집니다.	보험료를 실제로 누가 내는지와 일치하는지
피보험자	보험사고의 대상이 되는 사람. 이 사람이 아프거나 다치거나 사망하면 보험금이 지급됩니다.	가족 중 누구의 위험을 보장하는 계약인지
수익자	보험금을 받는 사람. 생존 보험금(진단비·수술비 등)과 사망 보험금의 수익자가 다를 수 있습니다.	사망수익자가 '법정상속인'으로 되어 있는지, 지정되어 있는지

계약자·피보험자·수익자를 누구로 정하느냐에 따라 **세금**이 달라진다는 점도 기억해 두세요. 예를 들어 남편이 계약자이자 피보험자이고 아내가 사망수익자인 종신보험에서 남편이 사망하면, 그 사망보험금은 상속재산으로 보아 상속세 과세 대상이 됩니다. 반면 아내가 계약자로서 실제 보험료를 내고 남편을 피보험자로 한 계약이라면, 아내가 받는 사망보험금은 상속세 과세 대상에서 벗어날 수 있습니다. 이 내용은 CHAPTER 23에서 더 자세히 다룹니다.

보험증권에서 반드시 확인할 5가지

① 상품 종류

종신·정기·건강·실손·운전자 등 어떤 성격의 보험인지. 생명보험사 상품인지 손해보험사 상품인지도 함께 봅니다.

② 납입기간·보장기간

몇 년(몇 세)까지 보험료를 내고, 몇 세까지 보장받는지. '20년납 100세 만기'처럼 표기됩니다.

③ 보장 내용과 범위

주계약과 특약별로 어떤 사고에 얼마가 나오는지. 진단비·수술비·입원비 등 담보 이름을 확인합니다.

④ 적절한 보험료

소득 대비 보험료 비중과, 갱신 시 오를 보험료까지 포함해 감당 가능한지 판단합니다.

⑤ 비례보상 중복 여부

실손·배상책임처럼 실제 손해만큼만 나누어 보상하는 담보는 여러 건 가입해도 더 받지 못합니다.

+ 갱신 여부

담보명 옆에 '갱신형'이라고 표시된 특약은 일정 주기마다 보험료가 다시 계산됩니다.

■ ① 상품 종류 — '이름'이 아니라 '구조'를 본다

보험 상품명은 마케팅 용어로 가득합니다. '든든', '플러스', '올인원', '무배당 ○○ 건강보험' 같은 이름만으로는 무엇을 보장하는지 알 수 없습니다. 증권에서는 상품명이 아니라 **주계약의 성격**을 확인해야 합니다. 주계약이 '일반사망'이면 종신보험 계열, '상해사망'이나 '질병사망'이면 손해보험의 건강·상해보험 계열일 가능성이 높습니다. 주계약은 보장이 작고 특약이 대부분인 '특약 중심 설계'라면, 특약의 만기와 갱신 여부를 꼼꼼히 보아야 합니다.

■ ② 납입기간과 보장기간 — 노후 보장 공백의 원인

보장기간이 60세·70세·80세로 끝나는 오래된 보험이 의외로 많습니다. 과거에는 평균수명이 지금보다 짧았기 때문에 80세 만기도 충분해 보였지만, 보험개발원의 제10회 경험생명표 기준 평균수명은 남성 86.3세, 여성 90.7세에 이릅니다. 질병과 수술이 가장 많이 발생하는 시기는 60대 이후인데, 바로 그 시기에 보장이 끝나 버리는 것입니다. 증권을 볼 때는 반드시 **"몇 세까지 보장되는가"**를 먼저 확인하세요.

납입기간도 중요합니다. 은퇴 이후까지 보험료를 내야 하는 구조라면, 소득이 끊긴 뒤 보험을 유지하지 못해 해지하는 일이 생깁니다. 일반적으로 **보험료 납입은 소득이 있는 기간 안에 끝내고, 보장은 최대한 길게** 가져가는 설계가 바람직합니다.

■ ③ 보장 내용과 범위 — 담보 이름 한 글자가 수천만 원을 가른다

'뇌졸중 진단비'와 '뇌혈관질환 진단비'는 비슷해 보이지만 보장 범위가 전혀 다릅니다. 뇌출혈만 보장하는 담보, 뇌졸중(뇌출혈+뇌경색)까지 보장하는 담보, 뇌혈관질환 전체를 보장하는 담보가 각각 존재하며, 실제 환자 분포를 보면 그 차이가 매우 큽니다(CHAPTER 13 참고). 암도 마찬가지입니다. '일반암', '유사암', '소액암', '고액암'의 정의에 따라 같은 진단을 받아도 받는 금액이 달라집니다.

■ ④ 적절한 보험료 — 얼마가 적당한가

보험료에 정답은 없지만, 일반적으로 **가구 월소득의 8~10% 안팎**을 보장성 보험료의 적정선으로 봅니다. 이보다 크게 높다면 중복·과잉 보장이 있는지, 저축성 보험이 섞여 있는지 살펴보아야 합니다. 반대로 지나치게 낮다면 핵심 위험(사망, 3대 질병, 실손)에 공백이 있을 수 있습니다. 여기서 중요한 것은 **현재 보험료뿐 아니라 갱신 후 보험료**까지 계산에 넣는 것입니다.

■ ⑤ 비례보상 담보의 중복 여부

보험금 지급 방식은 크게 두 가지입니다. 진단비·수술비·사망보험금처럼 약속한 금액을 그대로 주는 **정액보상**과, 실제 발생한 손해만큼만 주는 **실손(비례)보상**입니다. 정액보상은 여러 보험에 가입하면 각각 받을 수 있지만, 실손보상은 여러 건에 가입해도 실제 손해액을 넘어서 받을 수 없고 보험사들이 나누어 지급합니다.

보상 방식	대표 담보	중복 가입 시
정액보상	사망보험금, 암·뇌·심장 진단비, 수술비, 입원일당, 후유장해	가입한 만큼 각각 지급
비례보상	실손의료비, 일상생활배상책임, 화재 배상책임, 운전자보험 비용손해 담보 일부	실제 손해액 한도 내에서 보험사끼리 나누어 지급 → 중복 가입은 보험료 낭비

현장 팁 — 가장 흔한 중복 사례

일상생활배상책임 특약은 화재보험·운전자보험·자녀보험 등 여러 상품에 끼워져 있는 경우가 많습니다. 가족 중 한 명만 '가족형'으로 가입해도 함께 사는 가족 전체가 보장받는 경우가 많으므로, 가족 증권을 모두 모아 중복 여부를 확인하세요. 실손의료비도 회사 단체실손과 개인실손이 동시에 있다면 '개인실손 중지제도'를 활용해 보험료를 아낄 수 있습니다.

보장분석이 필요한 네 가지 신호

보장분석이란 가입한 모든 보험을 한자리에 모아 **위험별로 얼마씩 준비되어 있는지**를 정리하는 작업입니다. 다음 네 가지 중 하나라도 해당한다면 지금 바로 보장분석을 해 보는 것이 좋습니다.

1. 보험료는 내는데 보상을 제대로 못 받았다면

청구를 했는데 "약관상 해당 없음"이라는 답을 들은 경험이 있다면, 담보 구성이 실제 위험과 어긋나 있을 가능성이 큽니다.

2. 내 보장이 어떤지 모르겠다면

암 진단비가 얼마인지, 실손이 몇 세대인지 바로 답하지 못한다면 보장분석이 필요합니다.

3. 지인이나 전화로 가입했다면

관계나 권유로 가입한 보험은 내 필요보다 판매자의 상품 구성에 맞춰진 경우가 많습니다.

4. 가입한 지 3년 이상 지났다면

의료 환경과 상품은 빠르게 바뀝니다. 3년 전 최선이었던 설계가 지금은 공백일 수 있습니다.

■ 보장분석 5단계

1. 수집 가족 전원의 증권·가입내역 조회 › **2. 정리** 위험별(사망·암·뇌·심장·수술·입원·실손·배상) 금액 합산 › **3. 비교** 필요 보장액과 비교해 과부족 확인 › **4. 판단** 갱신·만기·중복·보험료 부담 평가 › **5. 조정** 추가·감액·유지·전환 결정

1단계에서는 생명보험협회·손해보험협회가 함께 운영하는 **'내보험다보여'**와 금융감독원 '파인'의 **'내보험찾아줌'**을 활용하면 가입 내역과 숨은 보험금(휴면보험금, 중도보험금 등)을 한 번에 확인할 수 있습니다. 2단계에서는 부록 D의 워크시트를 이용하세요. 같은 위험이라도 담보 정의가 다르면 따로 적어야 합니다(예: 뇌출혈 진단비와 뇌혈관질환 진단비를 합산하지 말 것).

■ 위험별 필요 보장액, 어떻게 정할까

위험	필요 보장액을 정하는 기준	일반적 참고 범위
사망	남은 가족의 생활비(3~5년분) + 부채 + 자녀 교육비 − 보유 자산	연소득의 3~5배 이상
암	치료 기간(1~2년) 소득 공백 + 비급여 치료비	연소득의 1~2배
뇌·심장	급성기 치료비 + 재활 기간 소득 공백 + 간병비	각 2,000~3,000만 원 이상
수술·입원	정액 담보로 실손의 자기부담금과 소득 손실 보완	질병수술비·종수술비 조합
실손	1인 1실손 원칙. 세대(1~5세대)와 보험료 부담 점검	—
배상책임	일상생활·화재·자동차 관련 배상	가족당 1건이면 충분한 경우가 많음

※ 참고 범위는 일반적인 설계 관행이며 가구의 소득·자산·부채·건강상태에 따라 달라집니다.

보험 리모델링 시 주의할 점

보장분석 결과 공백이 발견되었다고 해서 기존 보험을 깨고 새로 가입하는 것이 항상 답은 아닙니다. 오래된 보험에는 지금은 판매하지 않는 유리한 조건(높은 예정이율, 넓은 보장 정의, 자기부담금 없는 실손 등)이 숨어 있는 경우가 많기 때문입니다.

- **해지는 항상 마지막에.** 새 보험의 청약 승인과 보장 개시를 확인한 뒤 기존 보험을 정리합니다. 암보험은 보통 가입 후 90일의 면책기간이 있다는 점도 고려합니다.
- **나이와 병력.** 나이가 한 살 오를 때마다 보험료가 오르고, 그사이 생긴 병력은 새 보험 가입을 어렵게 만듭니다.
- **해지환급금 손실.** 저해지·무해지 상품은 납입기간 중 해지하면 환급금이 거의 없습니다.
- **부족분은 '추가'로 해결할 수 있는지 먼저 검토.** 기존 보험은 그대로 두고 부족한 담보만 단독 상품으로 보완하는 방법이 대개 더 효율적입니다.

Q. 보험증권을 잃어버렸어요. 어떻게 확인하나요?

A. 보험사 고객센터나 모바일 앱에서 증권을 재발급받을 수 있습니다. 가입한 보험사가 기억나지 않는다면 '내보험다보여'에서 본인인증 후 전체 가입 내역을 조회하세요.

Q. 보장분석을 받으면 무조건 보험을 바꾸라고 하지 않나요?

A. 좋은 보장분석은 '바꿀 것'보다 '지킬 것'을 먼저 알려 줍니다. 분석 결과를 받으면 ① 유지 권유 계약 ② 보완이 필요한 담보 ③ 해지·감액 권유 사유를 각각 근거와 함께 설명해 달라고 요청하세요.

Q. 가족 보험도 한꺼번에 봐야 하나요?

A. 네. 배상책임·실손처럼 가족 단위로 중복되는 담보가 있고, 가장의 사망보장은 가족 전체의 생활비와 연결되기 때문에 가구 단위로 보는 것이 정확합니다.

CHAPTER 01 핵심 요약

- 증권의 5가지: **상품 종류, 납입·보장기간, 보장 내용, 보험료, 비례보상 중복**(+갱신 여부)
- 보장기간이 80세 이하인 오래된 보험은 노후 보장 공백을 의심하세요.
- 정액보상은 중복 수령, 실손·배상책임은 중복 가입해도 더 받지 못합니다.
- 리모델링은 '새 보험 승인 → 기존 보험 정리' 순서를 반드시 지키세요.

■ 점검 체크리스트

- [ ] 가족 전원의 보험 가입 내역을 한 번에 조회했다.
- [ ] 각 계약의 계약자·피보험자·수익자를 확인했다.
- [ ] 보장이 80세 이전에 끝나는 계약이 있는지 확인했다.
- [ ] 갱신형 특약의 갱신 주기와 최근 갱신 보험료를 확인했다.
- [ ] 실손·일상생활배상책임의 중복 가입 여부를 확인했다.
- [ ] 월 보장성 보험료가 가구 소득의 몇 %인지 계산했다.

CHAPTER 02

갱신형 vs 비갱신형, 무엇이 유리할까

"처음엔 싸다"와 "끝까지 같다"의 차이. 갱신 구조를 이해하지 못하면 노후에 보험을 지킬 수 없습니다.

두 방식의 기본 구조

비갱신형은 가입할 때 정한 보험료를 납입기간 동안 똑같이 내는 방식입니다. 20년납이라면 20년 동안 같은 금액을 내고, 그 뒤로는 보험료 없이 만기까지 보장을 받습니다. **갱신형**은 10년·20년 등 일정 주기마다 그 시점의 나이와 손해율을 반영해 보험료를 다시 계산하는 방식입니다. 보장이 유지되는 동안에는 계속 보험료를 내야 합니다.

비갱신형

- 납입기간 내 보험료가 동일 → 계획적인 재무 설계 가능
- 정해진 보험료로 장기간 보장 → 젊을수록 유리
- 나이가 들수록 위험률이 계속 오르는 보장(암·뇌·심장 등)은 비갱신이 유리
- 초기 보험료는 갱신형보다 높음

갱신형

- 초기 보험료가 저렴
- 갱신 시점에 보험사의 손해율이 높아지면 보험료 인상 가능성 → 갱신 주기가 짧은 상품은 피하는 것이 좋음
- 만기까지 보험료를 내야 하므로 소득 없는 노후에 부담
- 갱신 주기가 긴 상품(20년·30년)은 생애주기에 맞춰 설계·활용 가능

보험료 흐름 비교 — 그림으로 보기

아래는 30세에 같은 보장을 가입했다고 가정할 때 연령대별 월 보험료 흐름을 단순화한 예시입니다. 비갱신형(20년납)은 30대와 40대에 일정한 보험료를 내고 50세 이후에는 납입이 끝납니다. 갱신형은 30대에 매우 저렴하지만, 갱신될 때마다 보험료가 계단식으로 올라 70~80대에는 처음의 수십 배에 이르기도 합니다.



※ 이해를 돕기 위한 단순 예시이며 실제 보험료는 상품·나이·성별·손해율에 따라 다릅니다.

■ 누적 납입액으로 비교하면

위 예시를 그대로 누적해 보면 결과가 흥미롭습니다. 비갱신형은 23,000원 × 240개월 = **약 552만 원**으로 끝납니다. 갱신형은 30~50대에 낸 금액은 약 126만 원으로 적지만, 60대 150만 원, 70대 402만 원, 80대 768만 원이 더해져 80대 말까지 유지하면 **약 1,446만 원**에 달합니다. 게다가 갱신형 보험료가 가장 비싸지는 시기는 소득이 없는 노후입니다. 실제로 많은 사람이 70대에 오른 갱신 보험료를 감당하지 못해 해지하고, 가장 보험이 필요한 시기에 보장을 잃습니다.

그렇다면 갱신형은 무조건 나쁜가?

그렇지 않습니다. 갱신형이 합리적인 경우도 분명히 있습니다.

상황	갱신형이 유리한 이유
지금 당장 보험료 여력이 적을 때	사회초년생·자녀 양육기처럼 현금흐름이 빠듯할 때 큰 보장을 저렴하게 확보할 수 있습니다.
특정 기간에만 필요한 보장	대출 상환 기간, 자녀 독립 전까지처럼 기간이 정해진 위험은 정기·갱신형으로 대비하는 것이 효율적입니다.
의료 기술 변화가 빠른 담보	표적항암·면역항암·로봇수술처럼 치료 기술이 바뀌는 영역은 갱신형으로 최신 정의를 따라가는 상품이 있습니다.
고령 가입	60대 이후 가입은 비갱신형 보험료가 매우 비싸므로 갱신형이 유일한 현실적 선택일 수 있습니다.
실손의료보험	현재 판매되는 실손은 구조적으로 1년 갱신(재가입 주기 5년)만 존재합니다.

현명한 조합 전략

원칙: '평생 필요한 핵심 보장'은 비갱신, '기간 한정·보조 보장'은 갱신

- **비갱신 추천**: 암·뇌혈관·허혈성심장 진단비, 사망보장의 기본 금액, 후유장해 기본 금액
- **갱신 허용**: 고액 치료비 담보, 표적·면역항암 등 신의료기술 담보, 입원일당, 기간 한정 사망보장
- **갱신 주기**: 같은 갱신형이라면 3년·5년보다 **20년·30년 갱신**을 선택해 인상 충격 횟수를 줄입니다.

■ 갱신 보험료 확인하는 법

1. 증권의 담보 목록에서 '(갱신형)', '갱신 주기 ◯년' 표시를 찾습니다.
2. 보험사가 갱신 시점 전에 보내는 '갱신 안내장'에서 새 보험료를 확인합니다.

3. 가입 설계서에 있는 '갱신 보험료 예시표'를 다시 봅니다. 예시표는 현재 위험률 기준이므로 실제 인상폭은 더 클 수 있습니다.
4. 최근 1~2회 갱신 인상률을 기록해 두고, 앞으로의 인상률을 보수적으로 가정해 노후 부담을 계산합니다.

사례 — 52세 A씨의 갱신 보험료 점검

A씨는 38세에 '3대 질병 보장 패키지'를 월 4만 원대에 가입했습니다. 보장분석을 해 보니 주계약은 소액이고, 암·뇌·심장 진단비 특약이 모두 **10년 갱신형**이었습니다. 48세 첫 갱신에서 보험료는 7만 원대로 올랐고, 설계서의 예시표대로라면 58세에는 13만 원, 68세에는 25만 원을 넘깁니다. A씨는 같은 보장을 지금 비갱신형으로 다시 짜는 경우와 갱신형을 유지하는 경우의 총 납입액을 비교한 뒤, **건강상태가 양호한 지금** 핵심 진단비를 비갱신형으로 새로 확보하고 기존 갱신 특약은 감액하는 쪽을 택했습니다.

Q. 갱신 보험료가 많이 올랐는데 갱신을 거절할 수 있나요?

A. 갱신을 거절하면 해당 특약의 보장이 종료됩니다. 대부분의 상품은 '감액 갱신'(가입금액을 줄여 갱신)이 가능하므로, 해지보다 감액을 먼저 검토하세요.

Q. 갱신 때 병력이 있으면 갱신이 거절되나요?

A. 갱신형은 계약 시 정한 갱신 기간 동안에는 건강 상태를 다시 심사하지 않고 자동 갱신되는 것이 원칙입니다. 다만 최대 갱신 가능 나이(예: 100세)와 상품 판매 중지 시의 처리 방식은 약관을 확인해야 합니다.

CHAPTER 02 핵심 요약

- 비갱신형: 보험료 고정, 납입 후 보험료 없음 → **평생 필요한 핵심 보장**에 적합
- 갱신형: 초기 저렴하지만 노후에 급등 → 기간 한정·보조 보장에 활용, **긴 갱신 주기** 선택
- 총 납입액 기준으로 비교하면 장기 유지 시 갱신형이 더 비싼 경우가 많습니다.

■ 점검 체크리스트

- [ ] 내 보험의 갱신형 특약 목록과 갱신 주기를 정리했다.
- [ ] 최근 갱신 시 인상률을 확인했다.
- [ ] 70세 이후 예상 보험료가 노후 소득으로 감당 가능한지 계산했다.
- [ ] 3대 진단비의 기본 금액이 비갱신형으로 확보되어 있는지 확인했다.

CHAPTER 03

계약 전 알릴의무 — 표준체·간편체·간편실손

보험금 분쟁의 상당수는 '가입할 때 알리지 않은 병력'에서 시작됩니다. 질문의 기간과 용어를 정확히 이해하는 것이 최선의 예방책입니다.

알릴의무란

보험계약자와 피보험자는 청약할 때 보험회사가 서면(청약서)으로 묻는 중요한 사항에 대해 **사실대로 알려야 할 의무**가 있습니다. 이를 '계약 전 알릴의무(고지의무)'라고 합니다. 보험사는 이 답변을 바탕으로 가입을 승인할지, 어떤 조건(부담보·할증)으로 받을지를 결정합니다.

알릴의무를 위반하면 보험사는 일정 기간 안에 계약을 해지할 수 있고, 위반 사실과 보험사고 사이에 인과관계가 있으면 보험금을 지급하지 않을 수 있습니다. 반대로 **질문받지 않은 사항은 알리지 않아도 됩니다.** 따라서 핵심은 '질문을 정확히 읽고, 질문한 기간과 행위에 해당하는 사실을 빠짐없이 답하는 것'입니다.

알릴의무 위반의 효과(일반적인 약관 기준)

- 보험사는 위반 사실을 안 날부터 1개월 이내, 계약 체결일부터 3년 이내에 계약을 해지할 수 있습니다.
- 보장개시일부터 보험금 지급 사유 없이 2년(진단계약은 1년)이 지나면 해지할 수 없는 것이 원칙입니다.
- 해지하더라도 위반 사실이 보험금 지급 사유 발생에 영향을 미치지 않았음이 증명되면 보험금은 지급됩니다.
- 설계사가 고지를 방해하거나 사실대로 알리지 않도록 권유한 경우 등에는 보험사가 해지할 수 없습니다.

표준체(일반심사) 알릴의무 질문

건강한 사람이 가입하는 일반 상품의 질문은 범위가 넓고 기간이 깁니다. 대표적인 문항은 다음과 같습니다.

기간	질문 내용
3개월	의사로부터 진찰 또는 검사(건강검진 포함)를 통해 **질병확정진단, 질병의심소견, 치료, 입원, 수술, 투약**을 받은 사실
3개월	마약을 사용하거나 혈압강하제, 신경안정제, 수면제, 각성제(흥분제), 진통제 등 약물을 상시 복용한 사실
1년	의사로부터 진찰 또는 검사를 받고 그 결과 **추가검사(재검사)**를 받은 사실
5년	입원, 수술(제왕절개 포함), 계속하여 7일 이상 치료, 계속하여 30일 이상 투약

기간	질문 내용
5년	11대 질병(암, 백혈병, 고혈압, 협심증, 심근경색, 심장판막증, 간경화증, 뇌졸중증, 에이즈 및 HIV 보균, 당뇨병, 직장 또는 항문 관련 질환※)으로 확정진단·치료·입원·수술·투약

※ 직장·항문 관련 질환은 실손의료보험 가입 시에 질문합니다. 문항은 상품·보험사·가입 시기별로 다를 수 있습니다.

간편체(유병자) 알릴의무 — '3·N·5' 구조

고혈압·당뇨 같은 만성질환이 있거나 과거 병력이 있는 사람을 위해 질문을 줄인 상품이 **간편심사(유병자) 보험**입니다. 질문이 단순한 대신 보험료는 표준체보다 비쌉니다. 과거에는 '3·2·5' 구조가 일반적이었지만, 최근에는 두 번째·세 번째 질문의 기간(N년)을 1~10년 등으로 다양화한 '3·N·5' 구조가 많아졌습니다.

(구) 간편체 — 3·2·5

- **3개월** 이내: 입원필요소견, 수술필요소견, 추가검사(재검사)필요소견, **질병확정진단, 질병의심소견**
- **2년** 이내: 질병·상해로 입원 또는 수술(제왕절개 포함)
- **5년** 이내: 암으로 진단, 입원 또는 수술

(신) 간편체 — 3·N·5

- **3개월** 이내: 위와 동일
- **N년** 이내: 질병·상해로 입원 또는 수술(제왕절개 포함)
- **N년** 이내: 중대질병(암, 뇌졸중, 심근경색, 협심증, 심장판막증, 간경화, 만성신장질환, 백혈병, 에이즈, 루게릭, 파킨슨 등)으로 진단·입원·수술

N이 짧을수록 가입 문턱이 낮고 보험료는 비쌉니다. 예를 들어 1년 전 입원 이력이 있는 사람은 '3·2·5' 상품에는 가입할 수 없지만 '3·1·5' 상품에는 가입할 수 있습니다. 반대로 최근 5년간 입원·수술 이력이 전혀 없다면 '3·5·5'처럼 N이 긴 상품을 골라 보험료를 낮출 수 있습니다. 같은 사람이라도 **어떤 N을 고르느냐에 따라 보험료 차이가 꽤 크므로** 자신의 이력에 맞는 가장 긴 N을 찾는 것이 요령입니다.

간편실손 알릴의무

유병력자 실손의료보험(간편실손)은 일반 실손에 가입하기 어려운 사람을 위한 상품입니다. 질문은 다음과 같습니다.

기간	질문 내용
3개월	의사로부터 진찰 또는 검사를 통해 입원필요소견, 수술필요소견, **치료(필요소견)**, 추가검사(재검사)필요소견, 질병확정진단, 질병의심소견을 받은 사실
2년	의사로부터 진찰 또는 검사를 통해 입원, 수술(제왕절개 포함) 또는 **계속하여 7일 이상 치료**를 받은 사실
5년	암으로 진단받거나 암으로 입원 또는 수술받은 사실

헷갈리는 용어 정확히 알기

알릴의무 분쟁의 상당수는 용어를 오해한 데서 생깁니다. 약관에서 정의하는 의미는 다음과 같습니다.

용어	의미
필요소견	의사가 진단서·소견서를 발급하거나, 진료기록부 등에 기재하고 이를 환자에게 설명·권유한 경우
추가검사(재검사)	검사 결과 이상 소견이 확인되어 보다 정확한 진단을 위해 시행한 검사. 병증에 대한 치료 필요 없이 유지되는 상태에서 하는 정기검사나 추적관찰은 포함하지 않습니다.
질병의심소견	의사가 진단서나 소견서, 진료의뢰서 등 서면(전자문서 포함)으로 교부한 경우
투약	의사가 환자에게 약을 처방하는 행위. **실제로 약을 구입하지 않았더라도** 처방받았다면 알려야 합니다.
치료(간편실손)	단순 처방을 위해 병원에서 진료받는 경우는 포함하지 않습니다.
계속하여	같은 원인으로 치료 시작 후 완료일까지 실제 치료받은 일수. 날짜가 띄엄띄엄 있어도 같은 질병이면 합산될 수 있습니다.

■ 자주 틀리는 다섯 가지 상황

건강검진 결과 '재검 요망'

건강검진에서 이상 소견으로 재검사를 받았다면 1년 이내 '추가검사' 질문에 해당할 수 있습니다. 재검 결과 '정상'이었더라도 사실대로 알리고 결과지를 함께 제출하는 것이 안전합니다.

처방받고 약을 안 먹었다

투약은 '처방' 기준입니다. 약국에서 받지 않았더라도 처방 기록이 있으면 해당합니다.

감기로 7일 넘게 통원

같은 원인으로 7일 이상 통원했다면 '계속하여 7일 이상 치료'에 해당할 수 있습니다. 횟수가 아니라 실제 치료일수로 봅니다.

내시경 중 용종 제거

위·대장 내시경 중 용종을 떼어 낸 것은 약관상 '수술'로 볼 수 있습니다. 5년 이내 수술 질문에 해당하는지 확인하세요.

한의원 치료

한의사도 '의사'에 포함됩니다. 한의원에서 7일 이상 침 치료를 받았거나 한약을 처방받았다면 해당 여부를 확인하세요.

설계사에게 말로만 알림

설계사에게 구두로 말한 것만으로는 알린 것으로 인정되지 않는 것이 원칙입니다. 반드시 청약서에 기재하세요.

알릴 사항이 있을 때의 선택지

표준체 청약	심사 결과	거절·부담보가 과도하면	최종 선택
병력을 정확히 고지	정상 승인 / 부담보 / 할증 / 거절	간편체(3·N·5) 비교	보장 범위와 보험료를 함께 비교

부담보는 특정 부위나 질병을 일정 기간(또는 전 기간) 보장에서 제외하는 조건입니다. 예를 들어 '위 부위 5년 부담보'라면 5년 동안 위와 관련된 질병은 보장하지 않고 나머지는 정상 보장합니다. 병력이 하나뿐이고 가벼운 경우에는 간편체보다 **표준체+부담보**가 보험료와 보장 면에서 유리할 때가 많습니다.

Q. 5년 전에 받은 수술을 알리지 않았는데, 지금이라도 할 수 있는 게 있나요?

A. 보험사에 '추가 고지'를 하는 방법이 있습니다. 보험사는 이를 반영해 계약을 유지하거나 조건을 변경합니다. 보험금 청구 시점에 발견되는 것보다 먼저 정정하는 편이 분쟁을 줄입니다.

Q. 진료 기록은 보험사가 다 알 수 있나요?

A. 보험사는 청약 단계에서 개인의 진료 기록 전체를 조회할 권한이 없습니다. 그러나 보험금을 청구하면 동의를 받아 진료 기록을 확인하므로, 그때 미고지 사실이 드러나는 경우가 많습니다.

Q. 간편보험에 가입한 뒤 건강해지면 어떻게 하나요?

A. 일정 기간 무사고이면 표준체로 전환하거나 보험료를 할인해 주는 '건강고지 전환' 제도를 운영하는 상품이 있습니다. 가입 시 해당 조건이 있는지 확인하세요.

CHAPTER 03 핵심 요약

- 질문받은 사항만, **질문한 기간 안의 사실**을 정확하게 청약서에 기재합니다.
- 표준체 = 3개월·1년·5년 질문 / 간편체 = 3·N·5 / 간편실손 = 3개월·2년·5년
- '투약'은 처방 기준, '추가검사'는 이상 소견 후 재검사, '필요소견'은 의사의 설명·권유가 기준
- 병력이 가벼우면 **표준체+부담보**가 간편체보다 유리할 수 있습니다.

■ 점검 체크리스트

- [ ] 최근 5년간 입원·수술·7일 이상 치료·30일 이상 투약 이력을 날짜별로 정리했다.
- [ ] 최근 1년간 건강검진 재검사 이력을 확인했다.
- [ ] 최근 3개월 내 진료·처방 내역을 확인했다(건강보험 앱 '진료 내역' 활용).
- [ ] 청약서의 모든 질문에 직접 답하고 서명했다.

PART 2

사망과 장해

사망보장은 '내가 없을 때 가족이 지금의 삶을 이어갈 수 있는가'에 대한 대답이고, 장해보장은 '살아 있지만 예전처럼 일할 수 없을 때'에 대한 대답입니다. 두 위험은 확률은 낮아 보여도 한 번 닥치면 가계 전체를 흔듭니다.

04 사망의 범주와 사망보험금 — 생명보험과 손해보험의 차이

05 통계로 보는 사망 위험 — 한국인은 무엇으로 사망하는가

06 상해·질병 후유장해와 지급률

CHAPTER 04

사망의 범주와 사망보험금

같은 '사망'이라도 보험에서는 원인에 따라 네 가지로 나뉩니다. 내 사망보장이 어느 범주까지 덮는지부터 확인하세요.

보험이 사망을 나누는 방식

보험에서 사망은 원인에 따라 **일반사망 ⊃ 질병사망 + 재해사망 ⊃ 상해사망**의 관계로 나뉩니다. 가장 넓은 개념이 일반사망이고, 그 안에 병으로 인한 사망(질병사망)과 외부 사고로 인한 사망(재해·상해사망)이 들어 있습니다.

구분	정의	주로 판매하는 곳
일반사망	원인을 묻지 않는 모든 사망. 다만 책임개시일부터 2년 이내의 고의적 자살 등 약관상 면책 사유는 제외	생명보험사 종신·정기보험 주계약
질병사망	질병을 직접적인 원인으로 한 사망	손해보험사 건강보험 특약
재해사망	우발적인 외래의 사고(재해분류표에 따른 사고, 일부 감염병 포함)로 인한 사망	생명보험사 특약
상해사망	급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체에 입은 상해로 인한 사망	손해보험사 기본계약

재해와 상해는 비슷하지만 표현이 다릅니다. 재해는 '우발적인 외래의 사고'로, 상해는 '급격하고도 우연한 외래의 사고'로 정의합니다. 실무에서는 대부분 같은 사고가 양쪽에 해당하지만, 재해는 재해분류표에 열거된 사고와 일부 법정 감염병까지 포함하는 등 세부 범위가 다를 수 있습니다.

핵심 — 2년 이내 자살과 일반사망

일반사망 보장은 책임개시일부터 2년이 지난 뒤의 자살에 대해서는 사망보험금을 지급하는 것이 원칙입니다(재해사망보험금이 아닌 일반사망보험금). 또한 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서의 자살은 기간과 관계없이 보장됩니다. 고의적 자살이 사망원인 5위(2023년)라는 통계를 고려하면, 이 조항은 결코 작은 차이가 아닙니다.

생명보험사 vs 손해보험사 사망보장 비교

사망보장을 준비할 때 가장 많이 받는 질문이 "종신보험이 꼭 필요한가, 손해보험의 질병사망·상해사망으로 충분한가"입니다. 두 상품의 구조적 차이를 먼저 비교해 보겠습니다.

생명보험사	구분	손해보험사
주계약(주보험)	**담보명**	기본계약
일반사망	**보장**	상해사망
종신 또는 정기	**보장기간**	설정한 보험기간(예: 80·90·100세)
2년 이내 자살을 제외한 모든 사망	**보장내용**	급격하고 우연한 외래의 사고로 인한 사망
재해사망	**추가사망**	질병사망
기간이 지날수록 증가	**해약환급금**	증가 후 만기 시점에 '0'에 가까워짐
가능	**연금전환**	불가능

■ 손해보험의 '질병사망 + 상해사망'이 일반사망을 대신할 수 있을까

숫자만 보면 질병사망과 상해사망을 합치면 거의 모든 사망을 덮을 수 있을 것 같습니다. 하지만 세 가지 함정이 있습니다.

1. **보장기간의 한계.** 손해보험의 질병사망 특약은 80세 또는 90세 만기가 많고, 고령 구간은 가입 한도가 낮습니다. 사망이 실제로 집중되는 80대 이후에는 보장이 끝나 있을 수 있습니다.
2. **원인 판정의 문제.** 사망원인이 '불명'이거나 질병과 사고가 겹친 경우(예: 지병이 있는 사람이 넘어져 사망) 어느 담보로 지급할지 다툼이 생깁니다. 일반사망은 원인을 묻지 않으므로 이런 분쟁이 없습니다.
3. **자산으로서의 기능.** 종신보험은 해약환급금이 쌓이고 연금으로 전환할 수 있어 '보장 + 자산'의 기능을 하지만, 손해보험 사망담보는 순수 보장형입니다.

반대로 손해보험 사망담보는 같은 금액 대비 보험료가 훨씬 저렴합니다. 따라서 **"가족의 생활비를 책임지는 기간에는 저렴한 정기·손해보험 사망담보로 큰 금액을, 평생 필요한 최소 금액(장례비·상속세 재원 등)은 종신보험으로"** 나누어 준비하는 방식이 많이 쓰입니다.

연령대별 사망자 수로 본 위험의 크기

통계청 자료를 보면 사망은 고령으로 갈수록 급격히 늘어납니다. 남성은 80대(약 6.3만 명)와 70대(약 4.6만 명), 60대(약 3.5만 명)에 사망이 집중되고, 여성은 80대(약 6.9만 명)와 90세 이상(약 4.5만 명)에 집중됩니다. 주목할 부분은 **남성의 50~60대 사망자 수가 같은 연령대 여성의 약 2.5배**라는 점입니다. 가계를 책임지는 시기의 남성 가장에게 사망보장이 특히 중요한 이유입니다.

연령대	남자 사망자(천 명)	여자 사망자(천 명)	남/여 배수
90세 이상	16.4	44.8	0.4
80~89세	63.2	69.4	0.9

연령대	남자 사망자(천 명)	여자 사망자(천 명)	남/여 배수
70~79세	46.0	24.6	1.9
60~69세	**35.1**	**13.5**	**2.6**
50~59세	**18.4**	**7.4**	**2.5**
40~49세	7.1	3.7	1.9
30~39세	2.9	1.6	1.8
20~29세	1.6	1.0	1.6
10~19세	0.4	0.3	1.3
1~9세	0.2	0.1	2.0
0세	0.3	0.3	1.0

자료: 통계청(2024 발표 자료 기준). 사망자 수는 천 명 단위 반올림.

경제적 가장이 부재하면 얼마가 필요할까

사망보장 금액을 정하는 가장 현실적인 방법은 "가장이 없어도 가족이 생활을 정리하고 새 방식에 적응할 시간"을 돈으로 환산하는 것입니다. 일반적으로 **3년치 생활비에 부채를 더한 금액**을 최소 기준으로 봅니다.

① 3년치 생활비

한 가구당 평균 월 생활비(소비지출+비소비지출) 약 **390만 원**

390만 원 × 36개월 = **약 1억 4,040만 원**

② 가구당 평균 부채

한 가구당 평균 부채 **약 9,128만 원**

(주택담보대출, 신용대출, 임대보증금 등 포함)

① 1억 4,040만 원 + ② 9,128만 원 = 최소 약 2.3억 원

자료: 통계청·한국은행·금융감독원 「2024년 가계금융복지조사」(2024년 3월 말 기준). 평균값이므로 가구별로 직접 계산해야 합니다.

여기에 자녀 교육비(특히 대학 등록금), 배우자의 노후 준비 공백, 장례비(평균 1,000~1,500만 원)까지 더하면 실제 필요 금액은 더 커집니다. 반면 이미 보유한 금융자산, 국민연금 유족연금, 퇴직금 등은 차감할 수 있습니다.

■ 우리 집 사망보장 필요액 계산표

항목	금액(만 원)
A. 월 생활비 × 36개월(또는 막내 자녀 독립까지 개월 수)	
B. 주택담보대출·신용대출 등 부채 잔액	

항목	금액(만 원)
C. 자녀 교육비(대학까지)	
D. 장례비 및 정리 비용	
E. 필요자금 합계 (A+B+C+D)	
F. 금융자산(예금·투자, 즉시 현금화 가능분)	
G. 유족연금·퇴직금 등 예상 수령액	
H. 이미 가입한 사망보험금 합계	
추가 필요 사망보장 = E − (F + G + H)	

종신보험의 다섯 가지 활용법

보장자산 마련

가장 부재 시 가족 생활비·부채 상환 재원. 종신보험의 본래 목적입니다.

연금재원 활용

자녀 독립 후 사망보장 필요가 줄면 적립금을 연금으로 전환해 노후 소득으로 활용합니다.

상속재원 마련

부동산 위주 자산가의 상속세 납부 재원. 현금이 없어 부동산을 급매하는 일을 막습니다.

목돈 마련

납입 완료 후 해약환급금이 납입보험료를 넘어서는 시점부터는 비상자금 역할을 합니다(상품별 상이).

금융자산 절세

요건을 갖춘 장기 보험차익 비과세, 계약자·수익자 설계를 통한 상속세 절감에 활용됩니다.

더 알아보기

노후의 연금전환·사망보험금 유동화는 CHAPTER 20, 상속세와 수익자 설계는 CHAPTER 23에서 자세히 다룹니다.

주의할 점

종신보험은 저축 상품이 아닙니다. 조기 해지 시 원금 손실이 크므로 '끝까지 유지할 수 있는 보험료'로 설계해야 합니다.

Q. 종신보험과 정기보험 중 무엇이 나은가요?

A. 목적에 따라 다릅니다. 자녀가 독립할 때까지처럼 '기간이 정해진 책임'에는 정기보험이 같은 금액을 훨씬 저렴하게 보장합니다. 상속·장례비처럼 '언젠가 반드시 필요한 돈'은 종신보험이 적합합니다. 많은 가정이 두 가지를 섞어 씁니다.

Q. 싱글이거나 부양가족이 없으면 사망보장이 필요 없나요?

A. 부양가족이 없다면 큰 사망보장은 우선순위가 낮습니다. 대신 장해·3대 질병·실손 등 '살아서 받는 보장'에 집중하는 것이 합리적입니다. 다만 부채가 있거나 부모를 부양한다면 그 금액만큼은 준비하세요.

Q. 재해사망과 상해사망 보험금을 둘 다 받을 수 있나요?

A. 정액보상이므로 생명보험의 재해사망 특약과 손해보험의 상해사망 담보에 모두 가입했다면, 같은 사고라도 각각의 지급 조건을 충족하면 모두 받을 수 있습니다. 일반사망보험금이 있다면 그것도 별도로 지급됩니다.

Q. 사망원인이 '불상'으로 나오면 어떻게 되나요?

A. 일반사망 담보는 원인을 묻지 않으므로 그대로 지급됩니다. 반면 상해(재해)사망 담보는 외래의 사고였다는 점을 청구하는 쪽에서 입증해야 하는 경우가 많아, 부검 결과나 사고 경위 자료가 중요해집니다.

사례 — 질병인가, 사고인가

지병으로 고혈압 약을 먹던 60대 P씨가 계단에서 넘어져 사망했습니다. 유족은 손해보험의 상해사망보험금을 청구했지만, 보험사는 "고혈압으로 인한 실신이 먼저였다면 질병사망"이라며 지급을 미뤘습니다. P씨에게 질병사망 담보가 있었다면 어느 쪽으로 판정되든 보험금을 받을 수 있었고, 생명보험 일반사망 담보가 있었다면 다툼 자체가 없었을 것입니다. 사망보장을 손해보험 담보로만 구성할 때는 **질병사망과 상해사망의 금액을 비슷하게 맞춰 두는 것**이 분쟁을 줄이는 방법입니다.

CHAPTER 04 핵심 요약

- 일반사망(가장 넓음) ⊃ 질병사망 + 재해·상해사망
- 생보 종신 = 원인 무관·평생 보장·환급금 증가 / 손보 = 저렴·기간 한정·원인별 보장
- 최소 사망보장 = **3년치 생활비 + 부채**(평균 약 2.3억 원)
- 책임 기간에는 정기·손보 담보로 크게, 평생 필요한 금액은 종신으로

CHAPTER 05

통계로 보는 사망 위험 — 한국인은 무엇으로 사망하는가

보험 설계는 '막연한 불안'이 아니라 '확률'에 근거해야 합니다. 사망원인 통계는 어떤 보장을 먼저 준비해야 하는지 알려 주는 가장 객관적인 지도입니다.

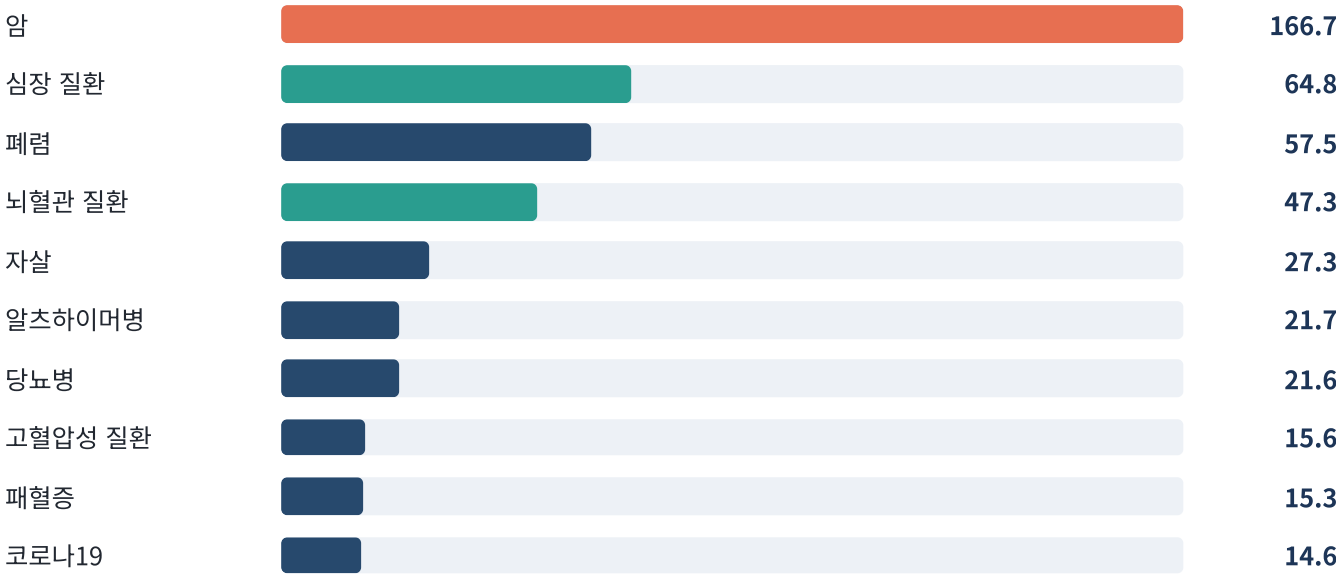
2023년 사망원인 순위 TOP 10

통계청 「2023년 사망원인통계」(2024년 발표)에 따르면 인구 10만 명당 사망률 기준 1위는 압도적으로 암(악성신생물)입니다. 2위 심장질환, 4위 뇌혈관질환까지 합하면 이른바 **3대 질병이 전체 사망의 약 40%**를 차지합니다.

순위	사망원인	사망률(10만 명당)	2022년 대비 순위
1	**악성신생물(암)**	166.7	-
2	**심장 질환**	64.8	-
3	폐렴	57.5	▲1
4	**뇌혈관 질환**	47.3	▲1
5	고의적 자해(자살)	27.3	▲1
6	알츠하이머병	21.7	▲1
7	당뇨병	21.6	▲1
8	고혈압성 질환	15.6	▲1
9	패혈증	15.3	▲1
10	코로나19	14.6	▼7

자료: 통계청 「2023년 사망원인통계」. 2022년 3위였던 코로나19가 10위로 내려가면서 4~9위가 한 계단씩 올랐습니다.

■ 막대그래프로 보는 사망률 격차



40년 추이가 말해 주는 것

1983년부터 2023년까지의 사망률 추이를 보면 보험 설계에 중요한 흐름 네 가지가 보입니다.

① 암 — 꾸준한 상승

1983년 10만 명당 70명대였던 암 사망률은 40년 동안 거의 쉬지 않고 올라 2023년 166.7명이 되었습니다. 고령화가 진행될수록 이 추세는 이어질 가능성이 높습니다.

② 심장질환 — 2000년대 이후 재상승

1990~2000년대 40명 안팎에서 정체했던 심장질환 사망률은 2000년대 중반부터 다시 올라 60명대에 도달했습니다. 서구화된 식습관과 고령화의 영향입니다.

③ 폐렴 — 가장 가파른 증가

2000년대 초반 10명 미만이던 폐렴 사망률은 2023년 57.5명으로 급증해 3위가 되었습니다. 고령자의 면역력 저하와 연관된 대표적 '노인성 사망원인'입니다.

④ 뇌혈관질환 — 사망은 감소, 생존은 증가

1990년대 중반 80명대로 1위였던 뇌혈관질환 사망률은 47.3명으로 크게 줄었습니다. 그러나 이는 '덜 걸린다'가 아니라 '살아남는 사람이 늘었다'는 뜻입니다. 생존 후 후유장해와 간병 위험이 커진 것입니다.

보험 설계에 주는 시사점

사망률이 낮아진 질병일수록 **'생존 후 비용'**을 준비해야 합니다. 뇌혈관질환은 진단비만큼이나 재활치료비·간병비·후유장해 보장이 중요하고, 암은 진단 이후 수년간 이어지는 치료비(표적·면역항암, 방사선) 보장이 중요해졌습니다. 반대로 사망률이 오르는 폐렴·알츠하이머는 고령기 입원·간병 보장과 연결됩니다.

성별로 다른 사망원인

남녀의 사망원인 순위는 큰 틀은 비슷하지만 세부 순위와 사망률 수준이 크게 다릅니다. 특히 남성의 암 사망률은 여성의 약 1.6배이고, 자살 사망률은 약 2.6배입니다.

남성 사망원인 TOP 10 (2023)

순위	원인	사망률
1	암	204.9
2	심장 질환	64.9
3	폐렴	62.0
4	뇌혈관 질환	47.0
5	고의적 자해(자살)	38.3
6	당뇨병	23.0
7	간 질환	20.5
8	만성 하기도 질환	16.3
9	코로나19	15.2
10	알츠하이머병	13.7

여성 사망원인 TOP 10 (2023)

순위	원인	사망률
1	암	128.9
2	심장 질환	64.7
3	폐렴	53.1
4	뇌혈관 질환	47.6
5	알츠하이머병	29.7
6	당뇨병	20.2
7	고혈압성 질환	19.8
8	패혈증	17.6
9	고의적 자해(자살)	16.5
10	코로나19	13.9

자료: 통계청 「2023년 사망원인통계」. 단위: 인구 10만 명당 명.

여성은 **알츠하이머병이 5위**로 남성(10위)보다 훨씬 높습니다. 여성의 평균수명이 길어 고령기에 치매를 겪는 비율이 높기 때문입니다. 여성의 보장 설계에서는 치매·장기요양·간병 보장의 우선순위를 높일 필요가 있습니다. 남성은 간 질환·만성 하기도 질환이 순위에 올라 음주·흡연과 관련된 위험이 두드러집니다.

■ 2022년과의 비교

2022년에는 코로나19가 남녀 모두 3위였습니다. 2023년에는 코로나19가 크게 줄면서 폐렴이 남녀 모두 3위로 올라섰습니다. 감염병 유행은 일시적이지만, 폐렴·패혈증처럼 고령자의 면역 저하와 관련된 사망원인은 구조적으로 늘고 있다는 점에 주목해야 합니다.

통계를 보장으로 바꾸는 법

통계에서 본 위험	우선 점검할 보장
암 사망률 1위(전체 사망의 약 4분의 1)	일반암 진단비, 암 주요치료비(항암약물·방사선), 비급여 항암치료비

통계에서 본 위험	우선 점검할 보장
심장질환 2위, 꾸준히 상승	허혈성심장질환 → 심혈관질환까지 넓은 진단비, 관상동맥 수술비
뇌혈관질환 생존자 증가	뇌혈관질환 진단비, 혈전용해·혈전제거 치료비, 후유장해, 간병
폐렴·패혈증 증가	질병 입원비, 중환자실 입원비, 실손의료비
여성 알츠하이머 5위	치매(CDR 척도) 진단비, 장기요양 등급 보장, 간병인 지원
남성 자살·간질환	일반사망 보장, 간질환 관련 진단·수술비

Q. 암 사망률이 높다면 암보험만 잘 들면 되나요?

A. 암은 '가장 확률이 높은 단일 위험'이지만 전체 사망의 약 4분의 3은 다른 원인입니다. 특히 심장·뇌혈관질환은 발병 후 생존해 장기간 치료비와 간병비가 드는 경우가 많으므로, 3대 질병을 균형 있게 준비해야 합니다.

CHAPTER 05 핵심 요약

- 암·심장·뇌혈관 = 사망원인 1·2·4위, 합계 약 40%
- 뇌혈관질환은 사망률 감소 = 생존자 증가 → **후유장해·간병 보장** 중요
- 여성은 알츠하이머 5위 → **치매·장기요양** 보장 우선순위 상향
- 폐렴·패혈증 증가 → 고령기 입원·중환자실 보장 점검

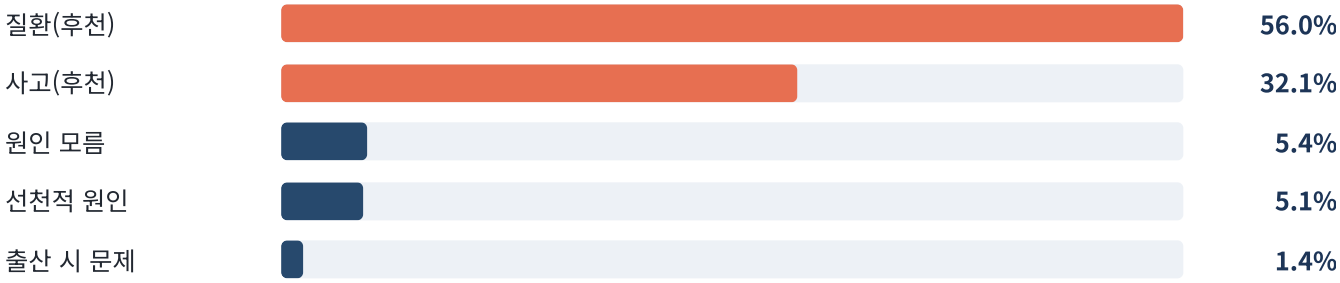
CHAPTER 06

상해·질병 후유장해와 지급률

장애는 대부분 '태어날 때'가 아니라 '살면서' 생깁니다. 후유장해 보장은 사망보다 확률이 높고, 가계에 남기는 부담은 더 오래갑니다.

장해의 88.1%는 후천적 원인

보건복지부 「2020년 장애인 실태조사」에 따르면 장애 발생 원인의 **88.1%가 후천적 원인**입니다. 질환이 56.0%, 사고가 32.1%를 차지하고, 선천적 원인은 5.1%, 출산 시 문제는 1.4%, 원인 불명은 5.4%에 불과합니다.



자료: 보건복지부 「2020년 장애인 실태조사」.

- 장애인 10명 중 6명(63.6%)은 **경증** 장애인입니다. 큰 장해만이 아니라 작은 장해도 보장받을 수 있어야 합니다.
- 보험의 후유장해 담보는 장해율 **3%~100%**까지 신체 부위별로 세밀하게 보장할 수 있습니다.
- 장해율이 높아질수록 보험금이 비례해 늘어납니다. 예: 가입금액 1억 원, 장해율 30% → 3,000만 원

후유장해 보험금의 기본 원리

후유장해 보험금 = 가입금액 × 장해지급률

- **장해분류표**: 약관에 첨부된 표로 신체를 13개 부위로 나누고 부위별 장해 상태에 따른 지급률을 정합니다.
- **판정 시점**: 원칙적으로 장해가 '영구히 고정된 상태'에서 판정합니다. 사고일 또는 진단일부터 180일 이내에 고정되지 않으면 180일이 되는 날의 상태로 판정하는 것이 일반적입니다.
- **같은 부위에 여러 장해**: 그중 가장 높은 지급률 하나만 적용합니다(별도 규정 제외).
- **다른 부위의 장해**: 각각의 지급률을 합산합니다.
- **보험료 납입면제**: 많은 상품이 50% 또는 80% 이상 장해 시 이후 보험료 납입을 면제합니다.

신체 부위별 장해지급률 한눈에 보기

아래 표는 장해분류표의 주요 항목을 부위별로 정리한 것입니다. 실제 판정은 약관의 세부 기준(측정 방법, 평가 시기 등)을 따릅니다.

눈의 장해	지급률
두 눈이 멀었을 때	100%
한 눈이 멀었을 때	50%
한 눈의 교정시력이 0.02 이하	35%
한 눈의 교정시력이 0.2~0.02	5~35%
한 눈에 뚜렷한 시야장해	5%
한 눈에 뚜렷한 조절기능 장해	10%
한 눈 눈꺼풀 뚜렷한 결손 / 운동장해	10% / 5%

귀·코의 장해	지급률
두 귀의 청력 완전 상실	80%
한 귀 청력 상실 + 다른 귀 청력 장해	45%
한 귀의 청력 장해	5~25%
한 귀의 귓바퀴 결손	10%
평형기능 장해	10%
코의 호흡기능 상실 / 후각기능 상실	15% / 5%

씹어먹거나 말하는 장해	지급률
씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두 심한 장해	100%
씹어먹는 기능 심한 장해	80%
말하는 기능 심한 장해	60%
치아 14개 이상 결손	20%
치아 7개 이상 결손	10%
치아 5개 이상 결손	5%

척추·체간골 장해	지급률
척추 운동장해 / 기형	10~40%
심한 추간판탈출증	20%
뚜렷한 추간판탈출증	15%

팔·손가락의 장해	지급률
두 팔을 손목 이상에서 잃었을 때	100%
한 팔을 손목 이상에서 잃었을 때	60%
한 팔 3대 관절 중 하나의 기능 완전 상실	30%
한 팔 3대 관절 중 하나의 장해	5~30%
한 팔에 가관절이 남은 장해	10~20%
한 손의 손가락 모두 잃음	55%
한 손 엄지 손가락 잃음	15%
엄지 외 손가락(하나마다)	10%
한 팔 뼈의 기형	5%

다리·발가락의 장해	지급률
두 다리를 발목 이상에서 잃었을 때	100%
한 다리를 발목 이상에서 잃었을 때	60%
한 다리 3대 관절 중 하나의 장해	5~30%
양쪽 인공관절 삽입 / 한쪽	40% / 20%
다리 길이 5cm / 3cm / 1cm 이상 짧아짐	30 / 15 / 5%
한 다리 뼈의 기형	5%
발가락 모두 잃음	30%
첫째 발가락 잃음 / 그 외(하나마다)	10% / 5%
발가락 뼈의 일부를 잃음	3%

흉·복부 장기 및 비뇨생식기	지급률
심장 기능을 잃었을 때(심장 이식)	100%
폐·신장·간 장기이식	75%
혈액투석(평생) / 방광기능 상실	75%
위·대장·췌장 전절제	50%
양쪽 고환 또는 난소 절제	50%

척추·체간골 장해	지급률
약간의 추간판탈출증	10%
어깨뼈·골반뼈 뚜렷한 기형	15%
빗장뼈·가슴뼈·갈비뼈 뚜렷한 기형	10%

흉·복부 장기 및 비뇨생식기	지급률
인공심박동기 영구 삽입	30%
위·췌장 50% 절제 / 한쪽 신장·폐 절제	30%
인공항문 설치	30%
폐질환으로 폐기능 정상의 40% 이하	15%
방광 용량 50cc 이하 / 음경 1/2 결손 등	15%

■ 신경계·정신행동 장해

장해 상태	지급률
정신행동에 극심한 장해	100%
정신행동에 뚜렷한 장해	50%
정신행동에 경미한 장해	10%
일상생활 기본동작(ADLs) 제한 장해	10~100%
치매 — 극심한 치매(CDR 5점) / 심한 치매(CDR 4점)	100% / 80%
치매 — 뚜렷한 치매(CDR 3점) / 약간의 치매(CDR 2점)	60% / 40%

뇌졸중 후유장해는 어떻게 평가할까 — ADLs 합산평가

뇌졸중·뇌손상·척수 및 신경계 질환으로 생긴 마비 등은 **발병 또는 외상 후 12개월 동안 지속적으로 치료한 후** 장해를 평가합니다. 이때 사용하는 기준이 '일상생활 기본동작(ADLs) 제한 장해평가'입니다. 다섯 가지 동작의 제한 정도를 각각 평가해 합산하고, **합산 지급률이 10% 이상**이면 지급합니다.

이동동작		음식물 섭취		배변·배뇨		목욕		옷 입고 벗기		합산평가
10~40%	+	5~20%	+	5~20%	+	3~10%	+	3~10%	=	최대 100%

사례 — 뇌경색 후 편마비

62세 C씨는 뇌경색으로 오른쪽 편마비가 남았습니다. 12개월간 재활치료 후 평가 결과 ① 이동: 보조기구를 사용해야 독립적인 보행 가능(약 20%), ② 음식물 섭취: 젓가락 사용 불가, 숟가락으로 가능(약 5%), ③ 배변·배뇨: 독립 가능(0%), ④ 목욕: 부분적 도움 필요(약 3%), ⑤ 옷 입고 벗기: 부분적 도움 필요(약 3%)로 합산 약 31%가 나왔습니다. 질병후유장해 가입금액이 5,000만 원이었다면 약 1,550만 원을 받게 됩니다. ※ 판정 기준은 약관 세부 내용에 따름.

또한 장기요양등급(CHAPTER 17 참고)을 인정받으면 보험사의 '장기요양보험(간병) 담보'에서도 별도로 보장받을 수 있습니다. 대부분 65세 기준으로 요건이 달라지므로 가입 담보의 조건을 확인하세요.

상해후유장해 vs 질병후유장해

구분	상해후유장해	질병후유장해
원인	급격·우연·외래의 사고	질병
보험료	저렴(고액 가입 쉬움)	상대적으로 비쌈
가입 범위	3%~100% 또는 20%·50%·80% 이상 등	3%~100% 또는 80% 이상만 보장하는 상품 많음
만기	100세 만기 가능	80세·90세 만기가 많음
주요 발생	교통사고, 낙상, 스포츠 손상	뇌졸중, 디스크, 관절질환, 시력·청력 상실, 장기 절제

앞의 통계처럼 장애 원인 중 질환(56%)이 사고(32.1%)보다 많습니다. 그런데 실제 보험 가입은 저렴한 상해후유장해에 치우친 경우가 많습니다. **질병후유장해 3% 이상** 담보가 있는지 확인해 보세요.

Q. 디스크(추간판탈출증)도 후유장해로 보상되나요?

A. 척추의 추간판탈출증은 정도에 따라 10~20%의 장해지급률이 정해져 있습니다. 다만 디스크는 퇴행성 요인이 함께 작용하는 경우가 많아, 사고(상해) 기여도에 따라 지급액이 조정될 수 있습니다.

Q. 인공관절 수술을 받으면 무조건 장해 보험금이 나오나요?

A. 한쪽 인공관절 삽입은 20%, 양쪽은 40%의 지급률을 적용하는 경우가 많습니다. 질병후유장해 3% 이상 담보가 있다면 퇴행성 관절염으로 인한 인공관절 삽입도 보상 대상이 될 수 있습니다.

Q. 장해 판정은 누가 하나요?

A. 주치의의 후유장해 진단서를 바탕으로 보험사가 심사합니다. 판정에 이견이 있으면 보험사와 합의한 제3의 의료기관에서 다시 판정받을 수 있습니다(비용은 일반적으로 보험사 부담).

Q. 한 번의 사고로 여러 부위를 다쳤어요. 장해 지급률은 어떻게 합산하나요?

A. 다른 신체 부위의 장해는 각각의 지급률을 합산합니다(예: 한쪽 무릎 20% + 손가락 10% = 30%). 같은 부위에 여러 장해가 있으면 가장 높은 지급률 하나만 적용하는 것이 원칙이며, 한 사고로 인한 합산 지급률은 100%를 한도로 합니다.

Q. 장해 판정 후 상태가 더 나빠지면 추가로 받을 수 있나요?

A. 약관은 보통 장해지급률이 결정된 후 보험기간 중 같은 원인으로 장해 상태가 악화된 경우, 악화된 지급률에서 이미 지급한 지급률을 뺀 만큼 추가로 지급하도록 정하고 있습니다. 보험기간이 끝난 뒤의 악화는 원칙적으로 보장되지 않으니 증상 변화를 꾸준히 기록해 두세요.

CHAPTER 06 핵심 요약

- 장애의 88.1%는 후천적, 그중 **질환이 56%**로 사고보다 많음
- 후유장해 보험금 = 가입금액 × 지급률(3~100%)
- 뇌졸중 등은 12개월 치료 후 ADLs 합산평가(10% 이상 지급)
- 상해후유장해만 있다면 **질병후유장해 3% 이상** 보완 검토

■ 점검 체크리스트

- [ ] 상해후유장해와 질병후유장해 가입금액을 각각 확인했다.
- [ ] 후유장해 담보가 3% 이상부터 보장하는지, 80% 이상만 보장하는지 확인했다.
- [ ] 장해 시 보험료 납입면제 조건(50%·80%)을 확인했다.
- [ ] 치매 장해(CDR) 보장 여부를 확인했다.

PART 3

3대 질병 — 암·뇌·심장

사망원인 1·2·4위, 진료비 1·2위. 암과 뇌·심장 질환은 보험 보장의 중심축입니다. 같은 '진단비'라도 담보의 정의, 치료 방식의 변화, 질병코드에 따라 받을 수 있는 금액이 크게 달라지므로 이 파트는 특히 꼼꼼히 읽어 보시기 바랍니다.

07 CI보험 vs GI보험

08 암의 발생 원인과 통계

09 암의 검사·진단과 병기(TNM)

10 암 치료의 진화와 암보험 트렌드

11 수술의 분류 — 종수술 표 읽는 법

12 산정특례 제도

13 뇌혈관질환 — 진단·치료와 보장 범위

14 심장질환 — 보장 범위와 상병코드

CHAPTER 07

CI보험 vs GI보험

'중대한'이라는 세 글자가 보험금 지급의 문턱을 얼마나 높이는지 아는 것이 CI보험 이해의 시작입니다.

두 보험의 정의

CI보험 (Critical Illness, 중대한 질병)

- 약관상 **'중대한' 질병**으로 진단받거나 **'중대한' 수술**을 받았을 때 사망보험금 일부를 선지급
- 암: 일정 수준 이상 침윤된 경우 보상
- 뇌졸중: **영구적인 신경학적 결손**이 있는 경우 보상
- 급성심근경색: 관상동맥 폐색으로 흉통, 심전도 변화, 심근효소 변화가 **모두** 나타나는 경우 보상
- 선지급 후 남은 금액은 사망 시 지급

GI보험 (General Illness, 일반 질병)

- 약관에 정한 질병으로 **진단만 받으면** 보험금 선지급
- 약관의 질병 분류상 암으로 판정되면 보장
- 약관에 정한 뇌출혈로 판정되면 보장
- 급성심근경색증으로 진단받으면 보장
- 선지급 후 남은 금액은 사망 시 지급
- CI보험을 보완한 상품, **보상받을 확률이 높음**

두 상품 모두 기본 구조는 **종신보험 + 선지급**입니다. 살아 있는 동안 신체 각 부위에 발생 가능한 중대한 질병과 수술, 화상·부식, 일상생활 장해상태, 중증치매가 생기면 치료비와 간병비로 쓸 수 있도록 사망보험금의 일부(보통 50~80%)를 미리 지급하고, 그런 일이 없으면 사망 시 사망보험금으로 지급합니다.

CI보험의 보험금 지급 사유

주요 질병

- 중대한 암
- 중대한 뇌졸중
- 중대한 급성심근경색증
- 말기신부전증
- 말기간질환
- 말기폐질환 등

4대 수술

- 관상동맥우회술
- 대동맥류 인조혈관치환수술
- 심장판막수술
- 5대 장기 이식수술(간·폐·심장·신장·췌장)

그 외

- 중대한 화상·부식
- 중증 치매
- 일상생활장해상태
- 장해 50% 이상 등(상품별 납입면제)

■ 4대 수술 간단히 이해하기

수술	내용
관상동맥우회술	막힌 심장동맥(관상동맥)을 우회하도록 다른 혈관을 이어 붙여 혈류 통로를 새로 만드는 수술. 개흉 수술이 원칙이며, 스텐트 삽입(경피적 시술)은 일반적으로 포함되지 않습니다.
대동맥류 인조혈관 치환수술	풍선처럼 부푼 대동맥(대동맥류)을 제거하고 인조혈관으로 대체하는 수술. 복부·흉부 대동맥에서 시행합니다.
심장판막수술	제 기능을 못 하는 심장판막(승모판·대동맥판 등)을 고치거나 인공판막으로 교체하는 수술
5대 장기 이식	간·폐·심장·신장·췌장의 이식. 간과 신장은 기증자의 일부 장기로도 이식할 수 있고, 혈액형 불일치 이식·고령자 이식·복강경·로봇 수술 등 기술이 발전했습니다. 췌장은 신장과 동시에 이식하는 경우가 많습니다.

'중대한'의 함정 — CI보험 분쟁이 많은 이유

CI보험은 2000년대에 큰 인기를 끌었지만, 이후 보험금 분쟁이 끊이지 않았습니다. 이유는 '중대한'의 정의가 일반인이 생각하는 것보다 훨씬 엄격하기 때문입니다.

질병	일반인의 생각	CI 약관의 기준(예시)
암	암 진단을 받았으니 지급	악성종양 세포가 주위 조직으로 침윤·파괴적 증식을 하는 '중대한 암'. 초기 갑상선암·제자리암·경계성종양 등은 제외되는 경우가 많음
뇌졸중	뇌경색 진단을 받았으니 지급	뇌혈관 사고로 뇌혈액순환이 급격히 차단되어 **영구적인 신경학적 결손**(언어·운동·시야·감각 등)이 남은 경우. 회복되면 지급 안 될 수 있음
급성심근경색	심근경색 진단을 받았으니 지급	전형적인 흉통 + 새로운 심전도 변화 + 심근효소 상승 등 요건 충족. 협심증이나 스텐트 시술만으로는 지급 안 됨

이 때문에 같은 뇌경색 환자라도 GI보험에서는 진단만으로 보험금을 받지만(상품의 진단 범위에 따라), CI보험에서는 영구 장애가 남지 않으면 받지 못하는 일이 생깁니다. 이후 GI보험이 등장하고 '중대한'의 요건을 완화한 상품이 늘어났지만, **과거에 가입한 CI보험의 약관은 가입 당시 기준**이 그대로 적용됩니다.

> **CI보험을 가지고 있다면 — 해지보다 '보완'**
>
> CI보험은 종신보험으로서의 사망보장 기능이 있으므로 무작정 해지하는 것은 좋지 않습니다. CI보험은 사망보장 + 중증 상태 대비용으로 유지하고, 진단만으로 지급되는 **암·뇌혈관·심혈관 진단비**를 별도의 건강보험으로 보완하는 것이 일반적인 해법입니다.

CI·GI보험과 일반 건강보험 비교

구분	CI보험	GI보험	건강보험(진단비)
지급 조건	중대한 질병·수술	약관상 질병 진단	약관상 질병 진단
지급 방식	사망보험금 선지급	사망보험금 선지급	진단비 별도 지급
선지급 후	사망보험금 감소	사망보험금 감소	사망보장과 무관
보험료	높음(종신 기반)	높음(종신 기반)	상대적으로 저렴
적합한 사람	사망보장과 중증 대비를 하나로 묶고 싶은 사람		진단 시 목돈이 필요한 사람, 사망보장은 따로 준비한 사람

Q. CI보험에서 선지급을 받으면 사망보험금은 어떻게 되나요?

A. 예를 들어 사망보험금 1억 원, 선지급률 80%인 CI보험에서 중대한 암으로 8,000만 원을 받으면, 이후 사망 시에는 남은 2,000만 원만 지급됩니다. 선지급은 '추가 보험금'이 아니라 '사망보험금을 앞당겨 받는 것'입니다.

Q. CI보험에서 거절된 경우 다툴 수 있나요?

A. 의학적 기준 해석에 다툼의 여지가 있다면 주치의 소견서, 검사 결과지를 갖추어 재심사를 청구하거나 금융감독원 분쟁조정을 신청할 수 있습니다. 약관의 뜻이 명확하지 않으면 고객에게 유리하게 해석한다는 원칙(작성자 불이익 원칙)도 있습니다.

CHAPTER 07 핵심 요약

- CI = '중대한' 질병·수술 시 사망보험금 선지급 → 지급 요건 엄격
- GI = 약관상 질병 진단만으로 선지급 → 보상 확률 높음
- 선지급은 사망보험금을 앞당겨 받는 구조
- CI보험은 유지하면서 진단비 중심 건강보험으로 보완

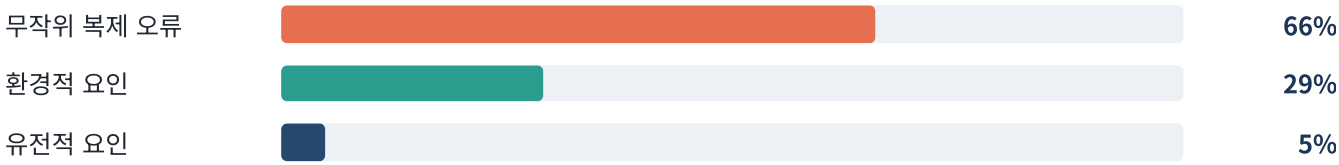
CHAPTER 08

암의 발생 원인과 통계

한 해 28만 명이 새로 암 진단을 받습니다. 암이 왜 생기는지, 어떤 암이 많은지 알면 어떤 보장이 필요한지가 보입니다.

암은 왜 생기는가 — 세 가지 원인

2017년 국제학술지 「사이언스(Science)」에 실린 미국 존스홉킨스대 연구진의 논문은 암을 일으키는 세포 돌연변이가 어디서 오는지를 분석해 큰 반향을 일으켰습니다. 연구에 따르면 암 관련 돌연변이의 원인은 다음과 같이 나뉩니다.



자료: Tomasetti C, Vogelstein B 외, Science(2017.3). 각 요인에 의해 세포 돌연변이가 일어나는 정도.

'무작위 복제 오류'란 세포가 분열할 때 DNA를 복사하는 과정에서 우연히 생기는 실수를 말합니다. 즉, 담배를 피우지 않고 건강하게 살아도 **세포 분열이 계속되는 한 누구에게나 암이 생길 수 있다**는 뜻입니다. 생활습관 관리(환경적 요인)로 위험을 줄일 수는 있지만 0으로 만들 수는 없기 때문에, 암에 대한 경제적 대비는 '건강한 사람'에게도 필요합니다.

암의 세 가지 특성과 보험

① 비정상적 빠른 세포분열

정상세포가 돌연변이를 일으켜 통제되지 않는 속도로 분열하고 증식합니다.

② 전이

주변 조직, 혹은 림프절이나 혈관을 통해 다른 장기로 퍼집니다.

③ 재발

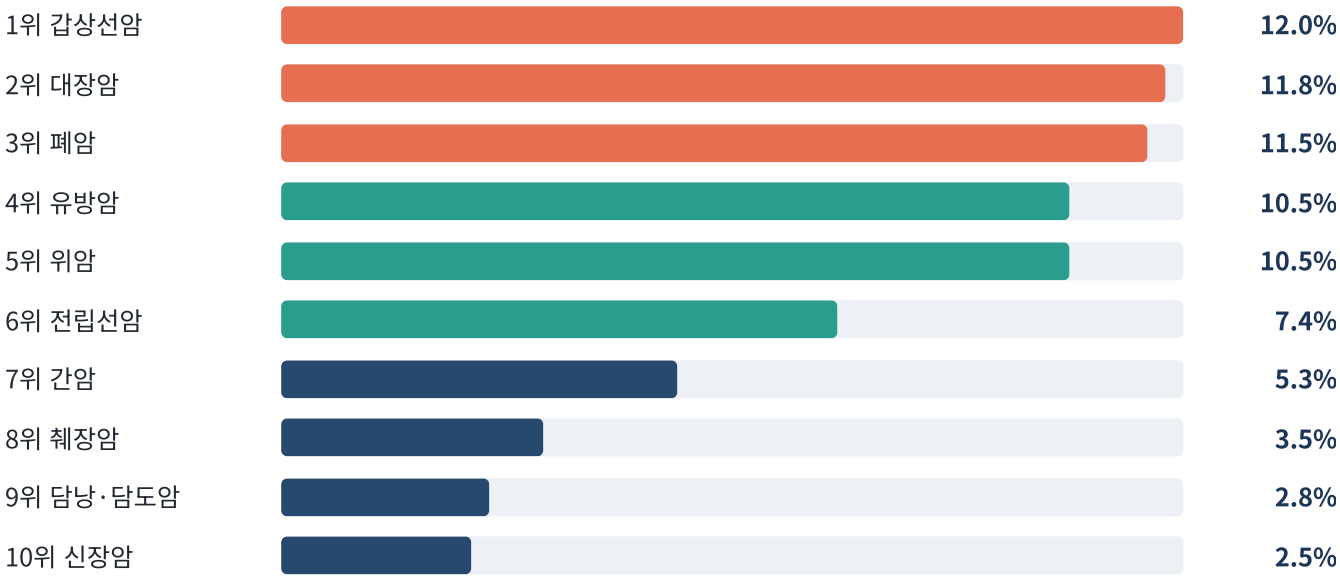
치료 후에도 남은 암세포나 미세암으로 인해 재발 가능성이 높습니다.

이 세 가지 특성 때문에 암 치료는 한 번으로 끝나지 않는 경우가 많습니다. 수술 후에도 재발 방지를 위한 보조 항암치료가 이어지고, 전이나 재발이 생기면 다시 치료가 시작됩니다. 그래서 최근 암보험은 진단 시 한 번 지급하는 진단비에서, **치료를 받을 때마다 보험 만기까지 지급하는 '암 주요치료비'**로 무게중심이 옮겨 가고 있습니다. 암주요치료비·비급여 암주요치료비·전이암 주요치료비가 바로 이런 암의 특성을 반영한 담보입니다.

한국인의 암 발생 현황

국가암등록통계(2022년 기준, 2024년 발표)에 따르면 2022년 새로 암 진단을 받은 사람은 **282,047명**입니다. 남성 147,468명(52.3%), 여성 134,579명(47.7%)이며, 인구 10만 명당 조발생률은 전체 550.2명, 남성 577.4명, 여성 523.3명입니다.

■ 전체 암 발생 순위(2022)



자료: 보건복지부·국립암센터 「국가암등록통계」(2022년 발생 기준). 기타 암 22.2%.

■ 성별 암 발생 순위(2022)

순위	남성	비율
1	**폐암**	14.7%
2	전립선암	14.1%
3	대장암	13.3%
4	위암	13.3%
5	간암	7.4%
6	갑상선암	5.8%
7	췌장암	3.4%
8	신장암	3.3%
9	담낭·담도암	2.9%
10	방광암	2.8%

순위	여성	비율
1	**유방암**	21.8%
2	갑상선암	18.8%
3	대장암	10.0%
4	폐암	7.9%
5	위암	7.4%
6	췌장암	3.5%
7	자궁체부암	2.9%
8	간암	2.9%
9	담낭·담도암	2.6%
10	난소암	2.4%

■ 통계가 보험 설계에 주는 메시지

- **여성의 유방암·갑상선암 = 40% 이상.** 갑상선암은 상품에 따라 '유사암·소액암'으로 분류되어 일반암 진단비의 10~20%만 지급되기도 합니다. 여성은 유사암 진단비의 금액과 유방암이 일반암으로 분류되는지 꼭 확인하세요.
- **남성의 전립선암 2위.** 일부 상품은 전립선암을 '소액암'으로 분류합니다. 남성은 전립선암의 분류 기준을 확인할 필요가 있습니다.
- **폐암·췌장암·간암은 치료비 부담이 큽니다.** 발견 시 이미 진행된 경우가 많아 표적·면역항암제 등 고가 치료로 이어지는 경우가 많습니다.

수도권 대형병원 쏠림과 치료비

암 진단을 받으면 많은 환자가 서울의 상급종합병원(이른바 '빅5' 병원)을 찾습니다. 환자들이 수도권 의료기관을 선택하는 가장 큰 이유는 **의사에 대한 신뢰**이고, 거주 지역 의료기관을 선택하지 않는 이유로는 의사 신뢰도와 함께 **병원 인지도**, 주변 추천, 최신 장비가 꼽힙니다.

여기서 놓치기 쉬운 비용이 있습니다. 2021년 서울아산병원의 암 치료 연인원 통계를 보면, 전체 암 환자 중 **입원 치료는 약 8%, 외래(통원) 환자가 약 92%**에 달했습니다. 항암약물치료와 방사선치료의 상당 부분이 통원으로 이루어지기 때문입니다. 지방에 사는 환자라면 매번의 통원에 교통비·숙박비·보호자 동행 비용이 더해지고, 그동안 일을 하지 못하는 소득 손실도 생깁니다.

암 치료비의 진짜 구성

비용 항목	건강보험·실손으로 해결되는가?
급여 치료비(본인부담 5%, 산정특례)	대부분 해결
비급여 항암제·신의료기술(일부 표적·면역항암, 중입자 등)	실손 세대·한도에 따라 일부만 해결
상급병실료, 간병비	일부 또는 해결 안 됨
교통비·숙박비·보호자 비용	해결 안 됨
치료 기간 소득 손실	해결 안 됨 → **진단비·치료비 정액 담보로 대비**

암 진단비, 얼마나 준비할까

암 진단비는 흔히 '연소득의 1~2배'를 기준으로 삼습니다. 치료 기간(평균 1~2년) 동안의 소득 공백을 메우고, 실손으로 보장되지 않는 비급여 비용과 부대비용을 감당하기 위해서입니다. 다만 최근에는 진단비 하나로 모든 것을 해결하기보다, **진단비(목돈) + 주요치료비(치료할 때마다) + 실손(실제 의료비)**의 세 층으로 나누어 준비하는 추세입니다.

1층 · 진단비	+	2층 · 주요치료비	+	3층 · 실손의료비
진단 즉시 목돈 소득 공백·초기 비용		수술·항암·방사선마다 재발·전이에도 반복		실제 치료비 (자기부담 제외)

Q. 가족력이 없으면 암보험은 덜 필요하지 않나요?

A. 앞서 본 것처럼 유전적 요인은 암 발생 원인의 약 5%에 불과합니다. 가족력이 없어도 무작위 복제 오류와 환경 요인으로 누구나 암에 걸릴 수 있습니다.

Q. 갑상선암은 '착한 암'이라 진단비가 적게 나와도 괜찮지 않나요?

A. 갑상선암은 예후가 좋은 편이지만, 수술·방사성 요오드 치료·평생 호르몬 복용이 필요할 수 있고 재발도 있습니다. 유사암 진단비가 지나치게 작다면 보완을 검토하세요.

CHAPTER 08 핵심 요약

- 암 돌연변이의 66%는 무작위 복제 오류 → 건강한 사람도 대비 필요
- 2022년 신규 암환자 282,047명, 1위 갑상선·2위 대장·3위 폐
- 남성 1위 폐암, 여성 1위 유방암(갑상선과 합쳐 40% 이상)
- 암 치료의 92%는 외래 → 진단비 + 주요치료비 + 실손의 3층 대비

CHAPTER 09

암의 검사·진단과 병기(TNM)

암 진단비는 '언제' 지급될까요? 그리고 '몇 기'인지가 보험에서 왜 중요할까요? 검사부터 병기 분류까지 차례로 살펴봅니다.

암을 찾아내는 네 가지 검사

① 내시경 검사

위·대장·방광·자궁경부 등을 직접 들여다보며 의심 부위의 조직을 떼어 냅니다(조직검사). 용종 제거도 이 과정에서 이루어집니다.

② 영상 검사

CT, MRI, PET-CT 등으로 종양의 크기와 위치, 원발 부위와 전이 여부를 확인합니다. 영상만으로는 암을 '확정'하지 않습니다.

③ 조직 검사

생검(조직을 떼어 냄), 미세바늘흡인검사, 혈액암의 경우 혈액·골수 검사로 세포를 현미경으로 확인합니다. **암 확정 진단의 핵심**입니다.

④ 유전자 검사

NGS(차세대 염기서열 분석), WGS(전장 유전체 분석) 등으로 암세포의 유전자 변이를 분석해 표적항암제 등 치료 방법을 결정합니다.

암 진단 확정일 = 병리학적 검사 결과를 주치의에게 보고하는 시점

보험에서 암의 진단 확정은 **병리 또는 진단검사의학 전문의가 조직(fixed tissue)검사, 미세바늘흡인검사, 혈액검사에 대한 현미경 소견을 기초로** 해야 합니다. 그리고 진단 확정일은 일반적으로 그 병리 결과가 주치의에게 보고된 날입니다. 영상검사에서 '암 의심' 소견을 받은 날이 아니라는 점에 주의하세요.

이 날짜가 중요한 이유는 **면책기간(가입 후 90일)과 감액기간(1~2년)** 때문입니다. 예를 들어 가입 후 85일에 조직검사를 했고 결과가 95일째에 보고되었다면 진단 확정일은 95일째로 보아 면책기간을 벗어납니다. 반대로 영상검사로 의심 소견을 받은 직후 서둘러 보험에 가입하는 것은 알릴의무 위반이 될 수 있습니다.

병기의 기본 — 제자리암부터 4기까지

단계	상태	일반적 치료
제자리암(상피내암)	암세포가 상피층 안에만 머물러 있는 상태	간단한 수술·약물치료로 대부분 완치
경계성종양	양성보다 예후가 나쁘지만 악성은 아님	대부분 치명적이지 않고 완치율 높음

단계	상태	일반적 치료
1기·2기(국한)	특정 부위에 암세포가 침윤·침식	수술로 완치 가능, 재발 우려 시 항암치료 시행
3기(국소)	암세포가 림프절로 전이(림프절 전이)	암세포 양상에 따라 수술 및 항암·방사선 병행치료
4기(원격)	암세포가 다른 장기로 전이(원격 전이)	항암치료 이후 수술, 다시 항암치료 또는 생명연장을 위한 치료

보험에서 제자리암과 경계성종양은 대부분 '유사암'으로 분류되어 일반암보다 적은 금액을 지급합니다. 질병코드로는 제자리암이 D00~D09, 경계성종양이 D37~D48에 해당합니다(부록 A 참고).

TNM 분류 — 암의 진행 정도를 나타내는 국제 표준

T (Tumor)

종양의 크기와 주변 조직으로 침윤된 정도. T1~T4로 숫자가 클수록 크거나 깊습니다.

N (Node)

림프절 침범 정도. N0는 림프절 전이 없음, N1~N3은 침범한 림프절의 수·위치에 따라 구분합니다.

M (Metastasis)

다른 장기로의 원격 전이 여부. M0는 전이 없음, M1은 원격 전이 있음입니다.

구분	T1	T2	T3	T4
N0, M0	근육층 내(1기)		장막하층 침범(2기)	
N1~3, M0	림프절 전이 시(3기)			
M1	다른 장기로 원격 전이 시(4기)			

※ 대장암·위암 등 소화기암을 예로 단순화한 구조이며, 암종마다 기준이 다릅니다.

■ 전이의 두 가지 경로

- **림프성 전이**: 암이 림프절을 통해 다른 장기로 퍼지는 경우
- **혈행성 전이**: 암이 혈관을 통해 다른 장기로 퍼지는 경우

요약병기별 비율 — 원격전이는 약 20%

국가암등록통계는 암을 진단 시점의 진행 정도에 따라 '국한(암이 처음 발생한 장기에 머무름)', '국소 진행(주위 조직·림프절 침범)', '원격 전이' 세 가지로 요약해 발표합니다. 2005년부터 2022년까지 추이를 보면 **국한 단계 진단**

비율은 40%대 중후반에서 약 50%로 꾸준히 늘었고, 원격 전이 상태로 발견되는 비율은 **약 20% 안팎에서 큰 변화가 없습니다.**

국가 암검진 확대로 조기 발견이 늘었지만, 여전히 암 환자 5명 중 1명은 다른 장기로 전이된 상태에서 진단받는다는 뜻입니다. 암종별로 보면 갑상선·유방·위·전립선·자궁 관련 암은 국한 단계 발견 비율이 높고, **췌장암·폐암·담낭 및 담도암·난소암은 원격 전이 상태로 발견되는 비율이 높습니다.** 이런 암일수록 진단 직후 고가의 항암치료가 바로 시작되는 경우가 많습니다.

> **전이암과 보험 — 원발암 기준 원칙**
>
> 대부분의 약관은 전이암을 **원발 부위(처음 생긴 부위) 기준**으로 분류합니다. 예를 들어 갑상선암이 림프절로 전이되었다면 '갑상선암(유사암)'으로 판단하고, 일반암 진단비를 별도로 지급하지 않는 경우가 많습니다. 최근에는 이를 보완하기 위해 **전이암 진단비·전이암 주요치료비**처럼 전이 자체를 보장하는 담보가 판매되고 있습니다.

보험금 청구 시 필요한 서류

서류	확인할 내용
진단서	질병명, **질병분류코드(C코드·D코드)**, 진단 확정일
조직검사 결과지(병리보고서)	병리 전문의의 현미경 소견, 보고일
입·퇴원 확인서, 수술 확인서	입원일수, 수술명·수술코드(수술비 청구 시)
진료비 세부내역서	항암약물·방사선 치료 내역(주요치료비 청구 시)

Q. 대장 내시경에서 용종을 떼었는데 '제자리암'이 나왔어요. 암보험금을 받을 수 있나요?

A. 제자리암(D코드)은 대부분 '유사암'으로 분류되어 유사암 진단비가 지급됩니다. 다만 대장의 점막내암은 병리학적 판단에 따라 C코드(일반암)로 분류되는 경우가 있어 분쟁이 잦은 영역이므로, 병리보고서의 침윤 깊이를 확인하세요.

Q. 진단서의 코드가 C인지 D인지 왜 중요한가요?

A. C코드(C00~C97)는 악성신생물로 일반암, D코드(D00~D09 제자리암, D37~D48 경계성종양)는 유사암으로 분류되는 것이 일반적입니다. 같은 부위의 암이라도 코드 하나에 진단비가 수천만 원 차이 날 수 있습니다.

사례 — 면책기간과 진단 확정일

Q씨는 암보험 가입 80일째에 건강검진에서 갑상선 결절이 발견되어 세침검사(미세바늘흡인검사)를 받았고, 결과는 가입 93일째에 나왔습니다. 진단 확정일이 면책기간(90일)이 지난 93일째로 인정되어 보험금을 받았습니다. 그러나 만약 가입 전에 이미 '결절 추적관찰' 소견을 받았는데 알리지 않았다면, 진단 시점과 관계없이 알릴의무 위반이 문제가 될 수 있습니다.

Q. 암이 의심된다는 말만 듣고 조직검사를 못 한 채 수술했어요. 진단비는요?

A. 약관은 조직검사를 원칙으로 하지만, 조직검사가 불가능한 경우에는 임상학적 진단(영상·임상 소견 등)과 치료 기록을 증거로 인정하는 예외 조항을 두는 경우가 많습니다. 수술 후 절제 조직의 병리 결과가 있다면 그 결과로 진단 확정이 가능합니다.

CHAPTER 09 핵심 요약

- 암 진단 확정 = 조직·혈액 등 **병리학적 검사** 결과 보고일
- TNM: 종양 크기(T)·림프절(N)·원격전이(M)
- 국한 단계 진단은 늘었지만 원격 전이는 여전히 약 20%
- 전이암은 원발암 기준 → 전이암 담보로 보완 가능

CHAPTER 10

암 치료의 진화와 암보험 트렌드

암 치료는 '자르고, 태우고, 독으로 죽이는' 시대에서 '표적을 겨냥하고 면역을 깨우는' 시대로 바뀌었습니다. 암보험도 그 변화를 따라 다섯 세대를 거쳐 왔습니다.

암보험의 5세대 변천

세대	핵심 키워드	대표 담보
1세대	진단비 중심	암 진단비, 유사암 진단비, 암 수술비, 항암방사선·약물치료비, 암 입원일당
2세대	이차암·재진단암	이차암 진단비(다른 부위에 새로 생긴 암), 재진단암 진단비(일정 기간 후 다시 진단)
3세대	신의료기술	다빈치 암로봇수술, 표적항암약물치료, 면역항암약물치료, 양성자 방사선, 세기조절 방사선, CAR-T 세포치료
4세대	통합암·전이암	통합암 진단비(부위별 반복 지급), 전이암 진단비, 암통원
5세대	**암 치료비**	암 주요치료비, 종합·상급병원 암 주요치료비, 암 비급여 치료비, 전이암 치료비

세대가 바뀌었다고 이전 세대 담보가 쓸모없어진 것은 아닙니다. 진단비는 여전히 '목돈'으로서 가장 강력한 담보입니다. 다만 암이 만성질환처럼 오랜 기간 관리되는 질병이 되면서, **진단 한 번이 아니라 치료 과정 전체**를 보장하는 담보의 중요성이 커졌습니다.

■ 세대별 담보, 내 보험에는 무엇이 있을까

- [ ] 일반암 진단비 / 유사암 진단비 금액
- [ ] 이차암·재진단암 진단비(재발·두 번째 암 대비)
- [ ] 표적항암·면역항암 약물치료비(신의료기술)
- [ ] 통합암 또는 전이암 진단비
- [ ] 암 주요치료비(연간 1회 또는 매회, 만기까지 반복 지급 여부)
- [ ] 암 비급여 치료비 / 상급종합병원 치료 시 가산 여부

암 주요 치료 ① 수술

구분	방법
절제술	절개술(개복·개흉), 복강경·흉강경 수술, 내시경 수술, 로봇 수술(다빈치·레보아이 등) 등
최소침습 수술	방사선, 고주파 열치료, 레이저, 색전술, 카테터를 이용한 시술 등

로봇 수술은 정밀도가 높고 회복이 빠르지만 대부분 비급여여서 1회 수백만 원에서 1,000만 원 이상이 들 수 있습니다. 실손보험에서 보상되더라도 자기부담금이 있으므로, 고액 수술에 대비한 **암 수술비(정액)**나 로봇수술 특약이 의미가 있습니다.

암 주요 치료 ② 항암약물치료

보조치료

수술·방사선 치료 후 남아 있을 수 있는 미세암을 제거해 재발을 막는 목적

선행치료

종양의 크기를 줄여 수술 및 방사선 치료의 효과를 높이는 목적

병행치료

약물치료와 방사선치료를 함께 시행해 전신에 퍼진 암과 특정 부위 암의 치료 효과를 높이는 목적

■ 항암제의 세대 변화

1세대 · 화학항암제
빠르게 분열하는 세포를 공격
정상세포도 손상(탈모·구토 등)

›

2세대 · 표적항암제
암세포의 특정 유전자·단백질만 공격
유전자 검사로 대상자 선별

›

3세대 · 면역항암제
환자 자신의 면역세포가 암을 공격하도록 활성화
CAR-T 세포치료 포함

표적·면역항암제는 효과가 뛰어난 대신 가격이 매우 높습니다. 건강보험 급여 적용 범위가 점차 넓어지고 있지만, 적응증(급여 인정 범위) 밖에서 사용하면 비급여로 1회 투약에 수백만 원, 연간 수천만 원에서 억대 비용이 들기도 합니다. CAR-T 세포치료는 급여 적용 시에도 본인부담이 상당하고, 비급여일 경우 수억 원에 이릅니다.

암 주요 치료 ③ 항암방사선치료

방사선 치료도 약물과 같은 목적(보조·선행·병행)으로 시행되며, 기술은 다음과 같이 발전해 왔습니다.

1세대 방사선
넓은 범위 조사

›

감마나이프·사이버나이프
정위적 방사선 수술

›

세기조절 방사선(IMRT)
종양 모양에 맞춰 세기 조절

›

양성자 방사선
정상조직 손상 최소화

›

중입자 방사선
양성자보다 강력, 국내 도입 초기

중입자 치료는 국내에서 2023년부터 일부 대학병원에서 시작되었으며, 대부분 비급여로 1회 치료 과정에 수천만 원이 듭니다. 양성자 치료는 소아암 등 일부 적응증에서 급여가 적용됩니다.

치료 담보를 고를 때 확인할 다섯 가지

확인 항목	내용
지급 주기	연간 1회 한도인지, 치료할 때마다 지급인지. 같은 해에 수술과 항암을 모두 받는 경우 차이가 큽니다.
지급 기간	보험 만기까지 반복 지급되는지, 최초 1회 또는 5년 등 기간 제한이 있는지
대상 치료	수술·항암약물·방사선 모두 포함인지, 호르몬 약물치료도 포함되는지(유방암·전립선암에서 중요)
급여·비급여	급여 치료만 인정하는지, 비급여 치료도 인정하는지
병원 규모	종합병원·상급종합병원 치료 시 가산 지급이 있는지

사례 — 유방암 환자의 치료 타임라인과 보험

45세 D씨는 유방암 2기 진단을 받았습니다. ① 선행 항암약물치료 4개월 → ② 부분 절제 수술 → ③ 방사선 치료 6주 → ④ 표적항암제 1년 → ⑤ 호르몬 약물 5~10년. 치료는 최소 2년, 호르몬 치료까지 포함하면 10년에 걸쳐 이어집니다. 진단비만 있었다면 한 번 받고 끝났겠지만, '매년 지급되는 암 주요치료비'가 있다면 치료가 이어지는 해마다 보험금을 받을 수 있습니다. 단, 호르몬 약물치료를 주요치료비 대상에 포함하는지는 상품마다 다르므로 약관을 확인해야 합니다.

Q. 이미 암 진단비가 충분하면 치료비 담보는 필요 없나요?

A. 진단비는 한 번 받으면 끝나는 경우가 많습니다. 재발·전이로 치료가 길어지면 진단비가 바닥날 수 있으므로, 진단비가 충분하더라도 반복 지급되는 치료비 담보를 일정 금액 갖추는 것이 안정적입니다.

Q. 실손보험이 있으면 표적항암제 비용도 다 보장되지 않나요?

A. 실손은 세대별로 비급여 보장 한도와 자기부담률이 다르고, 특히 5세대 실손은 비중증 비급여 보장이 크게 축소됩니다. 고가 항암제는 연간 한도(예: 5,000만 원)를 넘을 수 있어 정액 치료비 담보와 함께 준비하는 것이 안전합니다.

Q. 표적항암제를 먹는 약(경구제)으로 처방받았어요. 통원인데도 항암약물치료비가 나오나요?

A. 대부분의 항암약물치료 담보는 입원·통원 구분 없이 '항암약물 치료를 받은 경우'를 지급 사유로 합니다. 다만 약관상 인정되는 약제 목록(식약처 허가 항암제 등)과 호르몬제 포함 여부는 상품마다 다르므로 처방 약제명을 확인하세요.

Q. 임상시험으로 신약을 투여받으면 보장되나요?

A. 임상시험 단계의 치료는 대부분의 약관에서 보장하지 않거나 별도 조건을 둡니다. 실손보험에서도 임상시험 비용은 보상 대상이 아닌 경우가 많으므로 참여 전 확인이 필요합니다.

CHAPTER 10 핵심 요약

- 암보험 1→5세대: 진단비 → 이차·재진단 → 신의료기술 → 통합·전이 → **치료비**
- 항암제: 화학 → 표적 → 면역(CAR-T), 방사선: 세기조절 → 양성자 → 중입자
- 치료 담보는 지급 주기·기간·대상 치료·급여 여부·병원 규모를 확인

CHAPTER 11

수술의 분류 — 종수술 표 읽는 법

'1~5종 수술비'는 같은 수술이라도 어디를, 어떤 방식으로 하느냐에 따라 등급이 달라집니다. 수술분류표의 원리를 이해하면 받을 보험금을 미리 계산할 수 있습니다.

약관에서 말하는 '수술'이란

보험약관에서 수술은 **"의사가 피보험자의 질병 또는 재해의 치료를 직접적인 목적으로 필요하다고 인정한 경우로서, 의료기관에서 의사의 관리하에 수술분류표에 정한 기구를 사용하여 생체에 절단(切斷), 절제(切除) 등의 조작을 가하는 것"**을 말합니다. 흡인(吸引, 주사기 등으로 체액·조직을 빨아냄), 천자(穿刺, 바늘이나 관을 꽂아 체액·조직을 뽑아냄), 신경차단(Nerve block) 등의 조치는 수술에 포함되지 않는 것이 일반적입니다.

수술비 담보 중 **1~5종 수술비(종수술비)**는 주로 생명보험사에서 판매하며, 약관의 '수술분류표'에 따라 수술을 1종(가장 가벼운 수술)부터 5종(가장 큰 수술)까지 나누고 등급별로 다른 금액을 지급합니다.

수 술

- 암 수술
- 종수술
- 관혈·비관혈 수술
- 사이버·감마나이프
- 다빈치·레보아이 로봇수술

항암약물치료

- 항암약물치료
- 표적항암 약물치료
- 면역항암 약물치료
- CAR-T 항암약물 허가치료
- 호르몬 약물치료

항암방사선치료

- 항암방사선치료
- 세기조절 방사선치료
- 정위적 방사선치료
- 양성자 방사선치료
- 중입자 가속기

① 일반적인 질병·재해(상해) 치료 목적의 수술

수술분류표 대부분의 항목은 신체 부위별로 수술 방식(관혈적 수술, 절단, 적출 등)에 따라 종을 정합니다. 그런데 최근에는 개복하지 않고 내시경이나 카테터로 하는 수술이 크게 늘었습니다. 이런 수술에 적용되는 핵심 조항이 **88항**입니다.

수술명	수술 종류
88. 내시경(Fiberscope)에 의한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter)·고주파 전극 등에 의한 경피적 수술 수술 개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주해 1회의 수술보험금을 지급하며, 이후 동일한 기준으로 반복 지급 가능	1~3종
88-1. 뇌, 심장	**3종**

수술명	수술 종류
88-2. 흉부, 흉부장기(심장 제외), 복부장기(비뇨·생식기 제외), 척추, 사지관절(손가락·발가락 제외)	**2종**
88-3. 비뇨·생식기 및 손가락·발가락	**1종**

88항 적용의 의미

- 수술분류표의 각 부위별 항목(예: 위 절제술 등) 중 **내시경 또는 카테터 등에 의한 경피적(經皮的) 수술**은 원래 항목이 아니라 88항을 적용합니다. 즉, 같은 위 수술이라도 개복하면 높은 종, 내시경으로 하면 2종입니다.
- 다만 **흉강경·복강경에 의한 수술은 해당 부위의 원래 항목**으로 적용합니다. 복강경 담낭절제술은 88항이 아니라 담낭 수술 항목을 따릅니다.
- 심장 스텐트 삽입(경피적 관상동맥 중재술)은 88-1항 '심장' → 3종에 해당하는 것이 일반적입니다.

② 악성신생물(암)의 치료 목적 수술

수술명	수술 종류
1. 관혈적 악성신생물 근치수술(根治手術, Radical curative surgery) 단, 기타피부암(C44) 제외 / 내시경 수술, 카테터·고주파 전극 등의 경피적 수술 등은 제외	**5종**
1-1. 기타피부암(C44)	3종
2. 내시경 수술, 카테터·고주파 전극 등에 의한 악성신생물 수술 60일 이내 2회 이상 수술은 1회로 간주, 이후 동일 기준으로 반복 지급 가능	3종
3. 상기 이외의 기타 악성신생물 수술 60일 이내 2회 이상 수술은 1회로 간주, 이후 동일 기준으로 반복 지급 가능	3종

- 제자리암·경계성종양에 대한 수술은 '1. 일반 질병 및 상해 치료 목적의 수술' 각 항목을 적용합니다.
- 카테터를 이용한 흡인·천자·약물 주입 요법은 수술에 포함하지 않습니다.
- 비고형암(혈액암 등)에 대한 비관혈적 근치술은 관혈적 악성신생물 근치수술에 준하여 5종으로 인정합니다.

③ 악성신생물 근치·두개내 신생물 근치 방사선 조사

수술명	수술 종류
1. 악성신생물 근치 방사선 조사 5,000rad 이상 조사(照射)하는 경우로 한정하며, 악성신생물 근치 사이버나이프(Cyberknife) 정위적 방사선 치료(定位的 放射線治療, Stereotactic radiotherapy)를 포함	3종

수술명	수술 종류
2. 두개내 신생물 근치 감마나이프(Gammaknife) 정위적 방사선 치료	3종

수술 개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회로 간주해 1회의 수술보험금을 지급하며, 이후 동일한 기준으로 반복 지급 가능.

60일 규칙 — 반복 수술은 어떻게 계산할까

내시경·카테터 수술과 방사선 치료는 짧은 기간에 여러 번 반복되는 경우가 많습니다. 약관은 이를 **수술 개시일부터 60일 이내의 수술은 1회로 간주**하고, 60일이 지난 뒤의 수술은 다시 1회로 보아 반복 지급합니다.

계산 예시 — 방사선 치료를 30회 받은 경우

E씨는 폐암으로 1월 10일부터 2월 20일까지 방사선 치료 30회(총 6,000rad)를 받았고, 재발로 5월 1일부터 다시 방사선 치료를 받았습니다. 1월 10일~3월 10일(60일)의 치료는 **1회(3종)**로 간주되고, 5월 1일부터 시작된 치료는 **새로운 1회(3종)**로 지급됩니다. 결과적으로 3종 수술비를 2회 받게 됩니다.

■ 자주 묻는 종수술 사례

수술	일반적 분류	비고
위암 개복 절제술(근치)	5종	관혈적 악성신생물 근치수술
조기 위암 내시경 점막하 박리술(ESD)	3종	내시경에 의한 악성신생물 수술
대장 용종 내시경 절제(양성)	2종	88-2항(복부장기)
관상동맥 스텐트 삽입술	3종	88-1항(심장)
백내장 수술	상품별 상이	수정체 수술 항목 적용
갑상선암 로봇 절제술	5종	로봇·복강경은 원래 항목 적용
요관결석 체외충격파쇄석술	상품별 상이	약관상 '파쇄술' 항목 확인 필요

※ 일반적인 분류 예시이며 가입 시기·상품별 수술분류표에 따라 다를 수 있습니다. 반드시 약관의 수술분류표를 확인하세요.

Q. 손해보험의 '수술비'도 1~5종으로 나뉘나요?

A. 손해보험은 주로 '질병수술비(모든 수술 동일 금액)', 'N대 질병수술비(특정 질병코드)', '질병종수술비(1~5종 또는 1~7종)' 등을 판매합니다. 손해보험의 종수술 분류는 생명보험과 다를 수 있으니 상품별 분류표를 확인하세요. 자세한 비교는 CHAPTER 15에서 다룹니다.

Q. 같은 날 두 군데를 수술했어요. 수술비가 두 번 나오나요?

A. 약관은 보통 '동시에 두 종류 이상의 수술을 받은 경우 가장 높은 종의 수술비 하나만 지급'하도록 정합니다. 다만 질병수술비나 N대수술비처럼 담보 성격이 다른 경우에는 각각 청구할 수 있으므로 담보별로 확인하세요.

사례 — 같은 담석, 다른 수술비

T씨와 U씨는 같은 시기에 담석증 진단을 받았습니다. T씨는 복강경 담낭절제술을 받아 수술분류표의 '담낭수술' 항목이 적용되었고, U씨는 담관 결석을 내시경(ERCP)으로 제거해 88-2항(복부장기, 2종)이 적용되었습니다. 같은 병이라도 **수술 방식에 따라 종이 달라지고**, 복강경은 원래 항목·내시경은 88항이라는 원칙이 그대로 드러나는 예입니다. 수술 전에 주치의에게 수술 방식(개복·복강경·내시경)을 확인해 두면 받을 보험금을 미리 가늠할 수 있습니다.

CHAPTER 11 핵심 요약

- 내시경·카테터 수술은 88항: 뇌·심장 3종 / 흉복부·척추·관절 2종 / 비뇨생식기·손발가락 1종
- 흉강경·복강경 수술은 원래 부위 항목 적용
- 관혈적 암 근치수술 5종, 내시경 암 수술·방사선(5,000rad 이상) 3종
- 60일 이내 반복 수술은 1회로 간주, 이후 반복 지급

CHAPTER 12

산정특례 제도

암 환자의 병원비가 생각보다 적게 나오는 이유, 바로 산정특례 덕분입니다. 그리고 이제는 민간보험도 산정특례를 기준으로 보험금을 지급합니다.

산정특례란

산정특례는 진료비 부담이 높은 중증질환자와 희귀질환자의 **건강보험 본인부담률을 크게 낮춰 주는 제도**입니다. 일반 환자가 입원 시 20%, 외래 시 30~60%를 부담하는 것과 달리 산정특례 대상자는 5~10%만 부담합니다. 단, 산정특례는 **급여 항목에만** 적용되며 비급여 항목은 본인이 전액 부담합니다.

질병별 산정특례 본인부담률과 적용기간

구분	암	희귀질환	중증치매	중증화상	심장질환	뇌혈관질환	중증외상	결핵	잠복결핵
본인 부담률	5%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	0%	0%
적용 기간	5년	5년	5년	1년	최대 30일	최대 30일 (입원)	최대 30일 (입원)	치료 기간	1년

※ 중증화상은 상태에 따라 연장될 수 있으며, 세부 기준은 국민건강보험공단 고시를 따릅니다.

■ 적용 시작일과 등록 방법

- **등록이 필요한 질환**(암·희귀·중증치매 등): 등록 신청서상의 진단확진일로부터 **30일 이내에 신청하면 '진단확진일'부터**, 30일이 지난 후 신청하면 **'신청일'부터** 적용됩니다. 보통 진단한 병원에서 신청을 대행해 줍니다.
- **등록 절차가 없는 질환**: 심장질환, 뇌혈관질환, 중증외상은 별도 등록 없이 병원 수납 시 자동 적용됩니다.
- **심장질환**: 고시된 상병의 치료를 위해 고시에서 정하는 수술 또는 약제 투여를 받은 경우 최대 30일 적용
- **뇌혈관질환**: 고시된 상병의 치료를 위해 고시에서 정하는 수술을 받는 경우 최대 30일 적용(입원)
- **암 재등록**: 5년이 지난 뒤에도 잔존암·재발암·전이암이 있거나 추가 치료가 필요하면 재등록할 수 있습니다.

산정특례가 바꾼 민간보험 — '산정특례 진단비'

과거 민간보험의 뇌·심장 진단비는 '뇌출혈', '급성심근경색'처럼 좁은 질병코드를 기준으로 했습니다. 최근에는 **"국민건강보험 산정특례 대상으로 진단 또는 치료를 받은 경우"**를 지급 조건으로 하는 담보가 늘었습니다.

산정특례는 질병코드 + 수술·약제 등 실제 치료 요건을 함께 보기 때문에, 진단명이 다소 애매해도 '중증 치료를 받았다면' 보장받을 수 있다는 장점이 있습니다.

산정특례 기반 담보의 장점

- 질병코드 범위가 넓음(뇌혈관 약 97%, 심장 100% 범위 — CHAPTER 13·14)
- 객관적인 건강보험 기준으로 분쟁 감소
- 진단 + 치료 요건으로 실제 중증 환자 보장

확인할 점

- 수술·약제 등 치료 요건 충족이 필요(진단만으로는 불가한 경우)
- 산정특례 기준(고시)이 바뀔 수 있음
- 지급 횟수(최초 1회 / 연간 1회 / 매회)

산정특례와 민간보험은 중복 혜택

산정특례는 건강보험 제도이고, 민간보험은 개인 계약입니다. 따라서 **산정특례로 병원비가 줄었다고 해서 암보험금이 줄지 않습니다.** 진단비·수술비 같은 정액 보험금은 그대로 받습니다. 실손보험은 '실제 부담한 금액'을 기준으로 하므로 산정특례 적용 후 본인부담금을 기준으로 보상합니다.

사례 — 위암 수술 병원비 계산

F씨는 위암 수술로 3주간 입원했고 총진료비(급여) 1,500만 원, 비급여 300만 원이 나왔습니다. 산정특례가 없다면 급여 본인부담 20%인 300만 원을 내야 하지만, 산정특례 5%를 적용하면 **75만 원**으로 줄어듭니다. 여기에 비급여 300만 원을 더한 375만 원이 실제 부담액이고, 실손보험이 있다면 자기부담금을 제외한 금액을 돌려받습니다. 암 진단비와 수술비는 이와 별개로 전액 지급됩니다.

Q. 산정특례 등록을 깜빡했어요. 이미 낸 병원비는 돌려받을 수 없나요?

A. 진단확진일로부터 30일이 지나 신청하면 신청일부터 적용되므로 그 이전 진료비는 소급되지 않는 것이 원칙입니다. 진단 즉시 병원 원무과에 산정특례 등록을 확인하세요.

Q. 갑상선암도 산정특례 대상인가요?

A. 갑상선암도 암(C73)이므로 산정특례 대상입니다. 다만 제자리암 등 일부 신생물은 별도 기준이 적용됩니다.

CHAPTER 12 핵심 요약

- 암·심장·뇌혈관·중증화상·중증외상 5%, 희귀·중증치매 10%, 결핵 0%
- 암·희귀·치매는 등록 필요(진단 30일 이내 신청), 뇌·심장·외상은 자동
- 급여 항목에만 적용, 비급여는 해당 없음
- 민간보험 정액 보험금과 중복 수령 가능

CHAPTER 13

뇌혈관질환 — 진단·치료와 보장 범위

뇌출혈 진단비만 있다면 뇌혈관질환 환자 100명 중 8명만 보장받습니다. 담보 이름에 숨은 '보장 범위'를 확인해야 하는 이유입니다.

뇌·심장 보장이 중요한 이유

주요 질환 사망자 수

암 83,378명(22.4%)
심장질환 33,715명(9.0%)
뇌혈관질환 25,420명(6.8%)

질환별 유병자 수

암 243만 명
심장질환 183만 명
뇌혈관질환 117만 명

주요 만성질환 진료비

순환기계 질환 12조 7천억 원
악성신생물 9조 4천억 원
당뇨병 3조 4천억 원

뇌·심장 질환을 합한 순환기계 질환은 **진료비 1위**입니다. 사망자 수로는 암보다 적지만 유병자 수는 암과 비슷하고, 진료비는 오히려 더 많습니다. 생존 후 오랜 기간 치료·재활·약물 관리가 필요하기 때문입니다.

뇌·심 진단 방법

구분	진단 근거
뇌혈관 진단	병력, 신경학적 검진과 함께 뇌전산화단층촬영(CT), MRI, 뇌혈관조영술, 양전자방출단층술(PET), 뇌척수액검사 등을 기초로 진단
심혈관 진단	심전도, 심장초음파, 관상동맥(심장동맥) 촬영술, 혈액 중 심장효소검사 등 검사 결과가 객관적인 이상 소견을 보이는 경우 진단

뇌·심 치료 방법

구분	내용
수술	**관혈수술** — 심혈관: 관상동맥우회술, 인공심박동기삽입술, 인공판막치환술 등 / 뇌혈관: 경동맥내막절제술, 클립결찰술, 개두술 등
	비관혈수술 — 심혈관: 풍선확장술, 스텐트삽입술, 고주파절제술, 경피적대동맥판치환술 등 / 뇌혈관: 혈관성형술, 기계적 혈전제거술, 코일색전술(카테터) 등
약물	**혈전용해제**: 혈전 속 섬유질을 잘라 혈전을 녹이는 약물 **항응고제**: 혈액을 응고시키는 섬유질 합성을 막는 약물 **항혈소판제**: 혈소판 합성을 막아 혈전 생성을 억제. 질병 진행 및 예방 목적으로 사용

구분	내용
재활	운동치료, 압박치료, 물리치료, 중추신경계 재활치료, 전기자극치료, 기립경사훈련, 보행치료, 일상생활동작 치료

혈관 질환의 종류와 상태에 따라 수술 또는 약물치료 여부를 판단합니다. 최근 보험은 이런 치료 방식을 그대로 담보로 만들어 **혈전용해치료비, 혈전제거술 치료비, 중환자실 입원비, 재활치료비** 등을 보장합니다.

뇌혈관질환의 보장 범위 — 동심원으로 이해하기

뇌 관련 진단비는 이름에 따라 보장하는 질병코드 범위가 다릅니다. 건강보험심사평가원 질병통계(2021)를 바탕으로 뇌혈관 관련 환자 분포를 보면 다음과 같습니다.



자료: 건강보험심사평가원 질병통계(2021), 보건의료빅데이터개방시스템 기반 분석. 비율은 산정특례 및 뇌혈관질환 관련 상병 전체 대비 환자 비율.

- **뇌혈관질환/산정특례 공통: 80.73%** — 두 담보 모두에서 보장되는 영역
- **산정특례에만 해당: 16.27%** — 외상성 뇌손상(S06) 수술, 대동맥 관련 일부 등
- **뇌혈관질환에만 해당(산정특례 예외): 3.00%** — I68, I69(후유증 등)

■ 뇌혈관질환 상병코드별 비율

코드	질병명	비율	포함되는 담보
I60	지주막하출혈	2.65%	뇌출혈 8%
I61	뇌내출혈	4.34%	
I62	기타 비외상성 두개 내 출혈	0.69%	
I63	뇌경색증	**36.70%**	뇌졸중 56%
I65	뇌경색증을 유발하지 않는 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착	8.71%	
I66	뇌경색증을 유발하지 않는 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착	3.37%	
I64	출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중	1.54%	뇌혈관질환 83%
I67	기타 뇌혈관 질환	**22.75%**	
I68	달리 분류된 질환에서의 뇌혈관 장애	0.27%	
I69	뇌혈관 질환의 후유증	2.73%	

※ 뇌졸중의 코드 범위는 상품마다 다를 수 있습니다(I64 포함 여부 등). 반드시 약관의 '정의' 조항을 확인하세요.

■ 산정특례 뇌혈관질환의 요건

요건	해당 상병(비율)
상병명 진단 후 **수술**	I60~I67(80.73%) / I72.0(0.11%) / I77.0(0.06%) / Q28.0~Q28.3(0.52%) / S06(15.58%)
발병 후 90일 이내 **입원**	I60~I62 뇌출혈(7.67%)
NIHSS(뇌졸중 척도) **5점 이상**	I63 뇌경색(36.70%)

I68, I69는 산정특례에서 제외되는 상병명입니다. 산정특례 담보와 뇌혈관질환 담보를 함께 가지고 있으면 두 영역의 빈틈을 서로 메울 수 있습니다.

■ 뇌 순환계 질환 분류(I60~I98)

코드	질병 분류명
I60~I69	**뇌혈관질환**
I70	죽상경화증
I71	대동맥 동맥류 및 박리
I72	기타 동맥류 및 박리
I73	기타 말초 혈관질환
I74	동맥색전증 및 혈전증
I77~I79	동맥 및 세동맥의 기타 장애, 모세혈관의 질환 등
I80~I82	정맥염 및 혈전정맥염, 문맥 혈전증, 기타 정맥의 색전증 및 혈전증
I85~I89	식도 정맥류, 기타 부위의 정맥류, 비특이성 림프절염 등
I97~I98	달리 분류되지 않은 순환계통의 처치 후 장애 등

뇌 보장, 이렇게 설계하세요

1단계 · 넓은 진단비
뇌혈관질환(I60~I69) 진단비로 기본 확보

›

2단계 · 중증 가산
뇌졸중·뇌출혈 진단비로 중증 시 추가

›

3단계 · 치료비
혈전용해·혈전제거·수술비, 산정특례 진단비

›

4단계 · 생존 후
후유장해, 간병·장기요양

사례 — 담보 이름이 가른 3,000만 원

58세 G씨는 갑작스러운 어지럼증으로 응급실에 갔고, 뇌혈관조영술 결과 '뇌경색을 유발하지 않은 뇌전동맥 협착(I65)'으로 스텐트 시술을 받았습니다. G씨의 보험에는 '뇌출혈 진단비 3,000만 원'만 있었기 때문에 진단비를 한 푼도 받지 못했습니다. 만약 '뇌혈관질환 진단비'나 '뇌졸중 진단비'(I65 포함 상품)가 있었다면 진단비를 받을 수 있었고, 산정특례 뇌혈관질환 담보가 있었다면 시술(수술) 요건으로도 보장받을 수 있었습니다.

Q. 일과성 뇌허혈발작(TIA, G45)은 보장되나요?

A. G45는 신경계 질환(G코드)으로 분류되어 대부분의 뇌혈관질환(I60~I69) 진단비에 포함되지 않습니다. 일부 상품은 '뇌혈관질환' 정의에 별도로 포함하기도 하므로 약관을 확인하세요.

Q. MRI에서 '열공성 뇌경색'이 발견되었는데 진단비를 받을 수 있나요?

A. 무증상 열공성 뇌경색도 I63으로 진단되면 뇌졸중 진단비 지급 대상이 될 수 있습니다. 다만 과거 병변(진구성)인지, 가입 전 이미 있었던 병변인지에 따라 분쟁이 생길 수 있어 영상 판독 소견이 중요합니다.

CHAPTER 13 핵심 요약

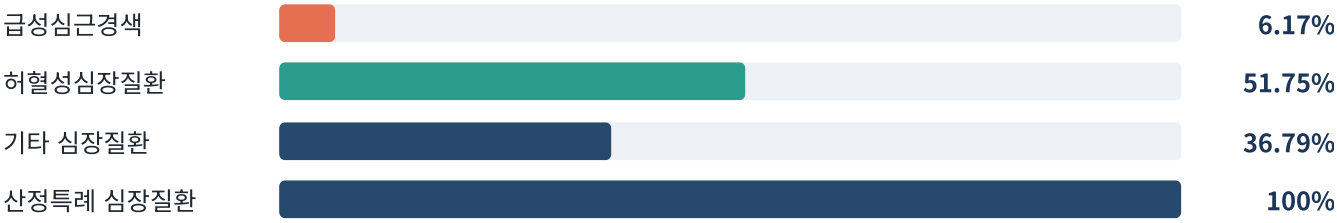
- 순환기계 질환은 진료비 1위(12.7조 원)
- 뇌출혈 8% → 뇌졸중 56% → 뇌혈관질환 83% → 산정특례 97%
- I68·I69는 산정특례 제외, S06 등은 산정특례에만 포함 → 두 담보로 상호 보완
- 진단비 + 치료비 + 후유장해·간병의 4단계 설계

CHAPTER 14

심장질환 — 보장 범위와 상병코드

급성심근경색 진단비가 보장하는 범위는 심장질환 전체의 약 6%입니다. 나머지 94%는 어떻게 대비할까요?

심장질환의 보장 범위



자료: 건강보험심사평가원 질병통계(2021), 보건의료빅데이터개방시스템 기반 분석. 산정특례 심장질환 상병 전체를 100%로 본 비율.

기타 심장질환 중에서는 **심방세동 및 조동(12.76%), 기타 부정맥(7.81%), 심부전(7.55%)**의 비중이 큽니다. 고령화와 함께 부정맥과 심부전 환자가 빠르게 늘고 있지만, 이들은 허혈성심장질환 진단비에 포함되지 않습니다.

산정특례 심장질환 상병명

허혈성심장질환 51.75%

코드	질병명	비율
I21	**급성심근경색증**	**6.10%**
I22	**후속심근경색증**	**0.04%**
I23	**급성심근경색증 후 특정 현존 합병증**	**0.03%**
I20	협심증	34.71%
I24	기타 급성 허혈성 심장질환	0.18%
I25	만성 허혈성 심장병	10.69%

음영 = 급성심근경색 담보 범위(6.17%)

기타 심장질환 36.79%

코드	질병명	비율
I30~I41	급성심장막염~심근염	3.71%
I42	심근병증	2.31%
I43	달리 분류된 질환에서의 심근병증	0.01%
I46.0	인공소생에 성공한 심장정지	0.23%
I47	발작성 빈맥	2.41%
I48	**심방세동 및 조동**	**12.76%**
I49	기타 심장 부정맥	7.81%
I50	심부전	7.55%

■ 상병명 진단 후 수술 또는 약제 투여 요건

상병	비율	상병	비율	상병	비율
D15.1	0.05%	I70.0	0.24%	Q20~Q25	3.16%

상병	비율	상병	비율	상병	비율
I01	0.01%	I71	1.52%	Q26.0~26.4/26.8/26.9	0.04%
I05~I09	1.01%	I79.0/I79.1	0.03%	S25~S26	0.02%
I20~I25	51.75%	M31.4	0.08%		
I26/I28	0.87%	I30~I51	41.21%		

자료: 보건복지부 고시 제2021-362호(2022.3.1 시행) 기반. 산정특례는 고시된 상병의 치료를 위해 고시에서 정하는 수술 또는 약제 투여를 받은 경우 최대 30일 적용.

심장 순환계질환 분류(I00~I52)

코드	질병 분류명	코드	질병 분류명
I00~I02	급성 류마티스열	I38	상세불명 판막의 심내막염
I05~I09	만성 류마티스 심장질환	I39	달리 분류된 질환에서의 심내막염 및 심장판막장애
I20~I25	**허혈성 심장질환**	I40	급성 심근염
I26	폐색전증	I41	달리 분류된 질환에서의 심근염
I27	기타 폐성 심장질환	I42~I43	심근병증
I28	폐혈관의 기타 질환	I44	방실차단 및 좌각차단
I30	급성 심장막염	I45	기타 전도장애
I31	심장막의 기타 질환	I46.0	인공소생에 성공한 심장정지
I32	달리 분류된 질환에서의 심장막염	I47	발작성 빈맥
I33	급성 및 아급성 심내막염	I48	심방세동 및 조동
I34~I37	비류마티스성 승모판·대동맥판 등 장애	I49	기타 부정맥
		I50	심부전
		I51~I52	심장병의 불명확한 기록 및 합병증, 달리 분류된 질환에서의 기타 심장장애

심장 담보 단계별 이해

담보	보장 범위	평가
급성심근경색 진단비	I21~I23	가장 좁음(약 6%)
허혈성심장질환 진단비	I20~I25(협심증 포함)	약 52%

담보	보장 범위	평가
심혈관질환·주요 심장질환 진단비	허혈성 + 부정맥·심부전·심근병증 등(상품별 정의)	넓음
산정특례 심장질환 진단비	산정특례 대상 상병 + 수술·약제 요건	가장 넓음
심장 수술비·시술비	스텐트, 관상동맥우회술, 판막수술, 고주파절제술 등	치료 단계 보장

사례 — 심방세동으로 고주파절제술을 받은 H씨

55세 H씨는 가슴 두근거림으로 병원을 찾았다가 심방세동(I48) 진단을 받고 고주파 전극도자 절제술을 받았습니다. H씨의 보험에는 '급성심근경색 진단비'와 '허혈성심장질환 진단비'가 있었지만, 심방세동은 허혈성이 아니어서 진단비를 받지 못했습니다. 심혈관질환 진단비 또는 산정특례 심장질환 진단비가 있었다면 보장받을 수 있었고, 1~5종 수술비에서는 88-1항(심장, 카테터)에 따라 3종 수술비를 받을 수 있었습니다.

Q. 협심증으로 약만 먹고 있어요. 허혈성심장질환 진단비를 받을 수 있나요?

A. 약관상 진단 요건(심전도·관상동맥 조영술 등 검사 결과에 의한 진단)을 충족하면 협심증(I20)도 허혈성심장질환 진단비 대상입니다. 다만 가입 전부터 앓던 질환이라면 알릴의무 문제가 생길 수 있습니다.

Q. 스텐트를 두 번 넣으면 수술비도 두 번 나오나요?

A. 종수술비는 수술 개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술을 1회로 보는 경우가 많습니다. 60일이 지나 다시 시술하면 새로 지급될 수 있습니다. 질병수술비는 상품별로 '매회' 지급 여부를 확인하세요.

Q. 심장 스텐트 시술을 받으면 어떤 담보를 청구할 수 있나요?

A. 진단명이 협심증(I20)이나 급성심근경색(I21)이라면 해당 진단비(허혈성·급성심근경색), 산정특례 심장질환 진단비(시술 요건 충족 시), 1~5종 수술비(88-1항 심장 3종), 질병수술비, 심혈관 수술·시술비 담보, 입원일당과 실손을 함께 청구할 수 있습니다. 진단서의 코드와 시술 확인서의 수술명을 함께 준비하세요.

Q. 심전도에서 '부정맥 의심' 소견을 받았는데 보험 가입에 문제가 되나요?

A. 건강검진에서 이상 소견을 받고 추가검사(재검사)를 했다면 1년 이내 추가검사 질문, 진단이나 치료가 있었다면 3개월·5년 질문에 해당할 수 있습니다. 사실대로 알리고 결과지를 함께 제출하면 정상 판정 시 조건 없이 인수되는 경우도 많습니다.

CHAPTER 14 핵심 요약

- 급성심근경색 6% / 허혈성 52% / 기타 심장질환 37% / 산정특례 100%
- 심방세동·부정맥·심부전은 허혈성 담보로 보장되지 않음
- 허혈성 + 심혈관(또는 산정특례) 진단비 + 심장 수술비로 3중 대비

■ 3대 질병 점검 체크리스트

- [ ] 일반암 진단비와 유사암 진단비 금액, 유사암 분류 기준을 확인했다.
- [ ] 암 주요치료비(반복 지급)와 표적·면역항암 담보 유무를 확인했다.
- [ ] 뇌 담보가 뇌출혈뿐인지, 뇌혈관질환까지 넓은지 확인했다.
- [ ] 심장 담보가 급성심근경색뿐인지, 허혈성·심혈관까지 넓은지 확인했다.
- [ ] 산정특례 기반 진단비가 있는지 확인했다.
- [ ] 3대 진단비가 비갱신형인지, 몇 세까지 보장되는지 확인했다.

PART 4

수술비

수술비는 가장 자주 청구되는 담보 중 하나입니다. 그런데 '수술비'라는 이름 아래 보장 방식이 전혀 다른 네 가지 담보가 존재합니다. 수술 기술이 바뀌면서 어떤 담보가 유리한지도 달라지고 있습니다.

15 수술 트렌드의 변화와 수술비 담보의 종류

16 통계로 보는 주요 수술 — 건수·진료비·입원일수

CHAPTER 15

수술 트렌드의 변화와 수술비 담보의 종류

배를 열던 수술에서 칼을 대지 않는 시술로. 수술이 작아질수록 '어떤 수술비 담보를 가졌는가'가 보험금을 좌우합니다.

수술의 네 세대

세대	수술 방식	대표 예	특징
1세대	관혈 수술	개두, 개흉, 개복	수술 후 상처가 크고 회복이 느림
2세대	비관혈 수술	복강경, 흉강경	합병증이나 부작용이 덜한 최소 침습 수술
3세대	경피적 수술	내시경, 카테터	신체에 부담은 적으나 나이·연령·기저질환 등을 고려하여 시행
4세대	첨단 수술	초음파, 무절개, 시술	신체 부담이 적어 일상적·반복적으로 시행 가능

이 변화는 환자에게는 반가운 일이지만 보험에서는 새로운 문제를 낳았습니다. 과거 수술비 담보는 '절제·절단' 같은 관혈적 수술을 전제로 만들어졌기 때문에, 흡인·천자·신경차단술처럼 칼을 대지 않는 시술은 '수술'로 인정받지 못하는 경우가 많았습니다. 그 결과 시술을 받고도 수술비를 못 받는 분쟁이 늘었고, 이를 보완하는 새로운 수술비 담보가 등장했습니다.

수술비 담보 4종류 비교

구분	질병수술비	N대수술비	1~5종수술비	ADRG종수술비
보장 기준	**[포괄주의]** 약관에 규정된 보상하지 않는 손해 외 일괄 보장	**[열거주의]** 약관에 규정된 **질병분류코드**에 따라 차등 보장	**[열거주의]** 약관에 규정된 **신체 부위, 분류별 수술 방식**에 따라 차등 보장	**[열거주의]** 약관상 규정된 **수술코드**에 따라 차등 보장
보장 조건	절제/절단	절제/절단	절제/절단	절제/절단/흡인/천자
보장 횟수	매회 또는 연간 1회	매회 지급	매회 또는 연간 1회	수술코드당 연간 1회 또는 연간 3회
장점	모든 경우 동일 보장, 보장 범위 넓음	관혈/비관혈 구분 없음, 양성종양 등 보장이 큼	급여/비급여 모두 보장, 감액 조건 없음	흡인·천자·신경차단술·창상봉합술 등 보장, 관혈/비관혈 모두 보장

구분	질병수술비	N대수술비	1~5종수술비	ADRG종수술비
단점	보장 금액이 낮음	암 수술 보장 취약, 1년 내 감액 지급	관혈 위주 보장, 흡인·천자·신경차단술 등 보상 불가	급여만 보장, 수술코드 해당 시에만 보장

담보별 자세히 보기

■ ① 질병수술비 — 넓지만 얕은 보장

질병수술비는 '보상하지 않는 손해'로 열거된 것만 빼고 질병으로 인한 수술이라면 모두 같은 금액을 지급하는 **포괄주의** 담보입니다. 백내장 수술이든 위암 수술이든 같은 금액(예: 30만 원)을 지급합니다. 보장 범위가 넓어 자주 받을 수 있지만 금액은 작습니다. 소액이지만 '빈도'가 높은 수술(백내장, 치핵, 용종 절제 등)을 대비하는 기본 담보로 적합합니다.

■ ② N대수술비 — 특정 질병의 수술을 크게

64대·119대 등 약관에 열거된 질병분류코드에 해당하는 질병으로 수술받을 때 지급합니다. 질병 기준이기 때문에 수술 방식(관혈·비관혈)을 따지지 않는다는 장점이 있습니다. 반면 열거된 질병에 해당하지 않으면 지급되지 않고, 암은 별도 암수술비로 빼 두는 경우가 많아 암 수술 보장이 약할 수 있습니다. 가입 후 1년 이내에는 50% 감액 지급하는 조건이 붙기도 합니다.

■ ③ 1~5종수술비 — 수술의 크기에 비례

CHAPTER 11에서 본 수술분류표에 따라 신체 부위와 수술 방식으로 종을 나누어 지급합니다. 급여·비급여를 가리지 않고, 감액 조건이 없는 경우가 많습니다. 다만 수술분류표가 관혈적 수술 위주로 되어 있어 흡인·천자·신경차단술 등은 보상되지 않습니다.

■ ④ ADRG 종수술비 — 시술의 시대를 반영

ADRG(Adjacent Diagnosis Related Group)는 건강보험 진료비 청구에 쓰이는 분류 체계입니다. ADRG 기반 종수술비는 **건강보험의 수술 행위 코드**를 기준으로 종을 나누어 지급합니다. 건강보험이 수술로 인정해 코드를 부여한 행위라면 흡인·천자·신경차단술·창상봉합술 등도 보장받을 수 있는 것이 가장 큰 장점입니다. 대신 **급여 항목만** 보장하고, 같은 수술코드는 연간 1회(또는 3회)로 한도가 있습니다.

추천 조합

- **기본**: 질병수술비(빈도 대비) + 1~5종수술비(크기 대비)
- **보완**: ADRG 종수술비(시술·급여 대비) — 척추 신경차단술, 관절 주사 시술이 잦은 중장년층에게 유용
- **선택**: N대수술비 — 특정 질병(부인과·소화기 양성종양 등) 가족력이 있는 경우
- **별도**: 암수술비, 뇌·심장 혈관수술비는 질병별 전용 담보로 준비

같은 시술, 담보마다 다른 결과

시술 예	질병수술비	N대수술비	1~5종	ADRG
복강경 담낭절제술	○	○(해당 코드 시)	○	○
척추 신경차단술	×	×	×	○(급여 시)
무릎 관절강 천자	×	×	×	○(급여 시)
열상 창상봉합술	× (상해수술비 해당 여부 확인)	×	상품별	○(급여 시)
대장 용종 내시경 절제	○	○(해당 코드 시)	○(2종)	○
비급여 로봇수술	○	○(해당 코드 시)	○	급여 수술 부분만

※ 일반적인 경향을 보여 주는 예시이며 상품·약관별로 다릅니다.

어디서 수술을 많이 받을까 — 요양기관 종별 점유율

국민건강보험공단 「주요수술통계」(2023)에 따르면 2023년 주요 수술 건수의 점유율은 의원 34.3%, 종합병원 24.0%, 상급종합병원 21.5%, 병원 20.2%입니다.



■ 연도별 점유율 추이

구분	2019	2020	2021	2022	2023
의원	37.7	39.3	39.4	38.1	**34.3**
종합병원	21.8	21.5	21.2	22.3	**24.0**

구분	2019	2020	2021	2022	2023
상급종합병원	19.9	18.8	19.6	20.1	**21.5**
병원	20.5	20.4	19.8	19.5	**20.2**

자료: 국민건강보험공단 「2023년 주요수술통계」. 단위: %.

의원급 수술 비중은 줄고 **종합병원·상급종합병원의 비중이 늘고 있습니다.** 백내장처럼 의원에서 주로 하던 수술 건수가 줄어든 영향도 있지만, 큰 병원에서 수술받는 환자가 늘었다는 뜻이기도 합니다. 큰 병원일수록 비급여와 상급병실 비용 등이 늘어나므로, '종합병원·상급종합병원 수술 시 가산' 조건이 붙은 수술비 담보도 검토해 볼 만합니다.

Q. 수술비 담보가 여러 개면 한 번 수술에 모두 받을 수 있나요?

A. 수술비는 정액보상이므로 각 담보의 지급 조건을 충족하면 모두 받을 수 있습니다. 예를 들어 질병수술비 30만 원, 3종 수술비 100만 원, ADRG 수술비 50만 원이 있다면 해당 수술 하나로 세 가지를 모두 청구할 수 있습니다.

Q. '시술'이라고 했는데 수술비 청구가 되나요?

A. 병원에서 '시술'이라 불러도 약관상 수술 정의(기구를 사용한 절단·절제 등)나 수술분류표, 건강보험 수술코드에 해당하면 수술비를 받을 수 있습니다. 진료비 세부내역서의 행위 코드를 확인하세요.

CHAPTER 15 핵심 요약

- 수술은 관혈 → 비관혈 → 경피적 → 첨단(무절개)으로 진화
- 질병수술비(포괄·소액) / N대(질병코드) / 1~5종(부위·방식) / ADRG(수술코드·급여)
- 시술이 잦은 중장년층은 ADRG 종수술비로 흡인·천자·신경차단술까지 보완

CHAPTER 16

통계로 보는 주요 수술 — 건수·진료비·입원일수

가장 많이 받는 수술, 가장 비싼 수술, 가장 오래 입원하는 수술. 숫자로 보면 내게 필요한 수술 보장이 보입니다.

가장 많이 받는 수술 TOP 7

국민건강보험공단이 관리하는 34개 주요 수술의 인구 10만 명당 수술 건수입니다.

순위	구분	2019	2020	2021	2022	2023	전년비	연평균 (2019~)
	계(34개 주요수술)	3,775	3,695	3,963	3,906	**3,768**	-3.5	0.0
1	백내장수술	1,305	1,329	1,476	1,390	**1,204**	-13.4	-2.0
2	제왕절개수술	580	554	559	575	**555**	-3.4	-1.1
3	일반 척추수술	348	356	380	385	**390**	1.3	2.9
4	치핵 수술	323	321	303	296	**287**	-3.0	-2.9
5	담낭절제술	160	163	175	177	**183**	3.2	3.5
6	슬관절 치환술	150	137	147	156	**168**	7.5	2.8
7	내시경 및 경피적 담도수술	103	110	145	151	**161**	6.3	11.7

자료: 국민건강보험공단 「2023년 주요수술통계」. 단위: 건(인구 10만 명당), %.

눈에 띄는 것은 **내시경 및 경피적 담도수술의 연평균 11.7% 증가**입니다. 앞 장에서 본 '경피적 수술' 시대가 통계로 확인되는 대목입니다. 척추수술·슬관절 치환술·담낭절제술도 꾸준히 늘고 있는데, 모두 고령화와 관련 깊은 수술입니다.

가장 많은 진료비가 드는 수술 TOP 7

순위	구분	2019	2021	2022	2023	전년비	연평균
	계(34개 주요수술)	6,702,970	7,798,488	8,082,345	**8,440,369**	4.4	5.9
1	일반 척추수술	800,156	987,697	973,836	**1,015,728**	4.3	6.1
2	슬관절 치환술	720,060	729,861	770,331	**839,713**	9.0	3.9
3	백내장수술	716,732	922,403	895,866	**823,419**	-8.1	3.5

순위	구분	2019	2021	2022	2023	전년비	연평균
4	경피적 관상동맥중재술(스텐트)	697,586	782,378	780,983	**811,678**	3.9	3.9
5	내시경 및 경피적 담도수술	331,688	547,765	564,359	**628,019**	11.3	17.3
6	담낭절제술	413,972	469,121	484,863	**520,275**	7.3	5.9
7	심박조율장치 삽입·교체·제거 및 교정	221,389	322,643	403,268	**449,071**	11.4	19.3

자료: 국민건강보험공단 「2023년 주요수술통계」. 단위: 백만 원, %. 건강보험 및 의료급여 진료비 기준, 비급여 제외.

34개 주요 수술의 총진료비는 2023년 **8조 4,404억 원**으로 2019년 이후 연평균 5.9% 늘었습니다. 2023년 진료비 상위 7개 수술의 점유율은 일반 척추수술 12.0%, 슬관절 치환술 9.9%, 백내장수술 9.8%, 스텐트 9.6%, 담도수술 7.4%, 담낭절제술 6.2%, 심박조율장치 5.3%입니다. 특히 **심박조율장치 관련 수술비는 연평균 19.3%**로 가장 빠르게 늘고 있는데, 고령화로 부정맥 환자가 늘어난 영향입니다(CHAPTER 14 참고).

수술 1건당 진료비 — 가장 비싼 수술

구분	2019	2020	2021	2022	2023	전년비	연평균
계(34개 주요수술)	3,358	3,593	3,718	3,909	**4,229**	8.2	5.9
1. 심장 수술	35,393	32,901	34,364	34,972	**36,828**	5.3	1.0
2. 관상동맥우회술	32,390	33,298	34,405	33,785	**35,249**	4.3	2.1
3. 줄기세포 이식술	—	—	—	34,184	**23,229**	-32.0	—

자료: 국민건강보험공단 「2023년 주요수술통계」. 단위: 천 원. 급여 진료비 기준.

심장 수술 1건의 평균 급여 진료비는 약 **3,683만 원**, 관상동맥우회술은 약 **3,525만 원**입니다. 산정특례(5%)를 적용하면 본인부담은 200만 원 안팎으로 줄지만, 여기에 비급여(로봇·특수재료·상급병실)와 간병비, 소득 공백이 더해집니다. 뇌·심장 수술비 담보가 필요한 이유입니다.

수술 1건당 입원일수 — 가장 오래 입원하는 수술

구분	수술	2019	2020	2021	2022	2023
계(34개 주요수술)		5.6	5.4	5.3	5.4	**5.6**

구분	수술	2019	2020	2021	2022	2023
상위	줄기세포 이식술	—	—	—	29.4	**20.3**
	슬관절 치환술	21.1	20.4	20.0	19.4	**19.5**
	고관절 치환술	19.7	18.6	18.0	17.2	**17.5**
하위	백내장수술	1.1	1.1	1.1	1.1	**1.1**
	정맥류 결찰 및 제거수술	2.2	2.1	2.1	2.0	**2.1**
	치핵수술	2.7	2.6	2.5	2.4	**2.3**

자료: 국민건강보험공단 「2023년 주요수술통계」. 단위: 일.

평균 입원일수는 5.6일로 짧아졌지만, **관절 치환술은 약 20일** 가까이 입원합니다. 이 기간에는 간병인이 필요한 경우가 많아 하루 12~15만 원 안팎의 간병비가 발생할 수 있습니다. 관절 수술 위험이 높은 50대 이후라면 수술비와 함께 **간병인 사용·지원 일당** 담보를 검토할 만합니다(CHAPTER 19 참고).

통계를 보장으로 바꾸기

통계	보장 시사점
백내장·치핵 — 빈도 높고 입원 짧음	질병수술비(소액·포괄)로 대비. 실손에서 백내장 다초점렌즈 등 비급여 분쟁 주의
척추·관절 — 건수·진료비 모두 증가	1~5종 수술비 + ADRG(신경차단술 등) + 간병 일당 + 질병후유장해(인공관절)
심장·관상동맥 — 건당 진료비 최고	심장 전용 수술비(관상동맥우회술·판막·스텐트), 산정특례 진단비
담도·담낭 — 경피적 수술 급증	88항(2종) 적용 확인, 질병수술비 매회 지급 여부

사례 — 무릎 인공관절 수술 한 번에 받은 보험금

67세 R씨는 퇴행성 관절염으로 한쪽 무릎 인공관절 치환술을 받고 20일간 입원했습니다. R씨가 받은 보험금은 ① 1~5종 수술비(관절 치환 해당 종) ② 질병수술비 ③ 질병 입원일당 20일분 ④ 간병인 사용 일당 20일분 ⑤ 실손 의료비(자기부담 제외) ⑥ 질병후유장해(인공관절 삽입 20% × 가입금액)였습니다. 수술 한 번에 여섯 가지 담보가 움직인 셈입니다. 특히 질병후유장해는 많은 사람이 놓치는 담보이므로, 관절 치환술을 받았다면 꼭 확인하세요.

CHAPTER 16 핵심 요약

- 건수 1위 백내장, 진료비 1위 일반 척추수술, 건당 진료비 1위 심장 수술(약 3,683만 원)
- 담도 경피적 수술(연 11.7%↑)·심박조율장치(진료비 연 19.3%↑) 급증
- 관절 치환술 입원 약 20일 → 간병 대비 필요

■ 점검 체크리스트

- [ ] 질병수술비가 매회 지급인지 연간 1회인지 확인했다.
- [ ] 1~5종 수술비의 종별 금액을 확인했다.
- [ ] 신경차단술 등 시술을 보장하는 ADRG 수술비가 있는지 확인했다.
- [ ] 심장·뇌혈관 수술 전용 담보가 있는지 확인했다.

PART 5

장기요양 · 치매 · 간병

평균수명 90세 시대, 오래 살면서 돌봄이 필요해지는 위험은 누구에게나 찾아옵니다. 국가의 노인장기요양보험이 어디까지 지원하는지, 치매는 어떤 기준(CDR)으로 평가되는지, 그리고 간병비는 어떻게 대비하는지를 한데 묶어 정리합니다.

17 공적 장기요양보험과 노인성 질환

18 장기요양 등급과 비용, 치매 척도(CDR)

19 장기요양 이용 현황, 요양병원과 요양원, 간병보험

CHAPTER 17

공적 장기요양보험과 노인성 질환

치매나 뇌졸중으로 혼자 생활하기 어려워졌을 때 국가가 돌봄 비용의 대부분을 지원하는 제도, 노인장기요양보험을 알아봅니다.

노인장기요양보험이란

노인장기요양보험은 고령이나 노인성 질병으로 혼자서 일상생활을 하기 어려운 사람에게 신체활동·가사활동 지원 등의 장기요양급여를 제공하는 사회보험입니다. 2008년 도입되었으며, 건강보험료에 장기요양보험료가 함께 부과되어 **전 국민이 가입 대상**입니다. 국민건강보험공단이 운영합니다.

신청 대상

- 65세 이상인 사람
- 65세 미만이지만 **노인성 질환**이 있는 사람

수급 대상

6개월 이상 혼자서 일상생활을 수행하기 어려워 장기요양 수급자로 판정받은 경우

여기서 중요한 점은 **65세 미만이라도 노인성 질환이 있으면 신청할 수 있다**는 것입니다. 50대에 뇌졸중이나 조기 치매(초로기 치매)가 생긴 경우에도 장기요양 서비스를 받을 수 있습니다.

노인성 질환의 범위

No	질병명	코드	No	질병명	코드
1	알츠하이머병에서의 치매	F00	13	기타 뇌혈관 질환	I67
2	혈관성 치매	F01	14	달리 분류된 질환에서의 뇌혈관 장애	I68
3	달리 분류된 기타 질환에서의 치매	F02	15	뇌혈관 질환의 후유증	I69
4	상세불명의 치매	F03	16	파킨슨병	G20
5	알츠하이머병	G30	17	이차성 파킨슨증	G21
6	지주막하출혈	I60	18	달리 분류된 질환에서의 파킨슨증	G22
7	뇌내출혈	I61	19	척추성 근위축 및 관련 증후군	G12
8	기타 비외상성 두개내 출혈	I62	20	달리 분류된 질환에서의 일차적으로 중추신경계통에 영향을 주는 계통성 위축	G13
9	뇌경색증	I63	21	기저핵의 기타 퇴행성 질환	G23
10	출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중	I64	22	다발경화증	G35

No	질병명	코드	No	질병명	코드
11	대뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착	I65	23	진전(상세불명의 떨림)	R25.1
12	뇌경색증을 유발하지 않은 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착	I66	24	중풍후유증	U23.4

자료: 노인장기요양보험법 시행령 별표, 국민건강보험공단(2025.1.1 기준).

- 노인성 질환은 **치매 질환군 / 뇌혈관 질환군 / 파킨슨 질환군 / 기타 질환군**으로 나뉩니다.
- 이 중 **뇌혈관 질환군(6~15번)은 젊은 층에서도 자주 발병하는 질병**입니다. 40~50대 뇌졸중 환자도 장기요양을 신청할 수 있다는 점을 기억하세요.

장기요양급여의 종류

재가급여 (집에서 받는 서비스)

- **방문요양**: 요양보호사가 집을 방문해 신체·가사 활동 지원
- **방문목욕**: 목욕 장비를 갖추고 방문해 목욕 제공
- **방문간호**: 간호사 등이 의사 지시서에 따라 간호·진료 보조
- **주·야간보호**: 하루 중 일정 시간 기관에서 보호 (이른바 '노치원')
- **단기보호**: 일정 기간 기관에 입소해 보호
- **기타 재가급여(복지용구)**: 휠체어·전동침대·보행기 등 구입·대여

본인부담 15%

시설급여 (시설에 입소)

- **노인요양시설**(요양원): 입소 정원 10명 이상
- **노인요양공동생활가정**: 입소 정원 5~9명, 가정과 같은 환경

본인부담 20%

※ 비급여(식재료비, 상급침실 이용료, 이·미용비 등)는 전액 본인부담

■ 공단 지원과 민간보험의 관계

수급자	›	재가 이용	›	시설 이용	›	민간보험
장기요양 등급 판정		공단 85% 지원 본인부담 15%		공단 80% 지원 본인부담 20%		재가·시설급여 이용 시 보험금 지급(상품별)

최근 민간보험사들은 '장기요양 재가급여 지원금', '장기요양 시설급여 지원금'처럼 **공단 급여를 실제로 이용할 때마다** 보험금을 주는 담보를 판매합니다. 공단 지원 후 남는 본인부담금과 비급여 비용을 메우는 용도입니다.

신청부터 이용까지

① 신청
공단 지사·홈페이지·앱 (가족 대리 신청 가능)

›

② 방문조사
공단 직원이 방문해 심신 상태 조사

›

③ 의사소견서
65세 미만 등 필요 시 제출

›

④ 등급판정
등급판정위원회 심의(신청 후 30일 이내 원칙)

›

⑤ 이용
장기요양인정서·개인별 이용계획서 수령 후 기관과 계약

Q. 부모님이 아직 걸으실 수 있는데 장기요양 신청이 가능할까요?

A. 걷는 것만이 기준은 아닙니다. 식사·목욕·옷 입기·화장실 이용 같은 신체 기능과 인지 기능, 행동 변화, 간호·재활 필요도를 종합 평가합니다. 치매 초기라도 '인지지원등급'으로 주·야간보호를 이용할 수 있습니다.

Q. 기초생활수급자도 본인부담금을 내야 하나요?

A. 국민기초생활수급자는 본인부담금이 면제되고, 의료급여 수급자·차상위계층·저소득층은 본인부담금을 40% 또는 60% 감경받을 수 있습니다.

CHAPTER 17 핵심 요약

- 65세 이상 또는 **65세 미만 노인성 질환자**가 신청, 6개월 이상 일상생활 곤란 시 수급
- 노인성 질환 = 치매·뇌혈관·파킨슨·기타 질환군(뇌혈관은 젊은 층도 빈발)
- 재가급여 본인부담 15%, 시설급여 20%, 비급여는 전액 본인부담

CHAPTER 18

장기요양 등급과 비용, 치매 척도(CDR)

몇 등급을 받느냐에 따라 한 달에 쓸 수 있는 금액이 두 배 가까이 차이 납니다. 민간 간병·치매보험의 보험금도 이 등급과 CDR 점수를 기준으로 지급됩니다.

장기요양 등급별 기준

등급	심신의 기능 상태	장기요양 인정점수	이용 가능 급여
1등급	심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 **전적으로** 다른 사람의 도움이 필요한 자	95점 이상	재가급여 또는 시설급여
2등급	일상생활에서 **상당 부분** 다른 사람의 도움이 필요한 자	75점~94점	
3등급	일상생활에서 **부분적으로** 다른 사람의 도움이 필요한 자	60점~74점	재가급여 (시설급여로 변경 가능)
4등급	일상생활에서 **일정 부분** 다른 사람의 도움이 필요한 자	51점~59점	
5등급	**치매 대상자(노인성 질병)**로서 장기요양이 필요한 자	45점~50점	
인지지원	치매 대상자(노인성 질병)로서 장기요양 5등급을 제외한 등급	45점 미만	주·야간보호급여, 복지용구

자료: 국민건강보험공단(2025.1.1 기준). 3~5등급도 가족의 돌봄이 어렵거나 주거환경이 열악한 경우 등 등급판정위원회 인정 시 시설급여를 이용할 수 있습니다.

■ 민간보험에서 등급이 중요한 이유

민간 간병·치매보험의 '장기요양 진단비'는 보통 **1~2등급, 1~3등급, 1~4등급, 1~5등급** 등 구간별로 보험금을 다르게 설정합니다. 1~2등급만 보장하는 상품은 보험료가 저렴하지만, 실제로 가장 많이 판정되는 3~5등급에서는 보험금을 받지 못합니다. 장기요양 수급자 중 상당수가 3~4등급이라는 점을 고려하면 **어느 등급부터 보장하는지**를 반드시 확인해야 합니다.

CDR(임상치매척도) — 치매보험의 기준

척도	심신의 기능 상태	상태
CDR 0	경미한 건망증 / 정상	정상
CDR 0.5	지속적인 건망증 / 장애가 있다고 판단하기 불확실한 상태	불확실

척도	심신의 기능 상태	상태
CDR 1	기억장애(일상생활 지장 있음) / 집안생활·사회활동 장애는 있으나 정상 활동	경도
CDR 2	반복된 과거 기억만 기억함(새로운 기억은 잊어버림) / 간단한 집안일 가능하고 집 밖에서도 활동 가능	중등도
CDR 3	**심한 기억장애(사람에 대한 인지 능력만 유지, 대소변 실금) / 정상적 기능은 힘들고 외견상으로 보여짐**	**중증**
CDR 4	**심한 기억장애마저 상실(하는 말 해독 불가) / 도움 없이는 이동 불가**	**심각**
CDR 5	**기억력 없음(자신에 대한 인식 없음) / 식사 시 먹여 주어야 하며 누워 지내는 상태(와병 상태)**	**말기**

자료: 중앙치매센터(2018) 자료 기반 정리.

'중증치매'만 보장하는 보험의 함정

과거 치매보험 상당수는 **CDR 3점 이상(중증치매)**에만 보험금을 지급했습니다. 그러나 치매 환자 대부분은 경도(CDR 1)와 중등도(CDR 2) 단계에서 수년을 보내며, 이 시기에도 약물·주간보호·돌봄 비용이 발생합니다. 최근 상품은 **경도치매(CDR 1)·중등도치매(CDR 2)**부터 단계별로 진단비를 지급하므로, 기존 치매보험이 중증만 보장한다면 보완을 검토하세요.

재가급여 비용(2025년 기준)

재가급여는 등급별로 한 달에 이용할 수 있는 금액(월 한도액)이 정해져 있습니다. 한도 안에서 이용하면 본인부담 15%, 한도를 넘는 금액은 전액 본인부담입니다.

등급	월 한도액	본인부담금(15%)	공단 부담
1등급	2,306,400원	**345,960원**	1,960,440원
2등급	2,083,400원	**312,510원**	1,770,890원
3등급	1,485,700원	**222,855원**	1,262,845원
4등급	1,370,600원	**205,590원**	1,165,010원
5등급	1,177,000원	**176,550원**	1,000,450원
인지지원등급	657,400원	**98,610원**	558,790원

시설급여 비용(2025년 기준)

구분	등급	1일 한도액	월 한도액(30일)	본인부담금(20%)
노인요양시설	1등급	90,450원	2,713,500원	**542,700원**
	2등급	83,910원	2,517,300원	**503,460원**
	3등급 이상	79,240원	2,377,200원	**475,440원**
공동생활가정	1등급	72,480원	2,174,400원	**434,880원**
	2등급	67,250원	2,017,500원	**403,500원**
	3등급 이상	62,000원	1,860,000원	**372,000원**

자료: 국민건강보험공단(2025.1.1 기준). 수가는 매년 조정되므로 이용 시점의 고시를 확인하세요.

■ 실제 한 달 부담은 얼마일까

요양원(1등급)에 입소하면 본인부담금 약 54만 원에 더해 **비급여 비용**(식재료비·간식비·이미용비·상급침실료 등)이 월 30~60만 원 정도 추가되는 경우가 많습니다. 결과적으로 **월 80~120만 원** 수준의 비용이 들고, 이 비용이 수년간 이어집니다. 5년이면 5,000만 원 이상이 될 수 있습니다.

사례 — 치매 어머니를 모시는 I씨 가족

I씨의 어머니(79세)는 알츠하이머 치매로 장기요양 3등급을 받았습니다. 처음에는 주·야간보호센터(월 한도 148만 원 중 본인부담 약 22만 원 + 식비)를 이용하다가, 증상이 심해져 2년 뒤 요양원에 입소했습니다(본인부담 약 48만 원 + 비급여 약 40만 원). 어머니가 가입해 둔 치매보험은 CDR 3점 이상만 보장해 당시에는 보험금이 나오지 않았고, 장기요양 등급 기반 간병보험도 없었습니다. I씨는 "등급을 받은 순간부터 매달 나오는 보험이 하나라도 있었다면"이라며 아쉬워했습니다.

CHAPTER 18 핵심 요약

- 1등급(95점 이상) ~ 5등급(45~50점), 인지지원등급(45점 미만)
- 재가 월 한도 1등급 약 231만 원(본인 15%), 요양원 1등급 월 약 271만 원(본인 20%)
- 실제 요양원 부담은 비급여 포함 **월 80~120만 원**
- 민간보험은 **몇 등급부터, CDR 몇 점부터** 보장하는지가 핵심

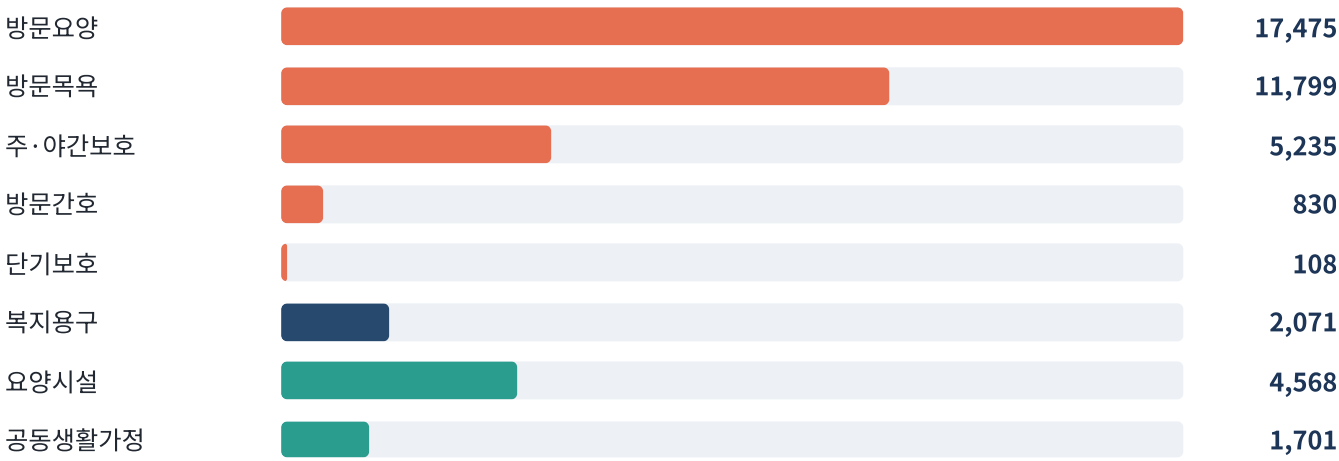
CHAPTER 19

장기요양 이용 현황, 요양병원과 요양원, 간병보험

요양병원과 요양원은 이름은 비슷하지만 법, 대상, 비용, 적용 보험이 모두 다릅니다. 간병보험도 '사람을 보내 주는' 방식과 '돈을 주는' 방식으로 나뉩니다.

장기요양 급여 종류별 이용 현황

장기요양 급여는 시설급여보다 재가급여 이용이 훨씬 많습니다. 급여 종류별 제공 기관 수(국민건강보험공단 자료)를 비교하면 방문요양이 가장 많고, 방문목욕, 주·야간보호, 요양시설 순입니다.



자료: 국민건강보험공단(2025.1.1 기준). 주황 = 재가급여, 남색 = 기타 재가(복지용구), 청록 = 시설급여.

재가급여는 2가지 이상을 함께 쓰는 **'통합재가급여'**로 이용할 수 있습니다. 예를 들어 평일 낮에는 주·야간보호센터에 다니고, 주말에는 방문요양과 방문목욕을 이용하는 방식입니다. 민간 장기요양보험도 재가급여 이용 시 매월 보험금을 지급하는 상품이 많으므로, 시설 입소 전 단계부터 보장받을 수 있는지 확인하세요.

■ 장기요양 등급의 유효기간

등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	인지지원
유효기간	4년	3년	3년	3년	2년	2년

※ 갱신 판정 시 같은 등급이 나온 경우 기준. 최초 판정 시 유효기간은 원칙적으로 2년입니다. 유효기간이 끝나기 90일 전부터 30일 전까지 갱신 신청을 해야 등급 판정을 다시 받을 수 있습니다.

요양병원과 요양원의 차이

요양병원	구분	요양원(노인요양시설)
의료법	**법적 근거**	노인복지법
30병상 이상의 수용시설, 장기요양이 의료 목적	**개념 정의**	노인성 질환자(치매·뇌졸중 등) 돌봄
노인성 질병 치료, 재활운동, 물리치료	**서비스 내용**	세면, 배설, 목욕, 조리, 세탁 등 생활 지원
본인 및 의사의 판단	**대상자**	장기요양 등급자
질병·부상의 치료 종결 시	**서비스 한도**	노인장기요양보험의 월 한도액 범위 내
의사 40명당 1명 / 간호사 입원 6명당 1명 / 물리치료사·사회복지사 병원당 1명	**인력 기준**	의사 상주 안 함(촉탁) / 간호사 25명당 1명 / 물리·작업치료사 100명당 1명 / 요양보호사 2.5명당 1명
건강보험	**적용 보험**	노인장기요양보험
80만~250만 원(간병비 포함 시 더 높음)	**월 비용**	**50만~70만 원 + 비급여**

선택 기준

- **의료적 치료가 계속 필요**(욕창, 흡인, 투석, 재활 등) → 요양병원
- **치료보다 일상생활 돌봄이 필요**(치매, 거동 불편) → 요양원
- 요양병원은 실손보험 적용이 가능하지만 **간병비는 대부분 별도**입니다. 요양병원 간병비는 그동안 전액 본인부담이었고, 정부가 건강보험 적용을 단계적으로 추진하고 있으므로 최신 시행 여부를 확인하세요.

간병보험의 두 가지 방식

구분	이용 방식	장소	보상
간병인보험	**간병인 지원**(보험사에 신청) — 보험사가 간병인을 직접 보내 줌, 주로 갱신형, **실물 지원**	병원 / 요양병원 / 간호간병통합병원	이용 일수만큼 보상 (보험사마다 차이 발생)
	간병인 사용(직접 고용) — 내가 간병인을 고용하고 일당을 받음, 비갱신/갱신, **현금 지원**		
장기요양보험 (민간)	장기요양등급 인정자가 해당 급여를 이용	재가(집) / 시설(요양원)	매월 이용 시 월 1회 보상

■ 간병인 지원 vs 간병인 사용 일당

간병인 지원(실물형)

- 간병인을 구하는 수고가 없음
- 간병비 상승에도 걱정 없음(실물 제공)
- 보험사 제휴 업체 사정에 따라 배정 지연 가능
- 갱신형이 많아 보험료 인상 가능

간병인 사용 일당(현금형)

- 가족 간병이 아닌 실제 간병인 고용 증빙 필요
- 간병비가 오르면 일당이 부족해질 수 있음
- 간호·간병 통합서비스 병동 이용 시 일당이 줄어드는 상품이 많음
- 체증형(매년 일당 증가) 상품도 있음

간병비는 하루 12~15만 원 수준까지 올랐고, 관절 치환술(약 20일)이나 뇌졸중 급성기 입원(수주~수개월)처럼 입원이 길어지면 수백만 원이 듭니다. 간병보험은 **입원이 길어지는 질병(뇌혈관·관절·골절)**의 위험이 커지는 50대 이후에 특히 의미가 있습니다.

Q. 간호·간병 통합서비스 병동에 입원하면 간병보험은 필요 없나요?

A. 통합서비스 병동은 간호 인력이 간병까지 맡아 간병비 부담이 크게 줄지만, 모든 병원·병상에 있는 것은 아니고 중증 환자는 입원이 제한될 수 있습니다. 통합병동 이용 시 지급하는 일당 담보도 있으니 함께 확인하세요.

CHAPTER 19 핵심 요약

- 장기요양은 재가급여(방문요양 등) 중심, 통합재가 이용 가능
- 요양병원 = 의료법·건강보험·치료 / 요양원 = 노인복지법·장기요양보험·돌봄
- 간병인보험 = 실물 지원형 vs 현금 일당형, 민간 장기요양보험 = 등급 후 매월 지급

■ 장기요양 · 치매 · 간병 점검 체크리스트

- [ ] 부모님(또는 본인)이 장기요양 등급 신청 대상인지 확인했다(65세 이상 또는 노인성 질환).
- [ ] 치매 보장이 경도(CDR 1)부터인지, 중증(CDR 3 이상)만인지 확인했다.
- [ ] 장기요양 보장이 몇 등급부터 지급되는지(1~2등급 / 1~5등급) 확인했다.
- [ ] 재가급여 이용 시에도 매월 보험금이 나오는지 확인했다.
- [ ] 간병비 대비 담보(간병인 지원·사용 일당)가 있는지 확인했다.
- [ ] 요양병원·요양원 중 어디가 맞을지, 예상 월 비용을 가족과 상의했다.

PART 6

노후 준비

종신 · 연금 · 상속재원 · 변액

돈보다 오래 사는 것, 그리고 남은 가족에게 무엇을 어떻게 물려줄 것인가. 노후 준비는 연금 하나로 끝나지 않습니다. 평생 보장과 자산 기능을 함께 가진 종신보험, 소득을 만드는 연금, 세금까지 고려한 상속재원, 그리고 투자 수익을 노리는 변액보험을 하나의 그림으로 묶어 정리합니다.

20 종신보험으로 준비하는 노후 — 종류, 연금전환, 사망보험금 유동화

21 노후자금과 연금 3층 보장

22 세제적격 연금 — 연금저축과 IRP 세액공제

23 상속재원 마련 — 수익자 지정, 상속세, 증여 활용

24 변액보험 — 구조, 최저보증, 비용과 주의점

CHAPTER 20

종신보험으로 준비하는 노후 — 종류, 연금전환, 사망보험금 유동화

종신보험은 '죽어야 받는 보험'이라는 인식이 강합니다. 하지만 설계와 활용에 따라 노후 소득과 상속 재원을 동시에 준비하는 도구가 될 수 있습니다.

노후 준비에서 종신보험의 역할

CHAPTER 04에서 본 것처럼 종신보험은 원인과 관계없이 평생 사망을 보장하는 보험입니다. 자녀가 어릴 때는 '가장 부재'에 대비하는 생활보장 기능이 핵심이지만, 자녀가 독립하고 은퇴가 가까워지면 역할이 바뀝니다. 그동안 쌓인 적립금(해약환급금)을 **연금으로 전환**하거나, 사망보험금을 **상속세 재원**으로 남기거나, 최근 도입된 제도를 통해 사망보험금 일부를 **생전에 연금처럼 미리 받는** 방식으로 활용할 수 있습니다.

30~40대
가장 부재 대비
(생활보장)

›

50대
납입 완료
적립금 축적

›

60대 이후
연금전환 · 유동화
(노후 소득)

›

사망 시
남은 보험금
(상속·장례 재원)

종신보험의 종류

종류	특징	노후 활용 관점
일반(표준형) 종신	납입기간 중에도 해약환급금이 일정 수준 쌓임. 보험료는 상대적으로 높음	연금전환·중도 활용에 유리
저해지·무해지 종신	납입기간 중 해지하면 환급금이 적거나 없지만, 그 대신 보험료가 10~30% 저렴. 납입 완료 후에는 환급금이 표준형 수준으로 회복	끝까지 납입할 수 있다면 효율적, 중도 해지 시 손실 큼
체증형 종신	사망보험금이 일정 기간 동안 매년 늘어남(예: 연 5%씩 체증)	물가·부동산 가격 상승에 따른 상속세 증가 대비
유니버셜 종신	의무납입기간 이후 납입 유예, 추가 납입, 중도 인출 가능	은퇴 전후 현금흐름 조절에 유연
변액 종신	적립금을 펀드로 운용, 실적에 따라 사망보험금·환급금 변동(최저 사망보험금 보증)	장기 투자 수익 기대, 원금 손실 위험(CHAPTER 24)
간편심사 종신	유병자도 간소화된 질문으로 가입, 보험료 높음	고령·유병자의 상속 재원

연금전환 — 사망보장을 노후 소득으로

많은 종신보험에는 **연금전환 특약**(또는 연금전환 기능)이 있습니다. 일정 나이 또는 납입 완료 이후, 계약의 적립금(해약환급금)의 전부 또는 일부를 재원으로 연금을 받는 방식입니다.

- **전환 방식**: 적립금 전부를 전환하면 사망보장은 종료되고 연금만 남습니다. 일부만 전환하면 사망보험금이 줄어든 상태로 보장이 유지됩니다.
- **연금 형태**: 종신연금형(평생 지급), 확정기간형(10·20년 등), 상속연금형(이자만 연금으로 받고 원금은 사망 시 지급) 등 상품별로 선택합니다.
- **적용 기준**: 연금액 계산에 쓰는 이율과 생명표가 '전환 시점' 기준인지 '가입 시점' 기준인지에 따라 연금액이 크게 달라집니다. 반드시 약관에서 확인하세요.
- **세금**: 일정 요건(계약 유지 10년 이상 등)을 충족한 보험차익은 비과세될 수 있습니다. 전환 시점의 세법을 확인하세요.

사례 — 자녀 독립 후 종신보험 연금전환

V씨(61세)는 35세에 사망보험금 1억 원, 20년납 종신보험에 가입해 55세에 납입을 마쳤습니다. 자녀가 모두 독립하자 큰 사망보장의 필요성이 줄었고, 대신 국민연금 수령 전까지 2년간의 소득 공백이 걱정이었습니다. V씨는 적립금의 절반을 확정기간 연금으로 전환해 공백기를 메우고, 나머지 절반은 사망보험금으로 남겨 장례비와 배우자 생활자금으로 쓰도록 했습니다. ※ 실제 연금액은 상품·적립금·전환 조건에 따라 다릅니다.

사망보험금 유동화 — 살아 있을 때 미리 받기

2025년 10월부터 생명보험사들이 순차적으로 시행한 **사망보험금 유동화** 제도는, 종신보험의 사망보험금 일부를 생전에 연금 형태로 미리 받을 수 있게 한 제도입니다. 보험료를 오랫동안 냈지만 노후 현금이 부족한 고령 가입자를 위한 것입니다.

항목	주요 내용(도입 당시 금융당국 발표 기준)
대상 계약	금리확정형 종신보험으로 계약 유지 10년 이상, 보험료 납입 완료, 사망보험금 9억 원 이하, 보험계약대출이 없을 것
신청 나이	만 65세 이상(상품·회사별로 확대 여부 확인)
유동화 한도	사망보험금의 최대 90% 이내에서 선택
지급 방식	연금형(매월 또는 매년 지급), 일부 회사는 요양·건강관리 서비스 형태도 운영
효과	유동화한 만큼 사망보험금은 줄어듭니다. 받는 총액은 유동화한 사망보험금보다 적을 수 있습니다(이자·비용 반영).

※ 대상 상품과 세부 조건은 보험사별로 다르므로 가입한 보험사에 문의하세요.

유동화 전 따져 볼 것

- 유동화로 줄어든 사망보험금이 **상속세·장례비 재원으로 충분한가**
- 유동화 대신 **연금전환**이 더 유리한 계약인지(적립금 규모, 연금 조건 비교)
- 배우자의 노후 생활비가 사망보험금에 의존하고 있지는 않은가

보험료가 부담될 때의 선택지

은퇴가 가까워져 종신보험료가 부담된다고 해서 바로 해지하면 큰 손실을 봅니다. 해지 전에 다음 방법을 먼저 검토하세요.

방법	내용	주의
감액	사망보험금을 줄여 이후 보험료를 낮춤. 줄인 부분은 해지로 처리되어 환급금 지급	줄인 보장은 되살릴 수 없음
감액완납	보험료 납입을 멈추고, 그때까지의 적립금으로 줄어든 보험금의 '납입 완료' 계약으로 변경	특약은 소멸하는 경우가 많음
연장정기	보험금은 그대로 두고 적립금으로 보장 기간만 줄인 정기보험으로 변경	평생 보장이 기간 보장으로 바뀜
납입 유예(유니버셜)	일정 기간 보험료를 내지 않고 적립금에서 위험보험료 차감	적립금 소진 시 계약 해지 위험
보험계약대출	해약환급금 범위 내에서 대출(약관대출)	이자 발생, 유동화 대상에서 제외될 수 있음

'단기납 종신'과 환급률 마케팅 주의

한동안 5년·7년만 납입하면 10년 시점에 납입 보험료보다 많은 환급금(환급률 100% 초과)을 준다는 **단기납 종신보험**이 '저축처럼' 판매되어 금융당국이 환급률 설계를 제한하고 소비자 경보를 낸 바 있습니다. 종신보험은 본질적으로 **보장성 보험**입니다. 환급률만 보고 가입했다가 10년 이전에 해지하면 원금 손실이 크고, 저축 목적이라면 연금저축·IRP 같은 상품이 더 적합할 수 있습니다.

Q. 종신보험을 연금보험 대신 가입해도 될까요?

A. 같은 보험료라면 순수 연금보험이 연금액 면에서 더 유리한 것이 일반적입니다. 종신보험은 사망보장 비용(위험보험료)이 들기 때문입니다. 사망보장과 노후 소득이 모두 필요할 때 종신보험의 연금전환이 의미가 있습니다.

Q. 오래된 종신보험의 예정이율이 높다는데, 유지해야 하나요?

A. 1990~2000년대 초에 가입한 종신보험은 예정이율이 높아 지금 같은 보장을 새로 가입하는 것보다 훨씬 유리한 경우가 많습니다. 해지보다는 감액·연금전환 등으로 활용하는 것이 대체로 낫습니다.

CHAPTER 20 핵심 요약

- 종신보험은 생활보장 → 적립 → **연금전환·유동화** → 상속재원으로 역할이 바뀜
- 저해지·체증형·유니버셜 등 종류별로 노후 활용 방식이 다름
- 사망보험금 유동화(2025.10~): 65세 이상·납입 완료·10년 유지 계약, 최대 90%
- 보험료 부담 시 해지보다 감액·감액완납·연장정기를 먼저 검토

■ 점검 체크리스트

- [ ] 종신보험의 종류(일반·저해지·체증형·유니버셜·변액)를 확인했다.
- [ ] 연금전환 가능 시기와 연금 계산 기준(가입 시점/전환 시점)을 확인했다.
- [ ] 사망보험금 유동화 대상 계약인지 보험사에 확인했다.
- [ ] 현재 해약환급금과 납입 완료 시점의 예상 환급금을 확인했다.

CHAPTER 21

노후자금과 연금 3층 보장

평균수명은 늘었는데 은퇴 시점은 그대로입니다. 국민연금·퇴직연금·개인연금의 3층 구조로 소득 공백을 메우는 법을 알아봅니다.

경험생명표로 본 수명 연장

경험생명표는 보험 가입자의 실제 사망 통계를 바탕으로 보험개발원이 작성하는 표입니다. 1988년 제1회를 시작으로 성별·연령별 사망률을 관찰해 작성하며, 통계청의 국민생명표와 함께 사망 현상에 대한 국가지표로 활용됩니다. 보험업법에 따라 약 5년마다 개정되며 보험료 산정의 기준이 됩니다.

회차	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	9회	10회
남자	65.7	67.1	68.3	73.3	76.4	78.5	80.0	81.4	83.5	**86.3**
여자	75.6	76.7	77.9	80.9	84.4	85.3	85.9	86.7	88.5	**90.7**

자료: 보험개발원. 단위: 세(평균수명).

제1회에서 제10회까지 남성의 평균수명은 **20.6세**, 여성은 **15.1세** 늘었습니다. 의료기술 발전으로 평균수명과 고령의 기대여명이 늘면서 은퇴 이후 노후 의료비와 소득 보장에 대한 관심이 더욱 커질 것입니다. 연금보험, 건강한 노후를 위한 헬스케어 연계 상품에 주목해야 하는 이유입니다.

수명 연장이 보험에 미치는 영향

- **사망보험료는 내려갑니다**: 같은 나이에 사망할 확률이 낮아지므로 종신·정기보험료가 인하되는 경향
- **연금보험료는 올라갑니다**: 오래 살수록 연금을 오래 지급해야 하므로 같은 적립금으로 받는 연금액이 줄어드는 경향
- **과거 생명표로 가입한 연금은 유리**: 가입 당시 생명표를 적용하는 연금보험은 오래된 계약일수록 유리할 수 있으므로 해지에 신중해야 합니다.

연금 3층 보장체계

3층 · 개인연금

여유로운 생활
은퇴 후 여유로운 생활을 위해 개인이 자발적으로 준비. 세제적격 연금저축, 세제비적격 연금보험(공시이율형·변액연금 등)

2층 · 퇴직연금

안정적인 생활
노사합의에 의해 가입. DB형(회사 운용 책임), DC형(근로자 운용 책임), IRP(개인형 퇴직연금, 세제혜택)

1층 · 국민연금

기본적인 생활
국민의 생활 안정과 복지 증진을 위해 국가가 만든 사회보험 제도

■ 1층 국민연금 — 2026년부터 달라진 점

2025년 3월 국민연금법 개정으로 2026년부터 연금 제도가 바뀌었습니다.

항목	개정 전	개정 후(2026년~)
보험료율	소득의 9% (직장가입자: 근로자 4.5% + 회사 4.5%)	2026년 9.5%부터 매년 0.5%p씩 인상해 **2033년 13%**
소득대체율	2028년까지 40%로 단계적 하향 예정	**43%**(2026년부터)
기타	—	국가 지급 보장 명문화, 출산·군복무 크레딧 확대 등

※ 세부 시행 내용은 국민연금공단 안내를 확인하세요.

소득대체율 43%는 '40년 가입 기준' 평균소득자의 수치입니다. 실제 가입기간이 20~30년이라면 소득대체율은 20~30%대에 그칩니다. 국민연금만으로는 '기본적인 생활'이 한계이고, 2층과 3층이 필요한 이유입니다.

■ 2층 퇴직연금의 종류

구분	확정급여형(DB)	확정기여형(DC)	개인형(IRP)
개념	퇴직 시 지급할 급여수준을 노사가 사전에 약정	기업이 기여할 부담금 수준을 노사가 사전에 확정	이직 시 퇴직연금 유지를 위한 통합계좌 및 추가납입 수단
특징	사전에 약정된 퇴직급여 지급, 근로기간·임금수준에 따라 결정	운용 결과에 따른 퇴직급여 지급, 자산운용 실적에 따라 변동	퇴직일시금 납입 시 과세 이연, 추가부담금에 대한 세액공제
기업 부담금	산출 기준에 따라 적립(연간 임금총액의 1/12 이상 수준)	연간 임금총액의 1/12 이상	없음(10인 미만 사업체 전원 IRP 설정 시 DC와 동일)
운용 주체	기업	근로자	근로자

구분	확정급여형(DB)	확정기여형(DC)	개인형(IRP)
적합한 기업	도산 위험이 없고 고용이 안정된 기업, 승진 등 임금 상승률이 높은 경우	연봉제 채택, 임금 체불 위험이 높은 기업, 임금상승률이 높지 않은 경우	퇴직일시금 수령자, 소규모 기업

노후 필요자금 계산해 보기

국민연금연구원의 국민노후보장패널조사에 따르면 노후에 필요한 적정 생활비는 부부 기준 월 300만 원 안팎, 최소 생활비는 월 200만 원대 초반으로 조사됩니다. 은퇴 후 30년을 산다고 가정하면 다음과 같은 계산이 나옵니다.

월 300만 원 × 12개월 × 30년 = 약 10억 8,000만 원 (물가상승 미반영)

재원	예상 월 수령액	비고
1층 국민연금(부부 합산)		국민연금공단 '내 연금 알아보기'에서 확인
2층 퇴직연금		적립금 ÷ 수령 기간
3층 개인연금		연금저축·연금보험 예상 연금액
기타(주택연금, 임대소득 등)		주택연금은 한국주택금융공사
부족액 = 목표 생활비 − 합계		**부족액을 3층에서 보완**

CHAPTER 21 핵심 요약

- 제10회 경험생명표 평균수명: 남 86.3세, 여 90.7세
- 국민연금(기본) + 퇴직연금(안정) + 개인연금(여유) = 3층
- 국민연금 2026년 개혁: 보험료율 9.5%→2033년 13%, 소득대체율 43%
- 과거 생명표로 가입한 연금보험은 유리할 수 있어 해지 신중

CHAPTER 22

세제적격 연금 — 연금저축과 IRP 세액공제

연말정산에서 최대 148만 5천 원을 돌려받는 방법. 단, 중도에 깨면 그 혜택을 토해 내야 합니다.

가입 대상과 세액공제율

직장인, 공무원, 전문직 종사자, 자영업자 등 **소득이 있는 사람**은 연금저축과 IRP 납입액에 대해 세액공제를 받을 수 있습니다.

총급여액(종합소득금액)	연금저축 납입한도 (세액공제 대상 납입한도)	세액공제율 (지방소득세 포함)
5,500만 원 이하 (4,500만 원 이하)	**600만 원** (퇴직연금 포함 900만 원)	**15%** **(16.5%)**
5,500만 원 초과 (4,500만 원 초과)		**12%** **(13.2%)**

납입액별 세금 절감 효과

월 납입액(연간 납입액)	세금 절감액 16.5%	세금 절감액 13.2%
50만 원(600만 원)	**990,000원**	792,000원
40만 원(480만 원)	792,000원	633,600원
30만 원(360만 원)	594,000원	475,200원
20만 원(240만 원)	396,000원	316,800원
10만 원(120만 원)	198,000원	158,400원

연금저축 600만 원에 IRP 300만 원을 더해 연 900만 원을 납입하면, 총급여 5,500만 원 이하인 사람은 **최대 148만 5천 원**(900만 원 × 16.5%)을 돌려받습니다. 매년 16.5%의 확정 수익을 얻는 것과 같은 효과입니다.

가입 시 유의사항

1. **개인형 퇴직연금(IRP) 세액공제 최대한도**: 연금저축과 합산해 연 900만 원(IRP만으로 900만 원도 가능)
2. **연금저축 세액공제 한도**: 연 600만 원. 세액공제율은 종합소득금액 4,500만 원(총급여 5,500만 원) 이하 16.5%, 초과 13.2%(지방세 포함)

3. **연금 수령 요건**: 5년 이상 가입, 만 55세 이후, 연금수령 개시 후 10년 이상(연간 수령 한도 내) 분할 수령. 한도를 넘거나 연금 외로 수령하면 기타소득세(16.5%) 과세
4. **연금소득세율**(연간 연금수령액 1,500만 원 이하, 분리과세로 납세의무 종결)

수령 나이	55~69세	70~79세	80세 이상
세율(지방세 포함)	5.5%	4.4%	3.3%

종신형 연금은 나이와 관계없이 4.4%(80세 이상 3.3%)가 적용되는 등 특례가 있습니다.

5. **연간 연금수령액이 1,500만 원을 초과하면**: 다른 소득과 합산해 종합과세하거나 16.5% 분리과세 중 선택할 수 있습니다. 사망, 해외이주, 3개월 이상 요양, 개인파산·개인회생 등 부득이한 사유로 인출하면 저율(3.3~5.5%) 과세됩니다.
6. **중도 해지 시**: 세액공제받은 원금과 운용수익에 기타소득세 16.5%가 부과되어 세제 혜택이 환수됩니다.
7. **세액공제받지 않은 납입액**: 인출 시 비과세
8. **납입한도**: 연금저축·IRP 합산 연 최대 1,800만 원(분기 한도 없음). ISA 만기 자금을 연금계좌로 옮기면 이전액의 10%(최대 300만 원)를 추가로 세액공제받을 수 있습니다.

연금저축보험 vs 연금저축펀드 vs IRP

구분	연금저축보험	연금저축펀드	IRP
판매처	보험사	증권사·은행	은행·증권사·보험사
원금 보장	예금자보호(5천만 원 한도) 대상, 공시이율 적용	원금 보장 없음(투자 성과)	상품 선택에 따라 다름(예금형 가능)
납입 방식	정기 납입(미납 시 효력 상실 가능)	자유 납입	자유 납입
위험자산 투자	불가	100%까지 가능	70% 한도
종신 수령	가능(생보사 상품)	불가(확정기간)	상품별
적합한 사람	안정성·평생 연금 선호	장기 투자로 수익 추구	퇴직금 수령자, 추가 세액공제 원하는 사람

세제비적격 연금보험과 비교

연금보험(세제비적격)은 납입 시 세액공제는 없지만, 요건을 갖추면 **연금 수령 시 이자소득세가 비과세**됩니다. 대표적인 비과세 요건은 ① 월 적립식: 5년 이상 납입, 10년 이상 유지, 월 보험료 150만 원 이하 ② 일시납: 10년 이상 유지, 1인당 1억 원 한도 ③ 종신형 연금 요건 충족 등입니다. 세액공제를 이미 한도까지 받고 있거나 연금 소득이 많아 종합과세가 걱정되는 사람에게 적합합니다.

사례 — 연봉 5천만 원 직장인 J씨의 연금 전략

J씨(35세)는 매년 연말정산에서 세금을 토해 내 왔습니다. 연금저축펀드에 월 50만 원(연 600만 원), IRP에 월 25만 원(연 300만 원)을 납입하기 시작하자 다음 해 **148만 5천 원**을 돌려받았습니다. J씨는 돌려받은 세금을 다시 연금저축에 넣는 방식으로 복리 효과를 키우고 있습니다. 단, 주택 구입 등 목돈이 필요할 때 연금계좌를 해지하면 세제 혜택을 토해 내야 하므로 비상자금은 별도로 마련해 두었습니다.

CHAPTER 22 핵심 요약

- 연금저축 600만 + IRP 300만 = 연 900만 원 세액공제(13.2% 또는 16.5%)
- 55세 이후·5년 이상·10년 이상 분할 수령 시 연금소득세 3.3~5.5%
- 중도 해지 시 16.5% 기타소득세로 혜택 환수 → 비상자금 별도 준비
- 세액공제 한도를 넘는 노후자금은 비과세 연금보험 활용

■ 노후 · 연금 점검 체크리스트

- ☐ 국민연금 예상 수령액을 조회했다.
- ☐ 퇴직연금 유형(DB/DC)과 적립금을 확인했다.
- ☐ 연금저축·IRP 세액공제 한도를 채우고 있는지 확인했다.
- ☐ 은퇴 후 목표 생활비와 3층 연금 합계의 부족액을 계산했다.
- ☐ 오래된 연금보험(과거 생명표 적용)을 해지하지 않고 유지하고 있다.

CHAPTER 23

상속재원 마련 — 수익자 지정, 상속세, 증여 활용

사망보험금은 '누가 받는지'를 정하지 않으면 법이 정해 줍니다. 그리고 그 결과는 가족 간 분쟁과 세금으로 이어질 수 있습니다.

민법이 정한 상속 순위

사망보험금의 수익자를 따로 지정하지 않았다면, 약관에 따라 '법정상속인'이 수익자가 됩니다. 법정상속인은 민법이 정한 순서에 따라 결정됩니다.

순위	조건	상속인
1순위	—	직계비속(자녀·손자녀)과 배우자
2순위	1순위가 없는 경우	직계존속(부모·조부모)과 배우자
3순위	1·2순위가 없는 경우	형제자매
4순위	1·2·3순위가 없는 경우	4촌 이내의 방계혈족

- 배우자는 1순위·2순위 상속인과 **공동상속인**이 되며, 1·2순위가 모두 없으면 단독상속인이 됩니다.
- 배우자의 법정상속분은 다른 공동상속인의 **1.5배**입니다. 예: 배우자와 자녀 2명이면 1.5 : 1 : 1 → 배우자 3/7, 자녀 각 2/7
- 같은 순위 상속인이 여러 명이면 촌수가 가까운 사람이 우선하고, 촌수가 같으면 균등하게 나눕니다.

수익자 지정이 필요한 이유

수익자를 지정한 경우

지정된 수익자가 사망보험금 **전액**을 받습니다. 다른 상속인과 나눌 필요가 없고 청구 절차도 간단합니다.

수익자를 지정하지 않은 경우

법정상속인이 **법정상속분에 따라** 나누어 받습니다. 상속인 전원의 서류가 필요하고, 미성년 자녀가 있으면 특별대리인 선임이 필요할 수 있습니다.

사례 — 수익자 미지정이 부른 갈등

40대 B씨가 갑작스럽게 사망했습니다. B씨에게는 배우자와 미성년 자녀 1명이 있었고, 종신보험 사망수익자는 '법정상속인'으로 되어 있었습니다. 보험금 3억 원은 배우자 3/5(1억 8천만 원), 자녀 2/5(1억 2천만 원)로 나뉘었습니다. 자녀 몫은 미성년자 재산이므로 배우자가 마음대로 쓸 수 없었고, 생활비와 대출 상환에 쓰려면 별도의 법적 절차가 필요했습니다. **수익자를 배우자로 지정해 두었다면** 전액을 바로 생활 안정에 쓸 수 있었을 것입니다.

가족 간 분쟁을 막기 위해서라도 수익자 지정은 필수

- 재혼 가정, 자녀가 없는 부부(→ 배우자와 시부모·장인장모가 공동상속), 미성년 자녀가 있는 가정은 특히 수익자 지정이 중요합니다.
- 수익자 변경은 계약자가 보험사에 신청하면 됩니다. 단, 피보험자와 계약자가 다르면 피보험자의 서면 동의가 필요합니다.
- 이혼 후 전 배우자가 수익자로 남아 있는 경우가 실제로 많습니다. 혼인·이혼·출산 등 가족 변동 시 반드시 수익자를 점검하세요.

■ 상속을 포기해도 사망보험금은 받을 수 있을까

고인의 빚이 재산보다 많아 상속을 포기하는 경우가 있습니다. 판례는 피보험자의 사망으로 수익자가 받는 사망보험금을 **수익자의 고유재산**으로 보는 입장입니다. 수익자가 특정인으로 지정되어 있든, 약관에 따라 '상속인'으로 정해졌든 마찬가지입니다. 따라서 상속을 포기하거나 한정승인을 하더라도 사망보험금은 받을 수 있는 경우가 많습니다. 다만 계약자와 피보험자가 모두 고인이고 수익자가 고인 본인으로 되어 있는 등 구조에 따라 판단이 달라질 수 있으므로 구체적인 사안은 전문가와 상의하세요.

상속세 기본 구조

민법상 고유재산이라도 세법은 다르게 봅니다. 피상속인(고인)이 보험료를 낸 계약에서 받는 사망보험금은 상속세 및 증여세법에 따라 **'간주상속재산'**으로 보아 상속세 과세 대상이 됩니다.

■ 상속세율표

과세표준	세율	누진공제
1억 원 이하	10%	—
1억 원 초과 ~ 5억 원 이하	20%	1천만 원
5억 원 초과 ~ 10억 원 이하	30%	6천만 원

과세표준	세율	누진공제
10억 원 초과 ~ 30억 원 이하	40%	1억 6천만 원
30억 원 초과	50%	4억 6천만 원

상속세 산출세액 = 과세표준 × 세율 − 누진공제. 증여세율도 같은 구조입니다. 상속세 체계(유산취득세 전환 등) 개편이 논의되고 있으므로 실제 신고 시점의 법령을 확인하세요.

우리나라 상속세 최고세율 50%는 OECD 회원국 평균(약 15% 수준, 상속세가 없는 국가 포함)과 비교하면 높은 편입니다. 최대주주 할증까지 적용되면 실효 부담은 더 커질 수 있습니다.

■ 상속세 계산 흐름

총상속재산
본래 상속재산 + 간주상속재산(보험금·퇴직금 등) + 추정상속재산

›

− 비과세·공제
장례비, 채무, 사전증여 합산 후

›

− 상속공제
일괄공제 5억, 배우자공제 최소 5억, 금융재산공제 등

›

과세표준 × 세율
− 누진공제 − 신고세액공제(3%)

일반 가정에서는 **일괄공제 5억 원 + 배우자공제 최소 5억 원** 덕분에 배우자가 생존해 있으면 대략 10억 원, 배우자가 없으면 5억 원까지는 상속세가 나오지 않는 경우가 많습니다. 하지만 수도권 아파트 한 채의 가격이 이 기준을 넘는 경우가 늘면서 '중산층 상속세'가 현실적인 문제가 되었습니다.

보험으로 상속세를 준비하는 법

■ 계약자·피보험자·수익자 구조와 세금

계약자(실제 납입자)	피보험자	수익자	사망보험금 과세
아버지	아버지	자녀	**상속세** 과세 대상(간주상속재산)
자녀(소득 있음)	아버지	자녀	상속세·증여세 **과세 대상 아님**(자녀 본인이 낸 보험료로 받은 보험금)
아버지	어머니	자녀	어머니 사망 시 아버지 → 자녀 **증여세** 과세 대상

즉, **소득이 있는 자녀가 계약자가 되어 실제로 보험료를 내고, 부모를 피보험자로, 자녀 본인을 수익자로** 하면 부모 사망 시 받는 보험금은 상속세 대상이 아니면서 상속세 납부 재원으로 쓸 수 있습니다. 단, 자녀에게 소득이 없어 부모가 준 돈으로 보험료를 냈다면 실질 납부자를 부모로 보아 과세될 수 있으므로 납입 자금의 출처가 분명해야 합니다.

부동산 위주 자산가에게 종신보험이 필요한 이유

상속세는 사망일이 속한 달의 말일부터 6개월 이내에 신고·납부해야 합니다. 상속재산이 대부분 부동산이면 현금이 부족해 부동산을 급하게 처분하거나 높은 이자의 대출을 받아야 하는 상황이 생깁니다. 연부연납(최장 10년 분할납부)과 물납 제도가 있지만 요건과 가산금이 있습니다. 사망 즉시 현금으로 지급되는 종신보험은 이 유동성 문제를 해결하는 가장 확실한 수단입니다.

Q. 사망보험금도 금융재산상속공제를 받을 수 있나요?

A. 상속재산에 포함되는 보험금은 금융재산에 해당해 순금융재산의 20%(최대 2억 원, 2천만 원 이하는 전액, 2천만 원 초과~1억 원은 2천만 원)를 공제받을 수 있습니다.

Q. 수익자를 지정해 두면 상속세가 줄어드나요?

A. 수익자 지정은 '누가 받느냐'를 정할 뿐, 피상속인이 보험료를 낸 보험금이라면 상속세 계산에는 포함됩니다. 세금을 줄이려면 계약자(실제 납입자) 구조를 바꾸어야 합니다.

상속세 계산 실전 예시

실제 숫자로 계산해 보면 '우리 집도 상속세가 나오는가'를 바로 알 수 있습니다. 아래는 이해를 돕기 위해 단순화한 예시입니다(장례비·채무·사전증여는 없다고 가정).

예시 — 배우자와 자녀 2명, 상속재산 20억 원

항목	금액
상속재산(아파트 시가 15억 + 금융자산 5억)	20억 원
− 일괄공제	5억 원
− 배우자상속공제(최소 금액 적용 가정)	5억 원
− 금융재산상속공제(순금융재산 5억 × 20%, 최대 2억)	1억 원
과세표준	**9억 원**
산출세액(9억 × 30% − 누진공제 6천만)	2억 1,000만 원
− 신고세액공제(3%)	630만 원
납부할 상속세	**약 2억 370만 원**

이 가족은 6개월 안에 2억 원이 넘는 현금을 마련해야 합니다. 금융자산 5억 원이 있어 납부는 가능하지만, 남은 배우자의 노후자금이 크게 줄어듭니다. 금융자산이 없고 아파트만 있었다면 대출이나 급매가 불가피했을 것입니다. 배우자가 실제로 더 많이 상속받으면 배우자공제가 커져(최대 30억 원, 법정상속분 한도) 세금이 줄 수 있으나, 이 경우 배우자 사망 시 2차 상속세를 함께 고려해야 합니다.

※ 단순화한 예시이며 실제 세액은 재산 평가, 공제 요건, 사전증여 등에 따라 달라집니다. 실제 신고는 세무 전문가와 상의하세요.

사전 증여와 증여재산공제

상속세를 줄이는 기본 전략은 **미리, 나누어, 공제 범위 안에서** 증여하는 것입니다. 증여재산공제는 수증자(받는 사람) 기준으로 10년간 합산해 적용됩니다.

증여자 → 수증자	공제 한도(10년 합산)
배우자 → 배우자	6억 원
부모(직계존속) → 성년 자녀	5,000만 원
부모(직계존속) → 미성년 자녀	2,000만 원
자녀(직계비속) → 부모	5,000만 원
기타 친족(6촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척)	1,000만 원
혼인·출산 증여재산공제(2024년 신설, 직계존속 → 자녀)	**추가 1억 원**

- **10년 합산 규정**: 상속 개시 전 10년 이내에 상속인에게 증여한 재산(상속인이 아닌 사람은 5년)은 상속재산에 다시 더해 계산합니다. 증여는 **일찍 시작할수록** 효과가 큽니다.

- **자녀 출생부터 계획**: 미성년 기간 2,000만 원 + 성년 이후 10년마다 5,000만 원씩 증여하면 30세까지 세금 없이 상당한 금액을 이전할 수 있습니다.
- **보험과 결합**: 증여받은 돈으로 자녀가 계약자가 되어 부모를 피보험자로 한 종신보험료를 내면, 자녀의 납입 자금 출처가 분명해져 사망보험금이 상속세 과세 대상에서 벗어날 수 있습니다(앞의 계약 구조 표 참고).

상속재원 설계 4단계

1. 재산 목록화	›	2. 예상 세액 계산	›	3. 유동성 점검	›	4. 재원 마련
부동산 시가, 금융자산, 부채, 기존 보험		공제 적용 후 과세표준과 세율		6개월 안에 낼 현금이 있는가		사전 증여 + 종신보험 (계약자 설계)

Q. 상속세 재원용 종신보험은 얼마나 가입해야 하나요?

A. 예상 상속세에서 즉시 현금화할 수 있는 금융자산을 뺀 금액이 기본입니다. 부동산 가격 상승을 고려해 여유를 두고, 체증형 종신보험이나 정기적인 재점검(3~5년마다)으로 금액을 조정하는 것이 좋습니다.

Q. 부모님이 고령이라 종신보험 가입이 어렵다면요?

A. 고령·유병자는 보험료가 매우 비싸거나 가입이 거절될 수 있습니다. 이 경우 사전 증여, 연부연납(최장 10년 분할납부) 활용 계획, 금융자산 비중 확대 등 보험 외 수단을 함께 검토해야 합니다. 상속재원 준비는 부모님이 건강할 때 시작하는 것이 핵심입니다.

CHAPTER 23 핵심 요약

- 수익자 미지정 → 법정상속인이 법정상속분대로 나눔(배우자 1.5배)
- 사망보험금은 민법상 수익자 고유재산, 세법상 간주상속재산
- 상속세율 10~50%, 일괄공제 5억 + 배우자공제 최소 5억
- 소득 있는 자녀가 계약자·수익자, 부모가 피보험자 → 상속세 납부 재원 마련
- 증여재산공제(성년 자녀 5천만·미성년 2천만·혼인출산 1억 추가)를 10년 단위로 일찍 활용

■ 점검 체크리스트

- [ ] 모든 사망보장 계약의 수익자를 확인했다.
- [ ] 이혼·재혼·출산 이후 수익자를 변경할 필요가 있는지 확인했다.
- [ ] 예상 상속재산(부동산 시가 포함)과 상속세를 대략 계산해 보았다.
- [ ] 상속세 납부 재원(현금·보험금)이 준비되어 있는지 확인했다.

CHAPTER 24

변액보험 — 구조, 최저보증, 비용과 주의점

변액보험은 '보험'과 '펀드'를 합친 상품입니다. 오래 유지하면 물가를 이기는 수익을 기대할 수 있지만, 구조를 모르고 가입하면 원금 손실과 높은 비용에 실망하기 쉽습니다.

변액보험이란

변액보험은 고객이 낸 보험료 중 사업비와 위험보험료를 뺀 금액을 **특별계정(펀드)**에 투자하고, 그 운용 실적에 따라 보험금과 해약환급금이 달라지는 실적배당형 보험입니다. 일반 보험이 보험사가 정한 이율(공시이율·예정이율)로 적립금을 불리는 것과 달리, 변액보험은 **투자 결과를 계약자가 직접 짊어집니다.**

장점

- 장기 투자 시 물가상승률 이상의 수익 기대
- 펀드 변경(주식형↔채권형) 가능
- 요건 충족 시 보험차익 비과세(10년 이상 유지 등)
- 최저보증 기능으로 일부 위험 완화

단점·위험

- 원금 손실 가능(특히 초기 해지 시)
- 사업비·운용보수·보증비용 등 비용이 많음
- 예금자보호 대상 아님(최저보증 보험금 등 일부 제외)
- 시장 하락기에 적립금 감소

변액보험의 종류

종류	주된 목적	특징
변액종신보험	평생 사망보장 + 투자	투자 실적이 나빠도 기본 사망보험금은 최저 보증(GMDB), 실적이 좋으면 사망보험금 증가
변액연금보험	노후 연금 재원 마련	연금 개시 시점에 납입보험료 등을 최저 보증(GMAB)하는 상품이 많음
변액유니버셜보험	투자형 저축(적립형) 또는 보장(보장형)	추가 납입·중도 인출·납입 유예 가능, 적립형은 사실상 장기 투자 상품

최저보증 옵션 이해하기

변액보험의 투자 위험을 줄이기 위해 보험사가 일정 금액을 보증해 주는 장치입니다. 보증에는 별도의 **보증 비용**이 적립금에서 차감됩니다.

약칭	이름	보증 내용
GMDB	최저사망보험금보증	투자 실적과 관계없이 사망 시 최소한 기본보험금(또는 납입보험료)을 지급
GMAB	최저연금적립금보증	연금 개시 시점의 적립금이 납입보험료(또는 그 일정 비율)보다 적으면 보증 금액으로 연금 재원을 만들어 줌
GMWB	최저인출금액보증	적립금이 줄어도 일정 기간 동안 정해진 금액을 인출할 수 있도록 보증
GLWB	종신인출금액보증	투자 실적과 관계없이 평생 일정 금액(또는 비율)을 연금처럼 인출하도록 보증

보증은 '중도 해지'에는 적용되지 않는다

GMAB 같은 최저보증은 대부분 **연금 개시 시점까지 유지했을 때**만 적용됩니다. 중간에 해지하면 그 시점의 실제 적립금(해약환급금)만 받습니다. 보증이 있다고 '원금 보장 상품'으로 오해하지 마세요.

비용 구조 — 왜 초기에 원금 손실이 클까

비용	내용
계약체결비용	설계사 수수료 등 판매 비용. 계약 초기(보통 7~10년)에 집중 차감
계약관리비용	계약 유지·관리 비용. 납입 기간 및 이후에도 차감
위험보험료	사망보장 등에 필요한 보험료(보장 금액이 클수록 큼)
최저보증 비용	GMDB·GMAB 등 보증 옵션 비용(적립금의 연 일정 %)
펀드 운용·수탁보수	특별계정 펀드의 운용 비용(펀드별 상이)

이 비용 때문에 변액보험은 **펀드 수익률이 0%라면 상당 기간 해약환급금이 납입보험료에 미치지 못합니다.** 상품설명서의 '해약환급금 예시표'에서 투자수익률 가정(예: 연 -1%, 2.5%, 4% 등)별로 원금 도달 시점을 반드시 확인하세요. 추가납입 보험료는 계약체결비용이 거의 없어, 기본보험료를 낮추고 추가납입을 활용하면 비용을 줄일 수 있습니다.

펀드 관리 — 가입보다 중요한 '유지 중 관리'

- **펀드 변경**: 연 12회 등 무료 변경 횟수가 정해져 있습니다. 나이가 들수록 주식형 비중을 줄이고 채권형 비중을 늘리는 것이 일반적입니다.
- **자동 재배분**: 정해 둔 비율(예: 주식 60 : 채권 40)로 주기적으로 자동 조정하는 기능을 활용하면 감정적인 매매를 피할 수 있습니다.

- **정기 점검**: 보험사가 분기마다 보내는 '변액보험 운용 현황 보고서'로 수익률과 적립금을 확인하고, 1년에 한 번은 펀드 구성을 점검하세요.

변액연금 vs 연금저축펀드 vs 일반 연금보험

구분	변액연금보험	연금저축펀드	일반(공시이율) 연금보험
수익	펀드 실적배당	펀드 실적배당	공시이율(최저보증이율)
원금 보장	연금 개시 시 최저보증(GMAB) 상품 다수	없음	최저보증이율 적용, 예금자보호
세제	납입 시 공제 없음, 요건 충족 시 비과세	세액공제(13.2~16.5%), 수령 시 연금소득세	납입 시 공제 없음, 요건 충족 시 비과세
비용	사업비+보증비용+운용보수 (높음)	운용보수(상대적으로 낮음)	사업비
종신 연금	가능	불가(확정기간)	가능
적합한 사람	10년 이상 장기 투자, 종신 연금 + 보증 원함	세액공제 우선, 직접 펀드 운용	안정성 최우선

가입 전 확인할 것 — 적합성 진단과 청약철회

- [ ] 투자성향 진단(적합성 원칙) 결과와 상품 위험등급이 맞는가
- [ ] 최소 10년 이상 유지할 수 있는 보험료인가
- [ ] 해약환급금 예시표에서 원금 도달 시점(수익률 가정별)을 확인했는가
- [ ] 최저보증의 종류와 적용 조건(연금 개시 시점 등)을 이해했는가
- [ ] 펀드 라인업과 변경 가능 횟수, 자동 재배분 기능을 확인했는가
- [ ] 청약철회 기간(보험증권을 받은 날부터 15일, 청약일부터 30일 이내)을 알고 있는가

사례 — 같은 변액연금, 다른 결과

W씨와 X씨는 40세에 같은 변액연금에 월 50만 원씩 가입했습니다. W씨는 4년 차 주식시장 하락 때 적립금이 납입액보다 크게 줄자 불안해서 해지했고, 원금의 70% 수준만 돌려받았습니다. X씨는 계속 유지하면서 주식형과 채권형을 60 : 40으로 자동 재배분했고, 65세 연금 개시 시점에는 납입보험료를 웃도는 적립금으로 종신연금을 받기 시작했습니다. 시장이 나빴더라도 X씨는 최저보증(GMAB) 덕분에 납입보험료 수준의 연금 재원은 확보할 수 있었습니다. ※ 이해를 돕기 위한 가상의 사례입니다.

Q. 변액보험은 예금자보호가 되나요?

A. 특별계정(펀드)에서 운용되는 적립금은 예금자보호 대상이 아닙니다. 다만 최저사망보험금, 최저연금적립금 등 보험사가 보증한 금액과 특약 부분은 보호 대상에 포함될 수 있습니다(1인당 보호 한도 내).

Q. 수익률이 마이너스인데 해지해야 할까요?

A. 계약 초기의 마이너스는 상당 부분 사업비 때문입니다. 해지하면 손실이 확정되므로, 먼저 펀드 구성을 점검하고 납입 유예·감액·추가납입 활용 등을 검토하세요. 유지할 여력이 없다면 해지 시점의 환급금과 앞으로의 비용을 비교해 결정합니다.

CHAPTER 24 핵심 요약

- 변액보험 = 보험 + 펀드, 투자 결과는 계약자 부담, 예금자보호 원칙적 제외
- 최저보증(GMDB·GMAB·GMWB·GLWB)은 유지 조건부 — 중도 해지에는 적용 안 됨
- 초기 사업비로 원금 도달까지 오래 걸림 → **10년 이상 유지**가 전제
- 펀드 변경·자동 재배분으로 유지 중 관리가 핵심

■ 노후 준비(종신·연금·상속·변액) 종합 체크리스트

- [ ] 종신보험의 노후 활용(연금전환·유동화) 가능 여부를 확인했다.
- [ ] 3층 연금 합계와 은퇴 후 목표 생활비의 차이를 계산했다.
- [ ] 예상 상속세와 납부 재원을 확인했다.
- [ ] 변액보험의 수익률·펀드 구성을 최근 1년 안에 점검했다.
- [ ] 노후 준비 상품의 월 납입액 합계가 감당 가능한 수준인지 확인했다.

PART 7

자동차보험 · 운전자보험

자동차보험은 '남에게 입힌 손해'를, 운전자보험은 '내가 지게 될 형사책임'을 대비합니다. 둘은 대체 관계가 아니라 보완 관계입니다. 2026년 형사사법 구조 변화로 운전자보험의 변호사 보장도 새로운 국면을 맞고 있습니다.

25 자동차보험의 주요 담보와 부상등급

26 운전자보험 — 사고 후 세 가지 책임과 12대 중과실

27 운전자보험 변천사 — 2009년부터 2024년까지

28 2026년의 변화 — 경찰조사 단계와 변호사 현물급부

CHAPTER 25

자동차보험의 주요 담보와 부상등급

자동차보험은 의무보험과 임의보험으로 구성됩니다. 담보 하나하나가 누구의, 어떤 손해를 보상하는지 정확히 알아야 사고 후 당황하지 않습니다.

자동차보험의 주요 담보

담보	보상 내용
대인배상 I (책임보험·의무)	자동차 사고로 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 한 경우, 자동차손해배상 보장법에서 정한 한도 내에서 보상
대인배상 II	대인배상 I에서 지급하는 금액을 초과하는 손해를 보상. '무한'으로 가입하는 것이 일반적이며, 종합보험 가입 시 형사처벌 특례(12대 중과실·중상해·사망 제외)의 근거가 됩니다.
대물배상 (의무 2천만 원)	자동차 사고로 다른 사람의 차량이나 물건을 없애거나 훼손한 경우 보상. 고가 차량이 많아 2억~10억 원 수준으로 가입하는 추세입니다.
자기신체사고 (자손)	피보험 자동차의 사고로 피보험자 본인 또는 그 가족(부모, 배우자, 자녀) 등이 죽거나 다친 경우 보상(정액 한도 내)
자동차상해 (자상)	자손과 같은 대상이지만, 쌍방과실 사고 시 타차 대인으로 보상되지 않는 자기 과실분도 보상하며 보험금 지급 기준이 대인배상 II와 동일(실손해 기준)
자기차량손해 (자차)	타차 또는 타물체와의 충돌, 화재, 폭발 등으로 피보험 자동차에 직접 생긴 손해나 차량 전부의 도난 손해를 보상. 자기부담금 손해액의 20%(최소 20만~최대 50만 원)
무보험 자동차에 의한 상해	기명피보험자와 가족 등이 보험에 가입하지 않은 차량이나 뺑소니 차량에 의한 사고로 죽거나 다친 경우 보상

자손 vs 자상 — 둘 중 하나만 가입 가능

자기신체사고(자손)는 부상 등급별 정액 한도 안에서만 보상하지만, 자동차상해(자상)는 치료비·휴업손해·위자료 등을 실손해 기준으로 보상합니다. 보험료 차이는 크지 않은 편이므로 **자동차상해를 선택**하는 것이 유리한 경우가 많습니다. 특히 단독사고나 내 과실이 큰 사고에서 차이가 커집니다.

대인배상 I(책임보험)의 보상 한도

구분	1인당 한도
사망	최고 1억 5,000만 원(최저 2,000만 원)

구분	1인당 한도
부상	상해 등급(1~14급)에 따라 최고 3,000만 원
후유장해	장해 등급(1~14급)에 따라 최고 1억 5,000만 원

자료: 자동차손해배상 보장법 시행령. 한도를 넘는 손해는 대인배상 II에서 보상합니다.

자동차사고 부상등급(1~14급)

자동차 사고의 부상은 자동차손해배상 보장법 시행령에 따라 **1급(가장 중함)부터 14급(가장 경미함)**까지 나뉩니다. 이 등급은 자동차보험 대인배상 I의 한도를 정할 뿐 아니라, 운전자보험의 '자동차사고 부상치료비'처럼 **민간보험의 보험금 기준**으로도 쓰입니다.

등급	상해 예시	대인 I 부상 한도
1	불안정성 골반뼈 골절로 수술을 시행한 상해 / 심장 파열로 수술을 시행한 상해	3,000만 원
2	무릎관절의 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해 / 척주 손상으로 불완전 사지마비를 동반한 상해	1,500만 원
3~4	어깨관절 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해(3급) / 위팔뼈 몸통 분쇄성 골절(4급)	1,200만 / 1,000만 원
5	위팔뼈 몸통 골절 / 3개 이상의 발허리뼈 골절로 수술을 시행한 상해	900만 원
6	위팔뼈 대결절 견열 골절 / 무릎관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해	700만 원
7	손목손허리뼈 관절의 탈구 또는 골절탈구 / 엉덩관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해	500만 원
8~11	팔꿈치관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해(8급) / 손가락뼈 골절 또는 손가락관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해(11급)	300만~160만 원
12~14	팔다리 관절의 근육 또는 힘줄의 단순 염좌(12급) / 손발가락 관절 염좌(14급)	120만~50만 원

※ 8급 300만, 9급 240만, 10급 200만, 11급 160만, 12급 120만, 13급 80만, 14급 50만 원. 세부 기준은 시행령 별표를 따릅니다.

■ 경상환자(12~14급) 치료 제도 변화

2023년부터 자동차보험 경상환자(12~14급)의 치료비 제도가 바뀌었습니다. ① 사고일로부터 **4주를 넘겨 치료**받으려면 진단서 등 추가 치료의 필요성을 입증하는 서류를 제출해야 하고, ② 대인배상 II의 치료비 중 **본인 과실 비율만큼은 본인(또는 본인 보험의 자동차상해·자손)이 부담**하게 되었습니다. 쌍방과실 사고가 많은 만큼 자동차상해 담보의 중요성이 더 커졌습니다.

■ 자동차보험 절약 팁

- **운전자 범위**: 실제 운전하는 사람만으로 한정(부부한정, 1인 한정)하고 최저 연령을 올리면 보험료가 낮아집니다.
- **마일리지 특약**: 연간 주행거리가 짧으면 만기 시 보험료 일부를 돌려받습니다.
- **블랙박스·안전장치 할인**, 자녀 할인, 대중교통 이용 할인 등 특약을 확인합니다.
- **소액 사고는 자비 처리 검토**: 할증으로 3년간 늘어날 보험료와 비교해 결정합니다.

CHAPTER 25 핵심 요약

- 대인 I·대물(2천만)은 의무, 대인 II는 무한 가입이 일반적
- 자손보다 **자동차상해**가 실손해 기준이라 유리
- 부상등급 1~14급은 대인 I 한도와 운전자보험 부상치료비의 기준
- 경상환자 4주 초과 치료 시 서류 필요, 본인 과실분 치료비 자기부담

CHAPTER 26

운전자보험 — 사고 후 세 가지 책임과 12대 중과실

자동차보험에 가입했으니 사고가 나도 괜찮다? 형사처벌은 자동차보험이 대신 받아 주지 않습니다.

교통사고 발생 시 지는 세 가지 책임

민사상 책임

- 손해배상책임
- 가해자는 불법행위에 대한 책임
- 차량 보유자의 책임(운행자 책임)

→ **자동차보험**

형사상 책임

- 업무상 과실치사상 / 도로교통법 위반
- 사망, 중상해, 도주(뺑소니)
- 12대 중과실 사고

→ **운전자보험**

행정상 책임

- 운전면허의 정지·취소
- 범칙금·과태료
- 벌점 부여

→ **보험으로 대비 어려움**(면허정지·취소 위로금 담보 일부)

자동차보험 영역 vs 운전자보험 영역

자동차보험 영역

- 배상책임 손해 부분 — 상대방 치료비(대인), 상대방 수리비(대물)
- 피보험자 및 동승자의 치료비
- 자차 수리비

자동차보험으로 민사합의(대인/대물)가 이루어지면 → **종결**

운전자보험 영역

- 대인 벌금 / 대물 벌금
- 변호사 선임 비용
- 교통사고처리지원금(형사합의금)
- 교통사고처리지원금(6주 미만)
- 비탑승 중 사고 보상

사망 / 중상해 / 12대 중과실 / 뺑소니 사고 시 형사 절차 진행

■ 형사 절차의 흐름

경찰
형사입건 및 조사

›

불송치
사건 종결 가능 (혐의 없음 등)

/

송치 → 검찰
수사 및 처분

›

처분
약식기소 / 정식기소 / 구속 / 불기소

›

법원
판결 (약식명령 후 정식재판 청구 가능)

2021년 검경 수사권 조정 이후 경찰은 수사 결과 무죄 가능성이 높으면 검찰 송치 없이 사건을 종결(불송치)할 수 있게 되었습니다. 이로써 **경찰조사 단계에서의 대응**이 결과를 좌우하는 경우가 많아졌고, 이 흐름은 2026년 더욱 강화되었습니다(CHAPTER 28).

형사처벌 대상 사고 — 12대 중과실

교통사고처리 특례법은 종합보험(대인배상 II)에 가입했거나 피해자와 합의하면 가해 운전자를 처벌하지 않는 것을 원칙으로 합니다(반의사불벌·공소제기 불가). 하지만 다음 경우는 **보험 가입 여부와 상관없이 형사처벌**을 받습니다.

- 피해자가 **사망**한 경우
- 피해자가 **중상해**(생명에 대한 위험, 불구, 불치나 난치의 질병)를 입은 경우
- **도주(뺑소니)** 또는 사고 후 피해자를 유기한 경우
- 다음 **12대 중과실**로 사람을 다치게 한 경우

No	12대 중과실	No	12대 중과실
1	신호·지시 위반	7	무면허 운전 (운전자보험 보상 안 됨)
2	중앙선 침범, 고속도로 횡단·유턴·후진	8	음주·약물 운전 (운전자보험 보상 안 됨)
3	제한속도 20km/h 초과 과속	9	보도 침범, 보도 횡단 방법 위반
4	앞지르기 방법·금지 위반, 끼어들기 금지 위반	10	승객 추락 방지 의무 위반
5	철길 건널목 통과 방법 위반	11	어린이 보호구역 안전운전 의무 위반 (2009.12.22 신설)
6	횡단보도 보행자 보호 의무 위반	12	화물 고정 조치 위반 (2017.12.3 신설)

처벌 수준

위 사고의 경우 보험 가입 여부와 관계없이 형사처벌을 받게 되며 **5년 이하의 금고 또는 2천만 원 이하의 벌금**에 처합니다(교통사고처리 특례법 제3조). 어린이 보호구역에서 어린이를 사망하게 하면 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」에 따라 무기 또는 3년 이상의 징역, 상해를 입히면 1년 이상 15년 이하의 징역 또는 500만 원 이상 3천만 원 이하의 벌금에 처합니다(이른바 민식이법, 2020.3.25 시행).

운전자보험으로 형사합의금을 보상받을 수 있지만…

운전자보험은 위 사고에서 형사합의금(교통사고처리지원금), 벌금, 변호사 선임 비용을 보상합니다. 단, **음주·무면허·뺑소니는 보상하지 않습니다.**

운전자보험 핵심 담보 정리

담보	보상 내용	권장 가입금액(일반적)
교통사고처리지원금	피해자와의 형사합의금. 피해자 부상 정도(6주 이상, 중상해, 사망)에 따라 한도 차등. 최근 6주 미만 사고와 일반 교통사고 중상해도 보장 확대	최대 2억 원 수준
변호사 선임 비용	형사 절차에서 변호사를 선임한 비용. 경찰조사 단계부터 보장하는 상품 확대	최신 약관 기준 가입금액 확인
벌금(대인)	대인 사고로 확정된 벌금	2,000만 원(스쿨존 3,000만 원)
벌금(대물)	대물 사고로 도로교통법상 벌금이 확정된 경우	500만 원
자동차사고 부상치료비	운전자 본인이 다쳤을 때 부상등급(1~14급)에 따라 정액 지급	등급별 금액 확인
면허정지·취소 위로금	운전면허가 정지·취소된 경우	선택

Q. 자동차보험에 '형사합의 지원' 특약이 있는데 운전자보험이 또 필요한가요?

A. 자동차보험의 법률비용지원 특약도 운전자보험과 비슷한 기능을 합니다. 두 개를 가입하면 비례보상되는 담보(교통사고처리지원금 등)는 중복으로 받지 못할 수 있으므로, 한쪽으로 정리하는 것이 효율적입니다. 다만 운전자보험은 내 차가 아닌 차(렌터카, 회사 차)를 운전하거나 자전거·킥보드 사고까지 보장하는 경우가 많아 보장 범위가 넓습니다.

Q. 운전을 거의 안 하는데 운전자보험이 필요한가요?

A. 운전 빈도와 관계없이 사고 한 번의 형사 비용은 수천만 원이 될 수 있습니다. 운전자보험은 월 1만 원 안팎의 저렴한 상품이 많고, 비탑승 중 사고·보행 중 사고를 보장하는 상품도 있어 가성비가 높은 보험입니다.

CHAPTER 26 핵심 요약

- 민사 = 자동차보험, 형사 = 운전자보험, 행정 = 보험 대비 어려움
- 사망·중상해·뺑소니·12대 중과실은 보험 가입과 무관하게 형사처벌
- 운전자보험 3대 담보: 교통사고처리지원금·변호사 선임비용·벌금
- 음주·무면허·뺑소니는 보상 불가

CHAPTER 27

운전자보험 변천사 — 2009년부터 2024년까지

운전자보험의 비용 담보는 법 개정과 함께 바뀌어 왔습니다. 오래전에 가입한 운전자보험이라면 지금의 형사 절차를 감당하지 못할 수 있습니다.

연도별 주요 변화

연도	내용
2009년	[10월] 합의금 담보 변경: 형사합의지원금 → 교통사고처리지원금, 정액보상 → 실손보상 / 동승자 면책 → 동승자 보상 [11월] 중상해 교통사고처리지원금 출시
2011년	[4월] 초과이익 담보 삭제 → 할증지원금, 렌트비용지원금 등 [6월] 법률비용 담보 변경: 방어비용 → 변호사선임비용 / 정액보상 → 실손보상
2017년	[4월] 교통사고처리지원금 후지급 → **선지급** 보상
2018년	[1월] 자동차 대물벌금 출시
2018~2019년	교통사고처리지원금 보장 확대 3천만 → 5천만 → 7천만 → 1억 원
2020년	**[4월] 스쿨존 벌금 — 민식이법 시행(2020.3.25)** **· 스쿨존 사고 시 벌금 확대 2천만 → 3천만 원** **· 교통사고처리지원금(6주 미만) 신설**
2021년	[4월] 대인·대물 벌금 **선지급** 시행 [8월] 변호사선임비용: 약식명령 후 정식재판 보장
2022년	[10월] 변호사선임비용: **경찰조사 단계** 보장(검경수사권 조정 반영) [10월] 교통사고처리지원금: 공탁금 50% 선지급 시행
2023년	[7월] 변호사선임비용: 변호사 선임 50% 선지급 시행 [8월] 교통사고처리지원금/보장기간 변경: 일반 교통사고 중상해 보장 확대, 세만기 삭제 → 최장 20년 만기
2024년	**[8월] 교통사고처리지원금 공탁금 100% 선지급(보험금 지급한도의 50%), 변호사 선임비용 가입금액 70% 선지급(보험금 지급한도의 70%)** **[11월] 비탑승 중 사고 보장**

변화의 배경 이해하기

민식이법 시행(2020)

운전자가 스쿨존에서 어린이를 다치게 하거나 죽게 한 경우 가중처벌하는 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 개정안으로 벌금이 상향 조정되었습니다. 운전자보험의 스쿨존 벌금 한도도 3천만 원으로 올랐습니다.

검경수사권 조정(2021~2022)

교통사고 시 경찰은 수사 결과 무죄 가능성이 높은 경우 검찰 기소 전 사건을 종결할 수 있게 되면서, 경찰조사 단계부터 변호사 선임의 중요성이 커졌습니다.

공탁제도 개정(2022)

피해자의 주민등록번호, 주소 확인 없이 사건번호로 공탁이 가능해졌습니다. 운전자보험에서 해당 특약 가입 시 지불한 공탁금에 대해 일부 선지급이 가능해졌습니다.

비탑승 중 사고 보장(2024)

해당 특약 가입 시 운전 후 비탑승 상태에서 급격하고 우연히 발생한 자동차 사고(언덕 주정차, 차문 사고, 도로 주정차 사고 등)에 대해서도 형사합의금 지급이 가능합니다.

오래된 운전자보험, 이것을 확인하세요

- 교통사고처리지원금이 **1억 원 미만**이거나 6주 미만 사고·중상해를 보장하지 않는다
- 변호사선임비용이 **기소 이후(재판 단계)**만 보장하고 경찰조사 단계는 보장하지 않는다
- 스쿨존 벌금이 2천만 원 한도다
- 대물벌금 담보가 없다
- 선지급 제도가 없어 합의금을 먼저 마련해야 한다

운전자보험의 비용 담보는 가입금액이 과거에 비해 크게 올랐습니다. 시대에 맞는 가입금액으로 손해를 예방하고, 법률 개정으로 그때그때 맞는 보장을 준비해야 합니다.

사례 — 2015년 가입 운전자보험의 한계

K씨는 횡단보도에서 보행자를 치어 전치 10주의 부상을 입혔습니다(12대 중과실). 피해자는 형사합의금으로 3,000만 원을 요구했고 경찰 조사가 시작되었습니다. K씨의 2015년 가입 운전자보험은 교통사고처리지원금 한도가 3,000만 원이어서 합의금은 해결됐지만, **후지급 방식**이라 K씨가 먼저 3,000만 원을 마련해야 했고, 변호사선임비용은 **기소된 경우에만** 보장해 경찰조사 단계의 변호사 비용 400만 원은 자비로 부담했습니다.

Q. 자전거나 전동킥보드 사고도 운전자보험으로 보장되나요?

A. 운전자보험의 기본 담보는 '자동차 운전 중 사고'를 대상으로 합니다. 자전거·개인형 이동장치(전동킥보드) 사고는 별도 특약이 있어야 보장되며, 최근 이를 보장하는 특약이 늘고 있습니다. 전동킥보드는 도로교통법상 '차'에 해당해 사고 시 형사 책임이 생길 수 있으니 이용이 잦다면 특약을 확인하세요.

CHAPTER 27 핵심 요약

- 교통사고처리지원금: 정액 → 실손, 3천만 → 1억+, 후지급 → 선지급 → 공탁금 100% 선지급
- 변호사선임비용: 재판 → 약식 후 정식재판 → 경찰조사 단계, 50% → 70% 선지급
- 벌금: 대물벌금 신설, 스쿨존 3천만 원, 선지급
- 2024년 비탑승 중 사고까지 보장 확대

CHAPTER 28

2026년의 변화 — 경찰조사 단계와 변호사 현물급부

교통사고 대응의 무게중심이 '재판'에서 '첫 경찰 조사'로 옮겨 가고 있습니다. 운전자보험은 변호사 비용을 주는 방식에서 변호사를 직접 붙여 주는 방식으로 진화하고 있습니다.

2026년 10월, 달라지는 형사 구조

언론 보도(로이슈, 2026.8.19)에 따르면 2026년 10월 2일 개정 형사소송법 시행으로 수사 구조가 개편되면서 **초기 경찰조사의 중요성**이 더 커질 전망입니다. 보도가 짚은 핵심은 세 가지입니다.

① 경찰조사 단계의 중요성 확대

수사 구조 개편에 따라 피의자가 마주하는 첫 단계인 경찰 조사의 중요성이 한층 부각될 전망입니다.

② 첫 출석 전 법적 대응 전략

첫 경찰 출석 전부터 치밀한 법적 대응 전략을 수립하는 자세가 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

③ 초기부터 변호사 조력 필요

형사법적 절차의 무게중심이 초기 수사 단계로 이동하므로, 조사 후 사후 약방문식 대책보다 처음부터 치밀한 법적 대응이 필수입니다.

※ 법 개정의 구체적 내용과 시행 일정은 법무부·경찰청 공식 발표를 확인하세요.

변호사 '현물급부'란

기존 운전자보험의 변호사선임비용은 운전자가 **직접 변호사를 찾아 선임하고, 비용을 보험금으로 돌려받는** 방식이었습니다. 하지만 사고 직후 경황이 없는 상태에서 교통사고에 밝은 변호사를 빨리 찾기란 쉽지 않고, 선임비용을 먼저 마련해야 하는 부담도 있었습니다.

현물급부 방식은 보험사가 제휴한 법무법인의 변호사를 **보험금 대신 직접 제공**하는 방식입니다. 사고 접수 후 보험사를 통해 변호사가 배정되므로, 첫 경찰 출석 전부터 조력을 받을 수 있다는 장점이 있습니다.

선임비용 보장(기존)

- 변호사를 직접 선택할 수 있음
- 먼저 비용을 지급하고 보험금 청구(선지급 70% 가능)
- 가입금액 한도 내에서 실손 보상

현물급부(신규)

- 보험사 제휴 법무법인 변호사가 배정
- 비용 선납 부담 없음
- 사고 초기 신속 대응에 유리
- 변호사 선택의 폭은 제휴 법인 범위로 제한

보험사별 변호사 현물급부 비교(2026년)

구분	메리츠화재	DB손해보험	하나손해보험
2026년 판매 시점	**10월** 출시 예정	8월 1일	5월 11일
담보 보장방식	선택 가능 ① 변호사 현물급부 ② 선임비용 보장	선택 가능 ① 변호사 현물급부 ② 선임비용 보장	선택 불가 변호사 현물급부 단일
기존 고객 소급 여부	소급 적용 ◯ 별도 배서 불필요 ※ 특정 담보 제외	소급 적용 ◯ 별도 배서 불필요 ※ 특정 담보 제외	소급 적용 × 별도 변경배서로 담보 변경 가능 (2026.4.1~5.10 가입 고객)
제공 법무법인	6개 법무법인 전국망 시스템 운영 예정	1개 법무법인 제공	교통사고 특화 법무법인 제공

※ 메리츠·DB 소급 적용 제외: ① 심급별 500만 원 보장 변호사비용담보(2026.1.1부터 판매) ② 보장금액 500만 원 미만 변호사비용담보. 보험사 비교는 2026년 8월 보도 및 각사 안내 자료 기준이며, 실제 보장 및 적용 여부는 해당 약관과 회사 안내를 확인하세요. 특정 상품의 가입을 권유하는 내용이 아닙니다.

내 운전자보험, 지금 점검할 것

1. **변호사선임비용이 경찰조사 단계부터 보장되는지** 확인합니다(2022년 10월 이전 가입 상품은 대개 기소 이후만 보장).
2. **현물급부 소급 적용 대상인지** 가입한 보험사에 문의합니다. 대상이라면 별도 절차 없이 이용할 수 있는지, 배서가 필요한지 확인합니다.
3. **교통사고처리지원금 한도와 선지급 여부**(공탁금 100% 선지급)를 확인합니다.
4. **비탑승 중 사고 보장** 특약 유무를 확인합니다.
5. 보장 내용이 크게 부족하다면, 운전자보험은 보험료가 저렴하므로 **최신 상품으로 새로 가입하는 것**이 합리적인 경우가 많습니다(기존 계약 해지는 새 계약 성립 후).

■ 사고 직후 행동 요령

- ☐ 즉시 정차 후 피해자 구호, 112·119 신고(현장 이탈은 뺑소니가 될 수 있음)
- ☐ 현장 사진·블랙박스 영상 확보
- ☐ 자동차보험사 사고 접수(대인·대물 처리)
- ☐ 운전자보험사 사고 접수 → 변호사 현물급부 또는 선임비용 보장 확인
- ☐ 첫 경찰 출석 전 변호사와 진술 전략 상의
- ☐ 형사합의 진행 시 운전자보험의 교통사고처리지원금(선지급·공탁금) 활용

Q. 현물급부로 배정된 변호사가 마음에 들지 않으면 어떻게 하나요?

A. 상품에 따라 제휴 법무법인 안에서 변호사 변경을 요청할 수 있는 경우가 있고, '선임비용 보장'과 '현물급부' 중 선택할 수 있는 상품이라면 직접 선임 후 비용을 청구하는 방식으로 바꿀 수도 있습니다. 가입 전에 변경 절차와 선택 가능 여부를 확인해 두세요.

CHAPTER 28 핵심 요약

- 2026년 형사 구조 개편 → **첫 경찰조사 단계**의 대응이 결과를 좌우
- 변호사 현물급부 = 보험사 제휴 변호사를 직접 제공, 사고 초기 대응에 유리
- 보험사별 판매 시점·선택 가능 여부·소급 적용·제휴 법무법인 수가 다름
- 교통사고 대응, 경찰조사 단계부터 나를 도와줄 변호사가 중요

PART 8

치아보험

치과 치료비는 대부분 비급여라 건강보험과 실손보험의 도움을 거의 받지 못합니다. 임플란트 하나에 수백만 원이 드는 현실에서, 치아보험의 구조와 가입 타이밍, 그리고 치과 치료의 종류와 비용을 정리합니다.

29 치아보험 — 급여·비급여 구조와 가입 전 주의사항

30 치과 치료의 종류와 비용

CHAPTER 29

치아보험 — 급여·비급여 구조와 가입 전 주의사항

치과 치료비의 대부분은 비급여이고, 실손보험은 치과 비급여를 보상하지 않습니다. 치아보험이 따로 존재하는 이유입니다.

치과 치료비의 급여·비급여 구분

급여 항목(건강보험 적용)

- **발치**: 사랑니 발치, 수술 발치, 비교정 목적의 발치
- **스케일링**: 만 19세 이상 연 1회
- **파노라마 사진**: 치아 상태 진단을 위한 엑스레이
- **만 65세 이상 임플란트**(평생 2개, 본인부담 30%), **틀니**(본인부담 30%)
- **치과 정기검진**, 구강검진
- **신경치료**: 충치·신경염증으로 통증 유발 시
- 만 12세 이하 영구치 광중합형 레진 충전

비급여 항목(전액 본인부담)

- **충전치료**: 고급 재료(금, 세라믹, 성인 레진 등)를 사용하는 충전치료
- **보철치료**: 치아를 인공적으로 만들어 주는 치료 — 임플란트, 브릿지, 틀니 등(65세 미만)
- **치아교정**: 치아를 바르게 배열하기 위한 교정치료
- **치아미백**: 외관상 보기 좋게 하는 미백치료, 라미네이트 등

■ 치과 치료비, 누가 내고 있나



자료: 보건복지부(2016) 치과 치료비 분석 자료 기준.

치과 치료비의 약 84%가 비급여 본인부담이라는 분석이 있을 정도로, 치과는 건강보험의 보장률이 가장 낮은 진료 영역입니다. 게다가 **실손의료보험은 치과 치료 중 급여 항목만 보상**하고, 임플란트·크라운 같은 비급여 보철치료는 보상하지 않습니다(상해로 인한 치아 파절 등 일부 예외). 치아보험은 바로 이 공백을 메우는 상품입니다.

치아보험의 주요 담보

담보	보장 내용	지급 방식(일반적)
보존치료	충전(아말감·레진·금·세라믹 등), 크라운	치아 1개당 정액, 재료별 차등
보철치료	임플란트, 브릿지, 틀니	치아 1개당 정액(연간 한도 확인)

담보	보장 내용	지급 방식(일반적)
치주치료	잇몸 치료(치근활택술, 치주소파술 등)	치료당 정액
신경치료(근관치료)	치수 제거 후 충전	치아당 정액
스케일링	연 1회 등	소액 정액
영구치 발거	영구치를 뽑은 경우	치아당 정액

치아보험 계약 전 알릴의무

치아보험은 다른 건강보험보다 알릴의무가 간단합니다. 아래 3가지 중 해당이 없으면 **무사통과**입니다.

No	질문	답변
1	현재 틀니를 하고 계십니까?	☐ 예 ☑ 아니오
2	최근 1년 이내 충치로 의사로부터 진찰 또는 검사를 통해 치료, 투약 같은 의료행위를 받은 사실이 있거나, 치료가 필요하다는 진단을 받은 적이 있습니까?	☐ 예 ☑ 아니오
3	최근 5년 이내에 치주질환으로 치아를 한 개 이상 상실하거나 치주수술을 받았거나 치주 수술이 필요하다는 진단을 받은 적이 있습니까?	☐ 예 ☑ 아니오

※ 상품별로 질문이 다를 수 있습니다. 치과 진료 기록은 보험금 청구 시 확인되므로 사실대로 답해야 합니다.

가입 전 주의사항 5가지

항목	내용
1. 보장개시일	상해는 가입일부터, 질병은 **면책기간 91일째부터** 개시. 보철치료는 감액기간(1~2년간 50% 지급 등)이 존재하므로 보험사별 조건 비교 필수
2. 면책조항	이미 발치한 치료가 있을 경우 해당 치아의 보철치료는 면책이므로 **가입 전 치료 이력을 꼭 확인**해야 함
3. 보험료 납입	갱신형의 경우는 가급적 갱신 기간이 긴 것으로 선택하는 게 유리
4. 연간 보장횟수	연간 보장 횟수 제한이 없는 보험을 선택하는 것이 유리(임플란트 연간 3개 한도 등 확인)
5. 고지의무	가입 전 질문 사항에 정확히 답해야 정확한 보장 가능

치아보험 가입 타이밍의 함정

치과에서 "임플란트 해야겠네요"라는 말을 듣고 나서 치아보험에 가입하면, 해당 치아는 알릴의무 위반이거나 면책·감액기간에 걸려 보험금을 받기 어렵습니다. 치아보험은 **치아가 건강할 때, 큰 치료가 예상되기 최소 1~2년 전**에 가입해 두어야 제 역할을 합니다. 당장 치료가 필요한 치아가 있다면 그 치아를 먼저 치료하고 가입하는 편이 낫습니다.

Q. 치아보험 보험금보다 보험료를 더 많이 내는 것 아닌가요?

A. 치아보험은 사용 빈도가 높은 만큼 보험료도 적지 않습니다. 임플란트처럼 고액 치료 가능성이 높은 중장년층에게는 효용이 크지만, 치아 상태가 매우 좋고 정기 관리를 잘하는 경우에는 납입 보험료 총액과 예상 치료비를 비교해 결정하세요.

Q. 실손보험으로 치과 치료는 전혀 안 되나요?

A. 치과의 급여 항목(발치, 신경치료, 잇몸 치료 중 급여 부분 등)은 실손에서 보상됩니다. 사고로 치아가 부러진 경우(상해)는 세대에 따라 일부 비급여도 보상되는 경우가 있습니다. 질병으로 인한 임플란트·크라운 등 비급여 보철은 보상되지 않습니다.

CHAPTER 29 핵심 요약

- 치과 치료비 대부분은 비급여, 실손은 치과 비급여 보철을 보상하지 않음
- 알릴의무: 틀니·1년 내 충치 치료·5년 내 치주질환 치아 상실·수술
- 질병 보장은 91일째부터, 보철 감액기간 존재, 기존 발치 부위 면책

CHAPTER 30

치과 치료의 종류와 비용

치과에서 듣는 낯선 용어들, 그리고 영수증의 금액이 왜 그렇게 나오는지 한 번에 정리합니다.

잇몸 치료 — 치주질환의 진행 단계

단계	상태	주요 치료	구분
건강함	분홍색이고 단단한 상태	정기검진	비외과적
치은염	잇몸이 붉으며 붓고 피나는 상태	스케일링	
초기 치주염	치아 주변의 뼈와 조직 소실 시작	치근활택술	외과적
중기 치주염	치아 주변의 뼈와 조직 파괴 시작	치주소파술	
말기 치주염	심각한 뼈와 조직 파괴, 치아 손실	잇몸절개 (치은박리소파술)	

치주질환(잇몸병)은 성인이 치아를 잃는 가장 큰 원인입니다. 초기에는 통증이 거의 없어 방치하기 쉽지만, 말기에 이르면 결국 발치 후 임플란트로 이어집니다. 연 1회 건강보험 스케일링만 꾸준히 받아도 상당 부분 예방할 수 있습니다.

보존치료 — 자연치아를 살리는 치료

치료	내용	평균 치료비(예시)
인레이	금이나 도재로 본을 떠서 시멘트로 합착하는 치료. 충전 면적이 적을 때 하는 치료	10~20만 원
온레이	인레이와 같은 치료지만 윗면과 옆면까지, 인레이보다 충전 면적이 넓을 때 하는 치료	20~50만 원
크라운	금이나 세라믹 등의 충전물로 치아를 덮어 치아의 형태와 기능을 재생시켜 주는 치료	35~80만 원

보철치료 — 잃은 치아를 대신하는 치료

치료	내용	평균 치료비(예시)
임플란트	영구치 빠진 자리에 인공치아를 심는 인공대치물. 주로 티타늄 금속을 사용해 유착시킨 후, 그 위에 보철물을 고정시켜 치아의 역할을 대체하는 치료	70~150만 원 수입 재료: 100~300만 원
틀니	상실된 치아를 대신하는 인공치아와 그 구조물. 직접 탈·부착이 가능한 치료	부분: 150만 원 전체: 200만 원
브릿지	상실된 치아 주변의 두 개 또는 그 이상의 치아를 기둥 삼아, 그 위에 보철물을 고정시켜 치아의 역할을 대체하는 치료	30~50만 원(치아당)

※ 치료비는 지역·치과·재료에 따라 차이가 크므로 참고용입니다. 건강보험심사평가원 '비급여 진료비 정보'에서 치과별 가격을 비교할 수 있습니다.

보존치료 재료별 특징

재료	특징	비용(예시)
아말감	은·구리·주석이 들어 있는 금속 가루와 수은의 혼합체. 심미성이 떨어져 현재는 거의 사용하지 않음	1~2만 원 (보험 적용)
글래스아이오노머(GI)	산 부식처리가 필요 없는 화학접착으로 치아에 직접적으로 수복하는 재료	1~2만 원 (보험 적용)
레진	세라믹에 비해 비용이 저렴하고 치아에 직접 충전함. 강도가 아말감·GI보다 강하나 변색될 수 있음	5~20만 원
세라믹	심미성과 강도가 뛰어나지만 비용이 많이 듦	상대적으로 고가
골드	강도·경도가 자연치아와 유사하지만 심미성이 떨어짐	금 시세 영향

치아보험 청구 시 확인할 것

- [ ] 치료한 **치아 번호**(치식)와 치료 내용이 적힌 진단서·치료확인서
- [ ] 보철치료 시 **발치일과 보철 시작일**(감액·면책기간 판단)
- [ ] 사용 재료(레진·세라믹·금 등) — 재료별로 보험금이 다른 상품
- [ ] X-ray 등 치료 전후 영상 자료(보험사 요청 시)
- [ ] 연간 보장 한도(임플란트 개수 등) 소진 여부

사례 — 50대 L씨의 치과 치료 견적

L씨는 어금니 2개를 발치하고 임플란트 2개(개당 120만 원), 옆 치아 크라운 1개(50만 원), 잇몸 치료(치주소파술)를 받아야 한다는 견적을 받았습니다. 총비용은 약 300만 원. 3년 전 가입한 치아보험(임플란트 개당 100만 원, 크라운 20만 원)에서 220만 원을 받았고, 잇몸 치료의 급여 부분은 실손에서 일부 보상받았습니다. L씨가 1년 전에 가입했다면 보철 감액기간 때문에 절반만 받았을 것입니다.

CHAPTER 30 핵심 요약

- 잇몸병: 치은염(스케일링) → 치주염(치근활택·소파술·잇몸절개) → 발치
- 보존: 인레이 < 온레이 < 크라운 / 보철: 브릿지·틀니·임플란트
- 아말감·GI는 건강보험, 레진(성인)·세라믹·골드는 비급여

■ 치아보험 점검 체크리스트

- [ ] 치아보험의 보철 감액기간과 연간 한도를 확인했다.
- [ ] 치료 예정 치아가 면책 대상인지 확인했다.
- [ ] 질병 보장 개시일(91일째)이 지났는지 확인했다.
- [ ] 갱신형이라면 갱신 주기와 인상 예상액을 확인했다.
- [ ] 만 65세 이상 가족의 건강보험 임플란트·틀니 지원 이용 여부를 확인했다.

PART 9

화재보험

화재는 내 집만이 아니라 이웃집 피해까지 배상해야 하는 위험입니다. 2009년 실화책임법 개정 이후 달라진 배상 책임, 세입자의 원상복구 의무, 그리고 화재보다 훨씬 자주 일어나는 누수 사고까지 주택화재보험으로 대비하는 법을 다룹니다.

31 주택화재보험과 실화책임법

CHAPTER 31

주택화재보험과 실화책임법

"작은 실수로 낸 불이니까 괜찮겠지"는 2009년 이전 이야기입니다. 지금은 실수로 낸 불이 이웃집에 번지면 그 손해를 모두 배상해야 합니다.

실화책임에 관한 법률(2009.5.8 시행)

- **개정 전**: 경과실 사고(누전, 가스사고 등)에 대해서는 면책 사항이었으나, 실화책임법 개정 이후로 **과실의 경·중 구분 없이 실화자가 손해배상 책임을 부담**합니다. 단, 경과실임에도 불구하고 대형 피해가 발생하거나 화재 확대에 다른 요인이 개입된 경우에만 배상책임 경감 청구가 가능합니다.
- **적용 대상**: 모든 주택(아파트, 빌라, 다세대, 단독주택 등)과 상가
- **아파트의 경우**: 단체 주택화재보험이 가입되어 있으나 보장 금액이 적게 책정되어 있거나, 실화자 집의 가재도구뿐만 아니라 배상 부분은 보상되지 않는 경우가 대부분입니다.
- **세입자**: 민법상 임차인은 임대계약이 끝나고 퇴거 시 점유지를 원상 복구할 의무를 집니다. 따라서 화재 발생 시 내부 수리 비용은 임차인의 책임입니다.
- **과실에 따른 화재벌금 부과**: 실화로 인해 피해를 입혔을 경우 1,500만 원 이하(실화죄) 또는 2,000만 원 이하(업무상실화·중실화)의 벌금에 처해질 수 있습니다.

임차인 과실 화재 시 보험금의 흐름

화재 발생
임차인의 과실

›

임대인(집주인)
본인 화재보험에서 보험금 수령

›

임대인의 보험사
지급한 보험금만큼 임차인에게 **구상권 청구**

›

임차인
보험이 없으면 전액 자비 부담

임대인: 가입 / 임차인: 미가입 → 임차인이 위험하다

임차인의 과실로 화재가 발생하면 임대인은 보험사로부터 보험금을 지급받고, 보험사는 임차인에게 구상권을 청구합니다. **집주인의 가입 유무와 상관없이 세입자도 화재보험(임차자 배상책임 포함)에 가입해야 합니다.**

주택화재보험의 주요 담보

담보	보상 내용
화재 손해(건물·가재도구)	화재·낙뢰·폭발 등으로 우리 집 건물과 가재도구에 생긴 손해

담보	보상 내용
화재배상책임	우리 집에서 난 불이 이웃집으로 번져 생긴 손해를 배상(실화책임법 대응)
임차자 배상책임	세입자가 빌려 쓰는 집에 낸 화재 손해를 집주인에게 배상
급배수 누출 손해	배관 누수로 아랫집 천장·벽지 등에 생긴 손해(배상) 및 우리 집 수리비
가전제품 수리비	고장 난 가전제품의 수리비(가입 후 일정 기간·연식 조건)
화재 벌금	실화죄 등으로 확정된 벌금
임시거주비·잔존물 제거비	화재 후 거주가 불가능할 때의 임시 거주 비용, 잔해 처리비
일상생활배상책임	일상생활 중 타인에게 입힌 손해 배상(중복 가입 주의 — CHAPTER 01)

■ 화재보험이 필요한 이유

- **실화법 개정!** 이웃집에 번진 불의 피해까지 배상해야 합니다.
- 화재 발생 시 과실에 따라 **벌금**이 부과됩니다.
- 화재보험은 우리 집의 안전과 소중한 재산은 물론, 실화로 인한 배상 책임과 벌금 등 각종 위험으로부터 보호하기 위해 꼭 필요합니다.
- 비싼 가전제품 수리비와 **급배수 누출 손해**까지 보장받을 수 있습니다. 실제로 화재보다 누수 사고가 훨씬 자주 일어납니다.

가입금액 정하기 — 비례보상에 주의

주택화재보험은 건물의 실제 가치(보험가액)에 비해 너무 적게 가입하면 손해액 전부를 받지 못하고 **비례보상**을 받습니다. 일반적으로 주택물건은 보험가입금액이 보험가액의 **80% 이상**이면 손해액 전액(가입금액 한도)을 보상하고, 그 미만이면 다음 식으로 줄여서 보상합니다.

지급보험금 = 손해액 × 보험가입금액 ÷ (보험가액 × 80%)

계산 예시

보험가액 2억 원인 주택을 1억 원에 가입했는데 4,000만 원의 화재 손해가 났다면, 4,000만 원 × 1억 ÷ (2억 × 80%) = **2,500만 원**만 지급됩니다. 1억 6,000만 원 이상 가입했다면 4,000만 원 전액을 받을 수 있었습니다.

Q. 아파트 관리비에 화재보험료가 포함돼 있는데 따로 가입해야 하나요?

A. 아파트 단체 화재보험은 주로 건물 골조와 공용부분을 대상으로 하고, 가입 금액도 시가보다 낮은 경우가 많습니다. 우리 집 가재도구, 이웃집 배상책임, 누수 배상은 보장되지 않는 경우가 대부분이므로 개인 주택화재보험(배상책임 포함)을 함께 가입하는 것이 좋습니다.

Q. 누수로 아랫집 천장이 망가졌어요. 어떤 보험으로 처리하나요?

A. 주택화재보험의 급배수 누출 손해 담보나 일상생활배상책임 담보로 처리할 수 있습니다. 배상책임은 누수의 원인이 우리 집의 관리 소홀인지(소유자·점유자 책임)에 따라 누가 배상할지가 달라지므로, 소유자와 세입자 모두 배상책임 담보를 갖추는 것이 안전합니다.

CHAPTER 31 핵심 요약

- 2009년 이후 경과실 화재도 이웃 피해 전액 배상 책임
- 세입자도 원상복구 의무 → 임차자 배상책임 필수
- 화재배상·급배수 누출·가전 수리비·벌금까지 한 번에
- 보험가액의 80% 이상 가입해야 비례보상을 피함

■ 화재보험 점검 체크리스트

- [ ] 우리 집 건물의 보험가액 대비 가입금액이 80% 이상인지 확인했다.
- [ ] 아파트 단체 화재보험의 보장 범위(가재도구·배상책임 포함 여부)를 확인했다.
- [ ] 주택화재보험에 화재배상책임·임차자배상책임이 있는지 확인했다.
- [ ] 급배수 누출 손해 담보가 있는지 확인했다.
- [ ] 가족 전체의 일상생활배상책임 중복 여부를 확인했다.

PART 10

실손의료보험 1~5세대

'제2의 건강보험'이라 불리는 실손의료보험은 약 4,000만 명이 가입한 국민보험입니다. 그러나 언제 가입했느냐에 따라 보장과 보험료가 완전히 다른 상품입니다. 세대별 차이를 이해하고, 5세대 실손으로 갈아탈지 판단하는 계산법까지 정리합니다.

32 의료실비 변천사 — 1세대부터 4세대까지

33 실손에서 보상하지 않는 사항

34 4세대 실손의 주요 특징 — 일반·유병자·노후

35 보험료 차등제와 구실손 vs 4세대 유불리

36 5세대 실손보험, 무엇이 달라지나

37 5세대 전환 손익 계산 — BEP로 판단하기

38 5세대 전환 평가 주요 포인트

CHAPTER 32

의료실비 변천사 — 1세대부터 4세대까지

같은 '실손'이라도 2008년에 가입한 사람과 2022년에 가입한 사람의 보장은 전혀 다릅니다. 내 실손이 몇 세대인지부터 확인하세요.

세대 구분 한눈에 보기

구분	1세대(구실손)	2세대(표준화)	3세대(착한실손)	4세대(개정실손)
판매 시기	손보 2003.10~ 생보 2008.5~	2009.10(8)~ 1차 2013.4~ / 2차 2015.9~ / 3차 2016.1~	2017.4~	2021.7~
갱신 주기	손보 5년(일부 3년) 생보 3년	표준화 3년 → 개정 후 1년	1년 (단독실손 2018.4)	1년
보험기간	80세/100세 만기 (생보 80세)	100세 만기 → 재가입 주기 15년	재가입 주기 15년	**재가입 주기 5년**
입원 보장비율	손보 100% 생보 80%	90% → 표준형 80%·선택형 90%	급여 90% / 비급여 80%	급여 80% / 비급여 70%
입원 본인부담	손보 없음 생보 20%	10%(연간한도 200만) → 20%	급여 10% / 비급여 20% (연간한도 200만)	급여 20%(연간한도 200만) 비급여 30%(**계속 공제**)
입원 한도	상해: 사고일 365일 후 보상종료 질병: 발병일 365일 후 180일 면책	입원일 365일 후 90일 면책	5천만 원(보상한도 소진 시 90일 면책)	상해·질병 각 급여 5천만 / 비급여 5천만(각 소진 시)
상급병실	2인실 기준 차액 50%	차액 50%, 1일 10만 원 한도	차액 50%, 1일 10만 원	비급여 병실료 50%, 1일 10만 원
외래 보장한도	10/30/50만 원 (외래+처방 합산)	25만/20만/15만 원(회당)	25만/20만/15만 원	상해·질병 급여 20만 비급여 20만(외래+처방 합산)
외래 본인부담	5천 원 공제 (외래+처방 합산)	의원 1만/병원 1.5만/ 상급종합 2만 원 vs 20% 중 큰 금액	의원 1만/병원 1.5만/상급종합 2만 vs 급여 10%+비급여 20% 중 큰 금액	급여: 의원·병원 1만, 종합병원 2만 vs 20% 비급여: 3만 vs 30% 중 큰 금액
통원 한도	사고일 연간 30회 180일 면책	연간 180회(외래·처방 각각)	연간 180회	비급여 연간 100회 (입원+통원 합산 연간 5,000만 원)
3대 비급여	입원/통원 기준으로 보장(별도 한도 없음)		특약 분리, 2만 원 vs 30% 중 큰 금액, 개인별 할증 없음	특약, 3만 원 vs 30% 중 큰 금액, **개인별 할증 있음**

※ 보험사·가입 시점별로 세부 조건이 다를 수 있으며, 실제 보장은 가입 당시 약관을 따릅니다.

세대별 그 밖의 차이

구분	1세대(손해/생명)	2세대(표준화)	3세대	4세대
3대 비급여 한도 MRI·도수/증식/체외충격파·주사	입원/통원 기준으로 보장 가능		연간 MRI 300만 도수·증식·체외충격파 350만(50회) 주사료 250만(50회)	연간 MRI 300만 도수·증식·체외충격파 350만(50회) **10회 이후 증상 개선 서류 필수** 주사료 250만(50회)
무사고 할인	없음 / 10%	10%(표준화) → 없음	2년 / 담보별 10%	2년 / 전체 10%
산재·자동차보험	본인부담금 40% / 32%	본인부담금 40%	본인부담금 급여 90%·비급여 80%	본인부담금 급여 80%·비급여 70%
정신과	×		급여만 보장(2016.1~): 우울증·조울증·공황장애·기억상실·ADHD·편집증·외상후 스트레스장애·틱장애 F04~F09, F20~F29, F30~F39, F40~F48, F51, F90~F98	
치매	손보 ◯ / 생보 ×	F00~F03 보장		
항문질환	×	급여만 보장		
한방	입원 ◯ / 통원 ×	급여만 보장		
치과	상해: 급여만 보장 질병: ×	급여만 보장		
불임 관련 질환	×			습관성 유산·여성불임·인공수정 관련 합병증: 보험가입일로부터 2년 후부터 급여만 보장
선천성 뇌질환	×			임신 중 보험가입 시 출생 자녀의 선천성 뇌질환 급여만 보장
피부질환	×			심한 농양 발생 등으로 치료 필요성이 인정되는 부분 급여만 보장

실손 제도 변화의 주요 연표

시기	주요 변화
2003년	실손보험 중복보상 폐지(여러 개 가입해도 실제 손해액만 비례보상) / 총진료비가 아닌 본인부담금에 한해 보장
2009년 10월	상품 구조 표준화 / 입원 100% 보장 폐지 → 90% 보장 / 통원 자기부담금 발생(1~2만 원)

시기	주요 변화
2013년 4월	15년 만기 재가입 및 1년 갱신으로 변경 / 비급여 자기부담금 10% 또는 20% 선택(2015년부터 20%로 일원화)
2017년 4월	기본 + 비급여 3대 특약 분리(도수치료, MRI, 비급여주사 등 특약으로 보장) / 무사고 할인 적용(2년)
2021년 7월	급여/비급여 구분 / 자기부담비율 및 통원 공제 금액 변경 / 재가입 주기 15년 → 5년으로 변경
2024년 7월	4세대 실손 비급여 보험료 차등제 시행(CHAPTER 35)
5세대	**비중증 비급여 보장 축소, 보험료 대폭 인하(CHAPTER 36)**

■ 내 실손이 몇 세대인지 확인하는 법

1. 증권의 **가입일(계약일)**을 확인하고 위 표의 판매 시기와 대조합니다.
2. 증권 담보명에 '비급여 도수치료·체외충격파·증식치료', 'MRI', '비급여 주사료' 특약이 따로 있으면 **3세대 이후**입니다.
3. 담보가 '급여'와 '비급여'로 나뉘어 있으면 **4세대**입니다.
4. 재가입 주기가 증권에 없고 80세·100세 만기만 적혀 있으면 **1세대 또는 2세대 초기**일 가능성이 높습니다.

CHAPTER 32 핵심 요약

- 세대가 내려갈수록 **자기부담 ↑, 보험료 ↓, 재가입 주기 ↓**
- 1세대: 자기부담 거의 없음, 만기까지 조건 유지, 보험료 높음
- 3세대: 3대 비급여 특약 분리 / 4세대: 급여·비급여 분리, 비급여 할증

CHAPTER 33

실손에서 보상하지 않는 사항

실손은 '병원비면 다 된다'는 보험이 아닙니다. 약관이 열거한 보상하지 않는 손해를 알아야 청구 거절에 당황하지 않습니다.

다음은 2021년 7월 이후 개정된 약관(4세대)을 기준으로 정리한 보상하지 않는 사항입니다. 세부 내용은 가입 시점별 약관을 참조하세요.

질병코드로 정한 보상 제외 항목

No	구분	세부 내용 및 예외
1	**정신 및 행동장애**(F04~F99)	단, **치매(F00~F03)는 보상**. F04~F09 뇌손상·뇌기능 이상에 의한 인격 및 행동장애, F20~F29 정신분열증(조현병)·분열형 및 망상성 장애, F30~F39 기분(정동) 장애, F40~F48 신경증적·스트레스와 연관된 신체형 장애, F90~F98 소아기·청소년기 행동 및 정서 장애는 **급여에 해당하는 의료비 보상**(2016년 1월 이후). 그 외 F10~F19(정신활성물질 사용), F50~F59, F60~F69(성인 인격), F70~F79(정신 발육지연), F80~F89(정신 발달장애), F99는 보상하지 않음
2	**여성생식기의 비염증성 장애**(N96~N98)	N96 습관성 유산자, N97 여성 불임증, N98 인공수정과 관련된 합병증 — 단, 의료비 중 전액본인부담금 및 보험 가입일로부터 2년 이내에 발생한 의료비 제외(2021년 7월 이후 급여 보상)
3	**임신, 출산 및 산후기**(O00~O99)	제왕절개 포함
4	**선천성 뇌질환**(Q00~Q04)	Q00 뇌없음증(무뇌증) 및 유사기형, Q01 뇌류, Q02 소두증, Q03 선천 수두증, Q04 뇌의 기타 선천기형 — 단, **태아 가입에 한정해 급여 본인부담금 보상**(2021년 7월 이후)
5	**비만**(E66)	—
6	**요실금**(N39.3, N39.4, R32)	—
7	**직장 또는 항문 질환 중 급여에 해당하지 않는 부분**(K60~K62, K64)	K60 항문 및 직장부의 열구 및 샛길(누공), K61 항문 및 직장부의 고름집(농양), K62 항문 및 직장의 기타 질환, K64 치핵 및 항문주위 정맥혈전증 — 급여는 보상

그 밖에 보상하지 않는 사항

- **수익자 고의 / 계약자 고의 / 피보험자의 고의**로 인한 손해
- **치과치료 및 한방치료 비급여**에 해당하는 부분

- **치료 목적이 아닌** 건강검진, 예방접종, 인공유산, 영양제, 보신용 — 단, 치료 목적으로 인정되면 보상
- 단순 피로 또는 권태
- 주근깨, 다모, 무모, 백모증, 딸기코, 점(모반), 사마귀, 여드름, 노화현상으로 인한 탈모 등 피부질환
- 발기부전, 불감증, 단순 코골음, 단순포경
- 검열반 등 안과질환
- 의치, 의수족, 의안, 안경 등 보조기 구입비용 — 단, 인공장기나 부분 의치 등 신체에 이식되어 기능을 대신할 경우는 제외(보상)
- **외모개선 목적**의 치료

자주 거절되는 청구 사례와 대응

사례	거절 사유	대응 방법
백내장 다초점렌즈 수술	입원 필요성 부족, 비급여 렌즈의 치료 목적 다툼	입원의 의학적 필요성 기록, 대법원 판례 동향 확인
도수치료 장기 반복	4세대: 10회 이후 증상 개선 확인 서류 필요	10회마다 객관적 개선 소견 (통증척도·관절가동범위) 확보
영양주사·비타민 주사	치료 목적이 아닌 영양제·보신용	약관상 '치료 목적' 요건(효능·효과 및 적응증) 해당 여부 확인
ADHD 비급여 약	정신질환은 급여만 보상	급여 처방 여부 확인
건강검진 중 용종 제거	검진비는 미보상	용종 제거(치료)에 해당하는 비용은 보상 대상 — 분리 청구
쌍꺼풀(안검하수) 수술	외모개선 목적 의심	시야 장애 등 기능 개선 목적의 진단·검사 기록

청구 거절 시 순서

1. 거절 사유를 서면(문자·우편)으로 받습니다.
2. 약관의 해당 조항과 주치의 소견서를 비교합니다.
3. 보험사 고객센터에 재심사(이의)를 신청합니다.
4. 해결되지 않으면 금융감독원 민원·분쟁조정을 신청합니다.

Q. 약값만 청구해도 되나요?

A. 처방조제비도 실손 통원 보상 대상입니다(유병자 실손 제외). 약국 영수증과 함께 처방전(질병코드 기재)을 제출하며, 외래 진료비와 합산해 한도와 공제금액이 적용되는 세대가 있으므로 같은 날 진료비와 함께 청구하는 것이 유리합니다.

CHAPTER 33 핵심 요약

- 정신질환은 급여만(일부 코드), 치매는 보상
- 임신·출산, 비만, 요실금, 항문질환 비급여, 치과·한방 비급여 미보상
- 치료 목적이 아닌 검진·영양제·외모개선은 미보상, 치료 목적이면 보상

CHAPTER 34

4세대 실손의 주요 특징 — 일반·유병자·노후

4세대 실손은 하나가 아닙니다. 일반 실손, 유병자 실손, 노후 실손은 구조와 자기부담이 다릅니다.

4세대 실손의료보험(일반)

구분	내용		
상품 구조	【기본계약】 상해급여 · 질병급여 【선택계약】 상해비급여 · 질병비급여 · **3대 비급여**		
보험료 할인/할증	급여: 미적용 / **비급여: 직전 1년 보험금 지급액 기준**		
보장 상해/질병 (입원+통원+조제)	상해 급여/비급여 각 5,000만 원	상해 급여 20만 원(외래+처방)	상해 비급여 20만 원(외래+처방) 비급여 연간 100회 한도
	질병 급여/비급여 각 5,000만 원	질병 급여 20만 원(외래+처방)	질병 비급여 20만 원(외래+처방) 비급여 연간 100회 한도
3대 비급여	주사료 250만 원(연 50회) · 연간 MRI/MRA 300만 원 · 도수/증식/체외충격파 350만 원(연 50회)		
입원 보장비율	급여 80% / 비급여 70%		
입원 본인부담	급여 20%(연간 200만 원 한도) · 비급여 30%(계속 공제)		
통원 본인부담	급여: 의원/병원 1만 원, 종합/상급 2만 원 vs 보상의료비의 20% 중 큰 금액 비급여: 3만 원 vs 보상의료비의 30% 중 큰 금액		
갱신/재가입 주기	1년 / 5년		

4세대 유병자 실손의료보험

구분	내용	
상품 구조	【기본계약】 상해입원 · 질병입원 · 상해통원 · 질병통원	
할인/할증	없음	
보장	상해 입원 5,000만 원	상해 통원(외래) 회당 20만 원
	질병 입원 5,000만 원	질병 통원(외래) 회당 20만 원 급여+비급여 180회

구분	내용
3대 비급여	3대 비급여 특약(주사제, MRI/MRA, 도수·증식·체외충격파) 보장 안 됨 / 처방조제는 보장 안 됨
입원 보장비율	70%
입원 본인부담	10만 원(연간 200만 원 한도)
통원 본인부담	2만 원 vs 보상의료비의 30% 중 큰 금액
갱신/재가입 주기	1년 / 3년

4세대 노후 실손의료보험

구분	내용	
상품 구조	【기본계약】 상해의료비 · 질병의료비 【선택계약】 상급병실료차액보장 · 요양병원의료비	
할인/할증	없음	
보장	상해 입원/통원(처방) 1억 원	상해 통원(외래) 회당 100만 원
	질병 입원/통원(처방) 1억 원	질병 통원(외래) 회당 100만 원 급여+비급여 180회
3대 비급여	보상 가능. 본인부담금은 아래 입원/통원과 동일 적용	
입원 보장비율	급여 80% / 비급여 70%	
입원 본인부담	우선공제 30만 원 + 급여 20% / 비급여 30%(연간 500만 원 한도)	
통원 본인부담	우선공제 3만 원 + 급여 20% / 비급여 30%	
갱신/재가입 주기	1년 / 3년	

노후 실손은 50~75세(상품별 상이)에 가입할 수 있는 고령자 전용 실손으로, 보장 한도가 크고 보험료가 일반 실손보다 낮은 대신 **우선공제(입원 30만 원, 통원 3만 원)**가 있어 소액 치료비는 보상받기 어렵습니다. 고액 의료비 대비에 초점을 맞춘 상품입니다.

세 상품 비교 요약

구분	일반 4세대	유병자 4세대	노후 4세대
가입 대상	표준체 심사 통과자	간편심사(3개월·2년·5년)	50~75세 고령자(상품별)
비급여 할증	있음(차등제)	없음	없음

구분	일반 4세대	유병자 4세대	노후 4세대
3대 비급여	특약으로 보장	보장 안 됨	보장(우선공제 후)
처방조제	보장	보장 안 됨	보장
입원 자기부담	급여 20%·비급여 30%	보장비율 70%, 10만 원 공제	30만 원 + 20%/30%
재가입 주기	5년	3년	3년

CHAPTER 34 핵심 요약

- 일반 4세대: 급여·비급여 분리, 비급여 30%·할증, 3대 비급여 특약
- 유병자: 처방조제·3대 비급여 미보장, 보장비율 70%
- 노후: 한도 1억·회당 100만, 우선공제 30만/3만 원

CHAPTER 35

보험료 차등제와 구실손 vs 4세대 유불리

4세대 실손은 비급여를 많이 쓰면 다음 해 보험료가 최대 4배가 됩니다. 구실손을 지킬지, 4세대로 갈아탈지 판단하는 기준을 정리합니다.

실손보험 보험료 차등제

- 보험료 갱신 전 **12개월간 지급된 비급여 보험금**을 기준으로 다음 해 비급여 보험료가 결정되는 방식
- **2024년 7월부터** 보험료 차등제 시행(4세대 실손 대상)
- 급여 보험료는 차등 없음 — 필수 의료 이용에는 불이익 없음

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
상태	할인	유지	할증	할증	할증
할인/할증률	약 5% 할인 (할증 재원 범위 내)	—	+100%	+200%	**+300%**
직전 1년 비급여 지급 보험금	없음	100만 원 미만	100만 원 이상	150만 원 이상	**300만 원 이상**

※ 1등급 할인율은 할증으로 확보된 재원 범위 내에서 결정됩니다. 할증은 비급여 특약 보험료에만 적용됩니다.

■ 차등제 적용 예외 대상

꾸준히 장기 치료를 받아야 하는 의료 취약계층은 비급여 보험금 산정에서 제외됩니다.

산정특례 대상자

암질환·심장질환·희귀난치성질환자 등
국민건강보험법상 산정특례 대상자의 해당 질환 의료비

장기요양 1~2등급

치매·뇌혈관성 질환 등으로 장기요양 1~2등급 판정을 받은 사람

※ 노후 실손·유병력자 실손은 별도 상품으로 차등제가 적용되지 않습니다.

구실손 vs 4세대 실손 — 유불리 비교

구실손(1~3세대) 유지

- 자기부담률이 없거나 낮아 **부담 적음**
- 높은 인상률로 갱신 시 **고연령대 유지 어려움**
- 해지 후 재가입 불가(같은 조건의 상품은 판매 종료)
- 가입 불가 사유 발생 시 **실손 보장 공백** 발생

→ **실손 부재에 대한 대안 필요**

4세대 실손 전환

- 낮은 인상률과 보험료로 **장기적 유지 가능**
- 비급여 입원 30% / 비급여 통원 30% 혹은 3만 원 중 큰 금액 공제
- 개인별 최대 300% 할증
- 만기 재가입으로 보장사항 변동(5년 주기)

→ **높은 자기부담금에 대한 대안 필요**

■ 계약 전환 제도

기존 1~3세대 실손 가입자는 같은 보험사의 4세대(또는 이후 세대) 실손으로 **별도의 건강 심사 없이 전환**할 수 있습니다. 또한 전환 후 일정 기간(6개월) 안에 보험금을 받은 이력이 없다면 기존 계약으로 되돌릴 수 있는 **철회 제도**가 운영되었습니다. 전환 시점의 조건은 보험사에 확인하세요.

누구에게 무엇이 유리할까

유형	추천 방향
병원을 거의 가지 않고, 보험료 부담이 큼	**4세대(또는 5세대) 전환** 검토 — 보험료 절감 효과가 큼
만성질환·정기적인 비급여 치료(도수·주사 등)를 받음	**구실손 유지** — 4세대에서는 할증·자기부담이 커짐
고령(60대 이상), 갱신 보험료가 크게 오름	향후 보험료 추정과 의료 이용량을 함께 비교(CHAPTER 37)
실손이 여러 개(단체+개인)	중복 정리 — 개인실손 중지제도 활용
산정특례 대상 질환 치료 중	전환 시 보장 축소 여부를 꼼꼼히 확인, 대체로 유지 쪽이 유리

Q. 회사 단체실손이 있는데 개인실손도 유지해야 하나요?

A. 퇴직 후에는 단체실손이 사라지므로 개인실손을 해지하면 나이·병력 때문에 재가입이 어려울 수 있습니다. 단체실손이 있는 동안 개인실손 보험료 납입과 보장을 중지했다가, 퇴직 후 다시 살리는 '개인실손 중지·재개 제도'를 활용하세요.

사례 — 할증을 피하는 비급여 이용 관리

4세대 실손 가입자 S씨는 어깨 통증으로 도수치료를 받으면서 1년간 비급여 보험금이 160만 원이 되어 다음 해 비급여 보험료가 200% 할증(4등급)되었습니다. 할증은 1년 단위로 다시 산정되므로, 다음 해 비급여 이용을 줄이면 등급이 내려갑니다. 비급여 치료가 필요할 때는 **급여 치료로 대체 가능한지** 먼저 확인하고, 할증 구간(100만·150만·300만 원)을 염두에 두면 보험료 부담을 관리할 수 있습니다.

CHAPTER 35 핵심 요약

- 4세대 차등제(2024.7~): 직전 1년 비급여 보험금 기준 최대 +300%
- 산정특례 대상자·장기요양 1~2등급은 차등 예외
- 구실손 = 부담 적지만 보험료 급등 / 4세대 = 저렴하지만 자기부담·할증

CHAPTER 36

5세대 실손보험, 무엇이 달라지나

"두 마리 토끼는 못 잡는다." 5세대 실손은 보험료를 크게 낮추는 대신, 병원비를 돌려받는 조건을 까다롭게 만들었습니다.

5세대 실손의 세 가지 핵심 변화

01 보험료 인하

- 4세대 실손 대비 약 **30% 인하**
- 주계약 및 특약 1·2를 모두 가입할 경우 기준
- 회사별·상품별로 차이가 큼

→ 보험료가 줄어들어 가입 부담이 낮아져요!

02 입원 의료비

- 비중증 비급여 본인부담금 **50%로 인상**
- 연간 한도 **1천만 원**으로 축소
- 비중증 입원 **1회당 한도 300만 원**

→ 입원할 때 부담이 더 커질 수 있어요!

03 통원 의료비

- 비중증 비급여 본인부담률 **50%로 인상**
- 최소 **5만 원** 이상 공제
- 1회 한도가 아닌 **1일당 20만 원**으로

→ 통원 치료비 부담이 커질 수 있어요!

쉽게 말해

보험료는 줄었지만, 병원비를 돌려받는 조건이 더 까다로워졌어요. 가입 전에 꼭! 꼼꼼히 확인하세요.

'중증'과 '비중증' 비급여의 구분

5세대 실손의 가장 큰 특징은 비급여를 **중증**과 **비중증**으로 나누어 다르게 보장한다는 점입니다.

구분	대상(개념)	보장 방향
중증 비급여	암·뇌혈관·심장질환·희귀난치질환 등 산정특례 대상 중증질환 치료에 필요한 비급여(예: 표적항암제 등)	현행(4세대) 수준의 보장 유지, 고액 입원 시 자기부담 상한 장치
비중증 비급여	도수치료, 체외충격파, 비급여 주사(영양주사 등) 등 남용 우려가 큰 비급여, 그 밖의 일반 비급여	자기부담 50%, 입원 연간 1천만 원·1회 300만 원, 통원 1일 20만 원, 최소 5만 원 공제

※ 금융당국의 실손보험 개혁 방향과 공개 자료를 바탕으로 정리했습니다. 출시 시기, 구체적인 중증 범위, 급여 자기부담률 등 세부 조건은 상품 약관과 보험사 안내를 반드시 확인하세요.

함께 추진되는 비급여 관리 정책도 영향을 줍니다. 도수치료 등 과잉 이용 우려가 큰 일부 비급여는 건강보험의 '관리급여'로 편입해 가격과 이용 기준을 관리하는 방향이 논의되고 있습니다. 관리급여 항목은 본인부담률이 매우 높게 설정될 수 있어, 실손 보상 여부와 함께 확인이 필요합니다.

40세 남성 기준 보험료 비교

5세대 실손 전환 컨설팅 자료에서 제시한 40세 남성 예시를 보면 보험료 차이는 다음과 같습니다(회사·상품별 상이).

01 1세대 실손보험

- 회사별, 상품별 상이
- 월 약 5만 4,300원

02 5세대 실손보험

- 월 보험료 약 17,000원
- 1세대 대비 약 30% 수준

03 20년 총 납입 보험료

- 1세대 **2,945만 원**(매년 8.1% 인상 가정)
- 5세대 **675만 원**(매년 5.0% 인상 가정)
- 총 차액 **2,270만 원**

원 자료의 계산 오류 바로잡기

일부 전환 컨설팅 자료에는 위 차액이 '2,720만 원'으로 표기되어 있으나, 2,945만 원 − 675만 원 = **2,270만 원**이 맞습니다. 이 책의 이후 계산(CHAPTER 37)은 바로잡은 2,270만 원을 기준으로 다시 했습니다. 실제 상담에서도 숫자를 직접 다시 계산해 보는 습관이 중요합니다.

결론부터 말하면, 5세대 실손보험은 보험료가 훨씬 저렴합니다. 이 가정대로라면 20년 동안 총 납입 보험료 차이가 약 2,270만 원에 이릅니다. 그러나 '보험료가 싸다'만으로 전환을 결정하면 안 됩니다. 그 차액이 앞으로 내가 쓸 의료비 대비 충분한지 따져야 합니다.

실제 의료비 지출과 실손보험 효용

01 건강보험 지출 구조

- 실제 **상위 10%가 60%** 정도를 씀
- 노인 19%가 45%를 사용
- 나이가 증가할수록 비중 높아짐

02 40~60세 지출 구조

- **상위 10%가 70~80%**를 쓰는 구조

03 생애 의료비 지출 규모

- 전체 기준(40~60세 구간) 약 **7,500만 원**
- 일반 평균 약 **1,700~2,500만 원** 지출

나이가 들수록 의료비 지출 비중이 높아지지만, 그 지출은 소수에게 몰려 있습니다. 40~60세 구간에서는 상위 10%가 의료비의 70~80%를 쓰기 때문에, '평균'의 함정에 빠지면 안 됩니다. 대부분의 사람은 평균보다 훨씬 적게 쓰고, 소수는 훨씬 많이 씁니다. 실손 전환 판단의 핵심은 **"나는 어느 쪽에 속할 가능성이 큰가"**입니다.

※ 생애 의료비·지출 구조 수치는 전환 컨설팅 자료가 인용한 가정이며, 개인별 편차가 매우 큽니다.

Q. 5세대 실손은 신규 가입만 되나요, 전환도 되나요?

A. 신규 가입과 기존 실손(1~4세대)에서의 전환이 모두 가능한 것이 일반적입니다. 전환 시 심사 여부, 철회 가능 기간 등 조건은 보험사에 확인하세요.

Q. 중증질환이면 5세대도 괜찮지 않나요?

A. 중증 비급여는 4세대 수준 보장을 유지하는 방향이므로 큰 병에 대한 대비는 상당 부분 유지됩니다. 그러나 '중증'의 범위 밖에 있는 비급여(도수치료, 비급여 주사, 일반 질환의 비급여 검사 등)는 자기부담이 50%로 커집니다.

CHAPTER 36 핵심 요약

- 보험료 약 30% 인하 vs 비중증 비급여 자기부담 50%
- 비중증 입원: 연간 1천만·1회 300만 / 통원: 1일 20만, 최소 5만 원 공제
- 40세 남성 20년 예시: 1세대 2,945만 vs 5세대 675만 → 차액 2,270만 원
- 의료비는 소수가 대부분을 씀 → 내 예상 의료 이용량이 판단 기준

CHAPTER 37

5세대 전환 손익 계산 — BEP로 판단하기

BEP(손익분기점)란 '1세대를 유지해 더 내는 보험료'와 '1세대가 더 돌려주는 의료비'가 같아지는 의료비 지출 수준입니다. 이 숫자를 넘게 쓸 사람이면 1세대 유지, 아니면 전환이 유리합니다.

BEP 계산의 원리

BEP 의료비 = 1세대를 유지해 더 내는 보험료 ÷ 5세대 전환 시 추가되는 자기부담률

1세대 실손은 자기부담이 거의 없고, 5세대는 비급여 등에서 30~50%의 자기부담이 생긴다고 단순화하면, 5세대로 전환한 사람은 의료비 X원을 쓸 때마다 X × 자기부담률만큼 손해를 봅니다. 반대로 1세대를 유지한 사람은 매년 더 비싼 보험료를 냅니다. 둘이 같아지는 X가 BEP입니다.

시나리오 ① 기본 시나리오(할증 없음)

40세 남성, 20년(40~59세) 납입 기준. 1세대를 유지하면 5세대보다 **2,270만 원**을 더 냅니다.

5세대 추가 자기부담률 가정	BEP 의료비(20년 합계)	해석
50%(비중증 비급여 중심)	**4,540만 원**	20년간 실손 대상 의료비를 4,540만 원 이상 쓰면 1세대 유지가 유리
40%(혼합)	**5,675만 원**	5,675만 원 이상 쓰면 1세대 유지가 유리
30%(중증 비급여 중심)	**약 7,567만 원**	7,567만 원 이상 쓰면 1세대 유지가 유리

※ 계산: 2,270만 ÷ 0.5 / 0.4 / 0.3. 원 자료(차액 2,720만 원 기준)의 5,440·6,800·9,066만 원을 바로잡은 값입니다.

■ 예상 의료비와 비교하면

앞에서 본 '일반 평균 약 1,700~2,500만 원'의 중간값 **2,100만 원**을 20년 의료비로 가정해 보겠습니다.

자기부담률	5세대 추가 본인부담 (2,100만 × 비율)	1세대 추가 보험료	1세대 유지 시 손익
30%	630만 원	2,270만 원	**−1,640만 원**
40%	840만 원	2,270만 원	**−1,430만 원**

자기부담률	5세대 추가 본인부담 (2,100만 × 비율)	1세대 추가 보험료	1세대 유지 시 손익
50%	1,050만 원	2,270만 원	**−1,220만 원**

즉, **평균적인 의료 이용자라면 1세대를 유지할 경우 20년간 약 1,200~1,600만 원을 더 손해**보는 셈입니다. 1세대를 유지해 이득을 보려면 실손 대상 의료비가 BEP(4,540만~7,567만 원)를 넘어야 하는데, 이는 의료비를 가장 많이 쓰는 상위 그룹에 해당하는 수준입니다.

시나리오 ② 5세대에서 매년 최대 할증을 받는 경우

5세대도 비급여 이용이 많으면 할증을 받을 수 있습니다. 극단적으로 **특약 부분(보험료의 70% 가정)에 대해 4배 할증(+300%)이 매년 적용**되고 보험료가 매년 5% 오른다고 가정해 보겠습니다.

01 할증분 70% 기준

- 특약 부분에 대해 4배 할증 (70% 가정)
- 비할증 5% 인상 시 총 675만 원
- 4배 할증 + 5% 인상 시 총 **2,091만 원**

02 1세대 실손과 비교

- 1세대 실손 총 2,945만 원
- 5세대 실손 총 2,091만 원
- 차액 **854만 원**

03 BEP

- 1,708만 원(50%)
- 2,135만 원(40%)
- 2,847만 원(30%)
- 예상 의료비 1,700~2,500만 원

최악의 할증 시나리오에서도 5세대는 1세대보다 854만 원 저렴합니다. 이 경우 BEP는 1,708만~2,847만 원으로 내려가 예상 의료비(1,700~2,500만 원)와 겹치기 시작합니다. 다시 말해 **매년 최대 할증을 받을 만큼 비급여를 많이 쓰는 사람이라면 1세대 유지와 5세대 전환의 손익이 비슷해지고**, 그보다 의료비를 더 쓰면 1세대 유지가 유리해집니다. 반대로 예상 의료비가 1,700~2,500만 원 사이라면 대체로 5세대가 유리할 수 있습니다.

BEP 계산 워크시트 — 내 숫자로 해 보기

항목	내 숫자
A. 현재 실손 월 보험료 × 12 × 예상 유지 기간(연), 연 인상률 반영	
B. 5세대 실손 예상 월 보험료 × 12 × 같은 기간, 연 인상률 반영	
C. 보험료 차액 = A − B	
D. 5세대 전환 시 추가 자기부담률(비중증 위주 50%, 혼합 40%, 중증 위주 30%)	
E. BEP 의료비 = C ÷ D	

항목	내 숫자
F. 최근 3~5년 실손 청구액 연평균 × 같은 기간(나이 증가분 가산)	
판단: F > E 이면 현재 실손 유지, F < E 이면 전환 검토	

F(예상 의료비)를 추정하는 팁

- 보험사 앱에서 최근 몇 년간 **실손 보험금 청구 내역**을 확인합니다.
- 국민건강보험공단 '건강in' 또는 앱에서 **진료 내역**을 조회해 비급여 이용 빈도를 확인합니다.
- 만성질환, 근골격계 질환(도수치료 이용), 가족력이 있다면 보수적으로 크게 잡습니다.
- 나이가 들수록 의료비가 늘어나므로, 40대의 청구액을 그대로 60대에 적용하면 과소평가가 됩니다.

CHAPTER 37 핵심 요약

- BEP = 보험료 차액 ÷ 추가 자기부담률
- 기본 시나리오 BEP 4,540만~7,567만 원 → 평균 이용자는 5세대 유리
- 최대 할증 시나리오 BEP 1,708만~2,847만 원 → 고이용자는 손익 비슷 또는 1세대 유리
- 숫자는 반드시 내 보험료·내 청구 이력으로 다시 계산

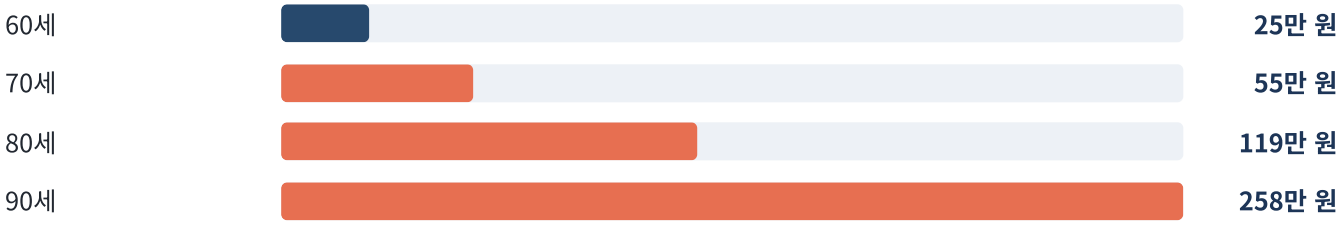
CHAPTER 38

5세대 전환 평가 주요 포인트

계산이 끝났다면 마지막으로 세 가지를 점검합니다. 보험료를 끝까지 낼 수 있는가, 통원 치료 한도는 충분한가, 1세대 보험료는 앞으로 얼마나 오를까.

포인트 ① 보험료 납입 여력

"은퇴 후에도 이 보험료를 낼 수 있는가?" 1세대 실손은 갱신될 때마다 그동안의 손해율이 반영되어 보험료가 크게 오릅니다. 전환 컨설팅 자료가 제시한 1세대 실손의 고령기 월 보험료 추정 예시는 다음과 같습니다.



※ 전환 컨설팅 자료의 추정치(78세 전후 인상률 정점 가정)이며, 실제 보험료는 회사·상품·손해율에 따라 크게 다릅니다.

이 추정이 절반만 맞더라도, 소득이 없는 70~80대에 월 수십만 원의 실손 보험료를 감당하기는 쉽지 않습니다. 결국 가장 의료비가 많이 드는 시기에 보험료를 못 내 해지하게 된다면, 그동안 낸 비싼 보험료의 의미가 사라집니다. **"언제까지 유지할 수 있는가"**를 먼저 따져 보세요.

포인트 ② 비급여 통원 치료의 한도와 횟수

한도

비중증 비급여 통원은 **1일 20만 원**이 한도이고, 비중증 비급여 연간 한도는 **1천만 원**으로 제한됩니다.

횟수

비급여 통원은 **연간 100회** 수준으로 제한됩니다.

정기적으로 도수치료, 체외충격파, 비급여 주사 치료를 받는 사람이라면 한도와 횟수 제한, 그리고 50% 자기부담이 모두 체감됩니다. 이런 치료를 자주 받는 사람에게 5세대 전환은 불리할 가능성이 큽니다.

포인트 ③ 1세대 인상률의 미래

- **통상 의료 이용량이 낮은 가입자가 먼저 전환**합니다. 보험료가 싸지는 5세대로 건강한 사람들이 빠져나가면,
- 1세대 실손에는 의료 이용량이 많은 가입자가 상대적으로 많이 남게 되고, **1세대 실손의 손해율 부담이 가중**됩니다.

- 그 결과 1세대 실손의 갱신 인상률이 앞으로 더 높아질 가능성이 있습니다(이른바 역선택의 악순환).

따라서 1세대를 유지하기로 했다면, 앞으로의 인상률을 과거보다 보수적으로(더 높게) 잡고 계산해야 합니다.

핵심 포인트!

1. **보험료 납입** 가능 여부를 꼼꼼히 확인하세요!
2. 비급여 통원 치료는 **한도와 횟수 제한**을 꼭 기억하세요!
3. 1세대는 **인상 부담**이 커질 수 있으니 신중한 선택이 필요합니다!

전환 의사결정 흐름도

Q1 현재 중증질환 치료 중이거나 정기적 비급여 치료를 받는가?	**예 →** 현재 실손 유지 우선 검토
Q2 (아니오) 현재 실손 보험료가 소득 대비 부담되는가? 은퇴 후 유지 가능한가?	**부담·유지 불가 →** 전환 적극 검토
Q3 내 예상 의료비(F)가 BEP(E)보다 큰가?	**F > E →** 유지 / **F < E →** 전환
Q4 (전환 시) 자기부담 증가분을 정액 담보로 보완할 수 있는가?	**보완** 질병수술비·입원일당·암/뇌/심 치료비

전환 후 보완 전략

5세대로 전환해 아낀 보험료의 일부를 **정액형 담보**에 쓰면 높아진 자기부담을 상당 부분 메울 수 있습니다.

5세대에서 커지는 부담	보완할 정액 담보
비중증 입원 자기부담 50%, 1회 300만 원 한도	질병·상해 입원일당, 질병수술비, 1~5종 수술비
비중증 통원 자기부담(최소 5만 원)	통원 일당(상품별), ADRG 수술비(시술)

5세대에서 커지는 부담	보완할 정액 담보
중증 질환의 고액 비급여	암 주요치료비, 표적·면역항암 치료비, 뇌·심장 수술비
장기 입원 간병비	간병인 지원·사용 일당

사례 — 같은 40대, 다른 결론

M씨(43세, 사무직): 최근 5년 실손 청구액이 연 20만 원 안팎. 1세대 보험료 월 6만 원이 부담. BEP 계산 결과 예상 의료비가 BEP의 3분의 1 수준 → **5세대 전환** 후 아낀 보험료로 질병수술비와 입원일당을 보강했습니다.

N씨(46세, 물류업): 허리 디스크로 매년 도수치료·주사 치료를 받아 연 청구액 300만 원 이상. 5세대로 바꾸면 비중증 비급여 자기부담 50%와 통원 1일 한도에 걸림 → **1세대 유지**, 대신 은퇴 전 보험료 부담을 대비해 별도 적립을 시작했습니다.

CHAPTER 38 핵심 요약

- 보험료 납입 여력: 1세대 고령기 보험료 급등 가능성
- 비급여 통원: 1일 20만 원·연 100회·자기부담 50%
- 건강한 가입자 이탈로 1세대 인상률 상승 가능성
- 전환 시 아낀 보험료로 정액 담보 보완

■ 실손 점검 체크리스트

- [ ] 내 실손의 세대와 가입일을 확인했다.
- [ ] 최근 3~5년 실손 청구 금액을 조회했다.
- [ ] 현재 보험료와 최근 갱신 인상률을 확인했다.
- [ ] BEP 워크시트로 유지·전환 손익을 계산했다.
- [ ] 단체실손과 개인실손 중복 여부를 확인했다.
- [ ] 전환 시 철회 가능 기간과 조건을 확인했다.

PART 11

몰라서 못 받는 정부 지원제도

병원비 걱정은 줄이고, 정부 지원제도로 든든하게. 민간보험보다 먼저 챙겨야 할 것이 공적 지원입니다. 신청하지 않으면 사라지는 돈, 기한이 지나면 받을 수 없는 지원을 정리하고, 마지막으로 보험금 청구 실전 요령까지 담았습니다.

39 본인부담상한제와 재난적 의료비 지원

40 산정특례·노인장기요양·임플란트와 틀니 지원

41 보험금 청구 실전 가이드

CHAPTER 39

본인부담상한제와 재난적 의료비 지원

한 해 병원비가 일정 금액을 넘으면 국가가 돌려줍니다. 그런데 신청하지 않으면 3년 뒤 사라집니다.

① 본인부담상한제

항목	내용
내용	1년 동안 지출한 의료비 중 개인의 소득 수준(건강보험료 기준 1~10분위)에 따른 **상한액을 초과한 금액을 국가에서 환급**해 주는 제도
적용 범위	병원, 의원, 약국 등 1년치 **급여** 의료비가 모두 합산 적용되며, **비급여 항목은 제외**
신청 방법	환급 대상자에게는 매년 8~9월경 안내문이 발송됩니다. 신청하지 않으면 **3년 후 소멸**하므로 건강보험 앱(The건강보험)이나 고객센터를 통해 확인·신청해야 합니다.

■ 어떻게 작동하나

- **사전급여**: 같은 요양병원 등 한 의료기관에서 낸 본인부담금이 최고 상한액을 넘으면, 넘는 금액은 병원이 공단에 직접 청구하므로 환자가 내지 않습니다.
- **사후환급**: 여러 병원을 다닌 경우 등은 다음 해 건강보험료 정산 후 상한액을 넘은 금액을 돌려받습니다(8~9월 안내).
- **상한액**: 소득분위가 낮을수록 상한액도 낮습니다. 하위 분위는 연 100만 원 안팎, 최고 분위는 연 800만 원대 수준이며 매년 조정·고시됩니다. 요양병원 장기 입원(120일 초과)은 별도 상한액이 적용됩니다.

실손보험과의 관계

본인부담상한제로 환급받을 금액은 실손보험이 보상하지 않는 것이 원칙입니다(실손 약관상 '국민건강보험법에 따라 환급받을 수 있는 금액' 제외). 큰 병으로 한 해 의료비가 많았다면, 실손 청구 후 나중에 보험사가 상한제 환급분을 다시 정산해 달라고 요청할 수도 있으니 미리 알아 두세요.

② 재난적 의료비 지원 사업

항목	내용
내용	갑작스러운 고액 의료비로 가계 부담이 큰 경우, **비급여 항목까지** 지원해 주는 제도(연간 최대 5,000만 원 한도)

항목	내용
지원 조건	기준 중위소득 50~100% 가구 중 연 소득의 10%를 초과하는 의료비가 발생했을 때 신청할 수 있으며, 기준을 약간 초과하더라도 개별 심사를 통해 지원 여부를 확인할 수 있습니다.
주의사항	퇴원일(최종 진료일) 다음 날부터 **180일 이내**에 신청해야 합니다.

- 기초생활수급자·차상위계층은 더 낮은 기준(본인부담 의료비가 일정 금액 초과)으로 지원받을 수 있습니다.
- 지원 대상 질환은 원칙적으로 모든 질환이며, 입원 및 외래(중증질환 등 요건 충족 시)가 대상입니다.
- 신청은 국민건강보험공단 지사 또는 병원 사회사업팀(의료사회복지사)을 통해 할 수 있습니다.
- 민간보험(실손 등)으로 받은 금액은 지원액 산정 시 차감됩니다.

사례 — 실손이 없던 O씨 가족

O씨(52세)는 실손보험 없이 희귀질환 치료로 1년간 급여 본인부담 900만 원, 비급여 1,500만 원을 썼습니다. 가구 소득은 기준 중위소득의 80% 수준. 먼저 본인부담상한제로 급여 본인부담 중 상한액 초과분을 다음 해 환급받았고, 병원 의료사회복지사의 안내로 퇴원 후 180일 안에 재난적 의료비를 신청해 비급여를 포함한 의료비 일부를 지원받았습니다. 두 제도를 몰랐다면 수백만 원을 그대로 부담했을 것입니다.

Q. 본인부담상한제 환급금이 있는지 어떻게 확인하나요?

A. 국민건강보험공단 홈페이지나 'The건강보험' 앱의 '환급금 조회'에서 본인 인증 후 확인할 수 있습니다. 상한제 외에도 과오납 보험료 등 다른 환급금이 함께 조회됩니다.

CHAPTER 39 핵심 요약

- 본인부담상한제: 급여 의료비 소득분위별 상한 초과분 환급, 3년 지나면 소멸
- 재난적 의료비: 비급여 포함 연 최대 5,000만 원, 퇴원 후 180일 이내 신청

CHAPTER 40

산정특례·노인장기요양·임플란트와 틀니 지원

앞 장들에서 다룬 제도를 '정부 지원' 관점에서 다시 한 번 모았습니다. 신청 시기와 방법만 정확히 알아도 수백만 원이 달라집니다.

③ 산정특례 제도

항목	내용
내용	암, 뇌혈관·심장 질환, 중증 난치 질환 등 중증 질환으로 치료받을 때 본인부담률을 5% 수준으로 크게 낮춰 주는 제도
적용 방식	암 환자는 등록 후 5년간 혜택이 적용되며, 5년 후 잔존·재발 시 재등록이 가능합니다. 뇌·심장 질환은 별도 서류 등록 없이 병원 수납 시 자동 적용(최대 30일)됩니다.
특징	개인 민간보험(암보험 등) 수령액과 상관없이 중복 혜택이 가능합니다.

→ 자세한 내용은 CHAPTER 12 참고

④ 노인장기요양보험

항목	내용
내용	고령이나 노인성 질환으로 혼자 일상생활을 하기 어려운 어르신에게 돌봄 서비스를 제공하는 제도 (만 65세 이상 또는 만 65세 미만 노인성 질환자 대상)
혜택 내용	**재가급여**: 요양보호사의 방문 요양, 주야간보호센터 이용 시 비용의 85% 지원(본인 부담 15%) **시설급여**: 요양원 등 전문 시설 입소 시 비용의 80% 지원(본인 부담 20%) **복지용구 지원**: 휠체어, 전동침대 등 필요 용품 구입·대여비를 연간 160만 원 한도 내에서 85% 이상 할인 지원

→ 자세한 내용은 CHAPTER 17~19 참고

⑤ 임플란트 및 틀니 지원

항목	내용
내용	만 65세 이상 국민을 대상으로 치과 치료비 부담을 줄여 주는 제도
임플란트	자연 치아가 1개 이상 남아 있는 경우(부분 무치악), 평생 2개까지 본인부담금 30% 수준(개당 약 30~40만 원 선)으로 시술 가능

항목	내용
틀니	치아가 전혀 없는 경우(완전틀니) 또는 일부 없는 경우(부분틀니), 7년에 1회씩 본인부담금 30% 적용
주의사항	시술 진행 전에 반드시 치과를 통해 **건강보험 대상자로 사전 등록**을 마쳐야 혜택을 받을 수 있습니다.

- 의료급여 수급자, 차상위 본인부담 경감 대상자는 본인부담률이 더 낮습니다(5~15% 수준).
- 임플란트는 '위아래 구분 없이 평생 2개'이므로 어느 치아에 쓸지 치과와 충분히 상의하세요.
- 틀니는 제작 후 일정 기간 무상 유지관리(조정)를 받을 수 있습니다.

⑥ 함께 알아 두면 좋은 지원

제도	내용
국가 암검진	위암·대장암·간암·유방암·자궁경부암·폐암 등 연령·주기별 무료 또는 저부담 검진
긴급복지 의료지원	갑작스러운 위기 상황으로 의료비 부담이 어려운 저소득 가구에 의료비 지원(시·군·구청)
치매 치료관리비 지원	치매안심센터 등록 치매 환자 중 소득 기준 충족 시 치매 약제비·진료비 일부 지원
간호·간병 통합서비스	간호 인력이 간병까지 제공하는 병동, 간병비 부담 경감(건강보험 적용)
장애인 보조기기 급여	등록 장애인의 보조기기(휠체어·보청기 등) 구입비 일부 건강보험 지원

정부 지원제도 한 장 요약

제도	대상 비용	신청	기한·주의
본인부담상한제	급여	안내문·앱	3년 후 소멸
재난적 의료비	급여+비급여	공단·병원 사회사업팀	퇴원 후 180일
산정특례	급여	병원(암 등) / 자동(뇌·심)	진단 30일 이내
노인장기요양	돌봄·복지용구	공단	등급 유효기간 갱신
임플란트·틀니	치과 보철	치과 사전 등록	65세 이상

CHAPTER 40 핵심 요약

- 산정특례는 민간보험과 중복 혜택
- 장기요양: 재가 85%·시설 80% 지원, 복지용구 연 160만 원 한도
- 65세 이상 임플란트 평생 2개·틀니 7년 1회 본인부담 30%, 사전 등록 필수

CHAPTER 41

보험금 청구 실전 가이드

보험은 청구해야 받습니다. 서류, 기한, 순서를 알면 받을 수 있는 보험금을 놓치지 않습니다.

보험금 청구의 기본 원칙

- **소멸시효 3년**: 보험금 청구권은 보험사고가 발생한 날부터 3년이 지나면 소멸합니다. 3년 이내라면 지난 진료비도 청구할 수 있습니다.
- **지급 기한**: 보험사는 서류를 접수한 날부터 3영업일 이내에 지급하는 것이 원칙이며, 조사가 필요하면 기간이 연장되고 그 사유를 알려야 합니다.
- **모든 보험사에 청구**: 하나의 사고로 여러 보험사의 담보(진단비·수술비·실손 등)에 해당할 수 있으므로 가입한 모든 보험사에 청구합니다.

실손보험 청구 간소화 — 실손24

2024년 10월부터 병원(30병상 이상)과 보건소에서, 2025년 10월부터는 의원과 약국까지 **'실손24'** 앱·홈페이지를 통해 진료비 서류를 종이 없이 보험사로 전송할 수 있게 되었습니다. 참여 의료기관이라면 영수증과 세부내역서를 따로 떼지 않아도 됩니다. 참여 여부는 실손24에서 확인할 수 있습니다.

담보별 필요 서류

청구 담보	기본 서류	추가로 챙길 것
실손 통원	진료비 영수증, 진료비 세부내역서(비급여 포함 시), 처방전(약제비)	질병코드가 있는 처방전 또는 진단서(금액이 큰 경우)
실손 입원	입·퇴원 확인서, 진료비 영수증, 세부내역서	수술 시 수술확인서
진단비(암·뇌·심)	진단서(질병코드 포함)	조직검사 결과지(암), 영상 판독지·검사 결과지(뇌·심)
수술비	수술확인서(수술명·수술코드)	종수술은 수술분류표 해당 여부, ADRG는 건강보험 수술코드
후유장해	후유장해 진단서	장해 평가에 쓰인 검사 결과(관절가동범위, 청력·시력 검사 등)
운전자보험	교통사고사실확인원, 합의서·공탁서, 벌금 납부 영수증	변호사 선임 계약서·영수증, 피해자 진단서

청구 담보	기본 서류	추가로 챙길 것
사망	사망진단서, 기본증명서·가족관계증명서	수익자 미지정 시 상속인 전원 서류

청구할 때 놓치기 쉬운 것들

- [ ] 같은 질병으로 받은 **수술·입원·통원**을 각각 청구했는가?
- [ ] 진단서의 **질병코드**가 실제 진단과 맞는가?(C/D, I63/I65 등)
- [ ] **재발·전이·이차암**, 반복 지급되는 치료비 담보를 다시 청구했는가?
- [ ] 오래된 보험의 **소액 담보**(골절 진단비, 깁스 치료비, 입원일당)를 놓치지 않았는가?
- [ ] 장기요양 등급을 받았다면 **간병·장기요양 담보**를 확인했는가?
- [ ] 장해 50%·80% 이상 등 **납입면제** 사유에 해당하는지 확인했는가?
- [ ] 가족의 보험(배상책임 등)으로 처리할 수 있는 사고는 아닌가?

손해사정과 의료자문

보험금이 큰 경우 보험사는 손해사정사를 통해 조사하거나 '의료자문'을 거치기도 합니다. 보험사가 의뢰한 자문의 소견만으로 지급을 거절하거나 줄이는 경우, 주치의 소견서를 보완해 재심사를 요청할 수 있습니다. 보험계약자는 보험사와 별도로 **독립손해사정사**를 선임할 권리도 있습니다.

CHAPTER 41 핵심 요약

- 청구 기한 3년, 서류 접수 후 3영업일 내 지급 원칙
- 실손24로 병원·의원·약국 서류 전송 간소화
- 한 사고에 여러 담보·여러 보험사 — 빠짐없이 청구

부록

실무 자료 모음

진단서의 질병분류코드를 읽는 법, 보험 실무에서 자주 쓰는 코드표, 헷갈리는 보험 용어, 그리고 내 보험을 직접 정리할 수 있는 보장분석 워크시트를 담았습니다.

A 질병분류코드(KCD) 읽는 법과 실무 분류

B 보험 실무 질병코드 요약표

C 보험 용어 사전

D 우리 가족 보장분석 워크시트

APPENDIX A

질병분류코드(KCD) 읽는 법과 실무 분류

진단서 오른쪽 위에 적힌 알파벳과 숫자 한 줄이 보험금을 결정합니다.

KCD란

한국표준질병·사인분류(KCD)는 세계보건기구(WHO)의 국제질병분류(ICD)를 우리나라 실정에 맞게 만든 분류 체계입니다. 통계청이 약 5년마다 개정하며, 현재는 제8차 개정판(KCD-8)이 사용됩니다. 진단서·처방전·진료비 세부내역서에 기재되는 질병코드는 모두 이 분류를 따르며, 보험 약관의 진단비·수술비 담보 대부분이 이 코드로 보장 범위를 정합니다.

■ 코드 구조

알파벳 1자리
대분류(장)
예: I = 순환계통

›

숫자 2자리
중분류(3단위)
예: I63 = 뇌경색증

›

소수점 이하
세분류(4·5단위)
예: I63.5 = 대뇌동맥의 폐쇄 또는 협착에 의한 뇌경색증

실제 진단서에는 하나 또는 여러 개의 부진단 코드가 함께 기재될 수 있습니다. 보험금 청구에서는 보통 **주진단 코드**를 기준으로 하되, 담보에 따라 부진단도 확인합니다.

보험 실무 추천 분류 11가지

No	분류	코드	자주 쓰는 예시
1	**암**	C / D	위암(C16), 폐암(C34), 갑상선암(C73), 제자리암(D00~D09), 양성종양(D33)
2	**뇌·심장**	I / G	뇌경색(I63), 뇌출혈(I61), 협심증(I20), 심근경색(I21), 심방세동(I48)
3	**척추·관절**	M	허리디스크(M51), 경추디스크(M50), 척추협착증(M48), 회전근개파열(M75), 무릎관절염(M17)
4	**소화기**	K	위염(K29), 역류성식도염(K21), 간경변(K74), 담석증(K80), 간암(C22)
5	**호흡기**	J	폐렴(J18), 천식(J45), COPD(J44), 비염(J30), 코로나(U07/B97)
6	**당뇨·대사**	E	당뇨(E11), 고지혈증(E78), 통풍(E79), 갑상선질환(E03/E05)

No	분류	코드	자주 쓰는 예시
7	**정신·신경**	F / G	우울증(F32), 불안장애(F41), 치매(F00), 간질(G40), 안면마비(G51)
8	**상해**	S / T / V / W / X / Y	골절(S52), 화상(T20), 교통사고(V), 낙상(W)
9	**여성·비뇨**	N / O	방광염(N39), 전립선(N40), 자궁내막증(N80), 임신중독증(O14)
10	**감염**	A / B / U	대상포진(B02), 결핵(A15), 코로나(U07), B형간염(B16)
11	**증상·검진·병력**	R / Z	복통(R10), 두통(R51), 건강검진(Z00), 암검진(Z12)

코드 실무 주의사항

- **R코드(증상)**는 확정 진단이 아닙니다. 진단비 청구에는 확정 진단 코드가 필요합니다.
- **Z코드(검진·병력)**는 질병이 아니라는 뜻이 될 수 있어 실손 청구가 거절될 수 있습니다. 검진 중 치료(용종 제거 등)를 했다면 해당 질병코드로 기재되었는지 확인하세요.
- 같은 질환이라도 **C코드와 D코드**, **I63과 I65**처럼 코드 하나로 진단비가 크게 달라집니다.
- 진단서 코드가 실제 진단과 다르다고 생각되면 주치의에게 정정을 요청할 수 있습니다(의학적 근거 필요).
- KCD 개정으로 분류가 바뀐 코드가 있습니다. 예를 들어 일부 혈액 질환(D45 진성적혈구증가증, D46 골수형성이상증후군 등)은 KCD-7부터 악성신생물로 분류되면서 약관에 따라 암 진단비 지급 여부가 달라질 수 있습니다.

APPENDIX B

보험 실무 질병코드 요약표

보험 청구와 가입 심사에서 자주 마주치는 코드를 분야별로 정리했습니다. 전체 목록은 통계청 KCD를 참고하세요.

1. 암·종양(C / D 코드)

코드	질병명(악성신생물)
C00~C14	입술, 구강 및 인두
C15	식도
C16	위
C17	소장
C18~C20	결장, 직장구불결장 이행부, 직장(대장암)
C21	항문 및 항문관
C22	간 및 간내 담관
C23~C24	담낭, 기타 담도
C25	췌장
C32	후두
C34	기관지 및 폐
C40~C41	뼈 및 관절연골
C43	피부의 악성 흑색종
C44	기타 피부의 악성신생물(기타피부암)
C50	유방
C53	자궁경부
C54	자궁체부
C56	난소

코드	질병명
C61	전립선
C62	고환
C64	신장(신우 제외)
C67	방광
C71	뇌
C73	갑상선
C77~C79	이차성(전이성) 악성신생물
C81	호지킨 림프종
C82~C86	비호지킨 림프종 등
C90	다발골수종 및 악성 형질세포 신생물
C91~C95	백혈병
D00~D09	**제자리 신생물(제자리암)**
D10~D36	양성 신생물(예: D12 대장, D25 자궁근종, D33 뇌)
D37~D48	**행동양식 불명 또는 미상의 신생물(경계성종양)**

※ C코드: 일반암 담보 대상(갑상선·기타피부암 등은 약관에 따라 유사암·소액암) / D코드: 제자리암·경계성종양은 '유사암', 양성 신생물은 암 아님.

2. 뇌·심장·혈관(I / G 코드)

코드	질병명	코드	질병명
I10~I15	고혈압성 질환	I60	지주막하출혈
I20	협심증	I61	뇌내출혈
I21	급성 심근경색증	I62	기타 비외상성 두개내출혈
I22~I23	후속 심근경색증, 합병증	I63	뇌경색증
I24~I25	기타 급성·만성 허혈성 심장질환	I64	출혈 또는 경색으로 명시되지 않은 뇌졸중
I26	폐색전증	I65~I66	뇌경색을 유발하지 않은 뇌전·대뇌동맥 폐쇄 및 협착
I34~I37	비류마티스성 판막 장애	I67	기타 뇌혈관 질환(모야모야병, 뇌동맥류 등)
I42	심근병증	I69	뇌혈관 질환의 후유증
I47~I49	빈맥, 심방세동, 기타 부정맥	I70	죽상경화증
I50	심부전	I71	대동맥 동맥류 및 박리
G20	파킨슨병	G45	일과성 뇌허혈발작
G30	알츠하이머병	G40	뇌전증(간질)

3. 척추·관절·근골격(M 코드)

코드	질병명	코드	질병명
M15~M19	관절증(M17 무릎관절증, M16 고관절증)	M48	기타 척추병증(척추관협착증)
M23	무릎 내부 장애(반월상연골 손상)	M50	경추간판 장애(목디스크)
M43	기타 변형성 등병증(척추전방전위증)	M51	기타 추간판 장애(허리디스크)
M45	강직성 척추염	M54	등통증(요통, 경통)
M65	윤활막염 및 힘줄윤활막염(방아쇠수지)	M75	어깨 병변(회전근개파열, 오십견 M75.0)
M77	기타 골부착부병증(테니스엘보)	M79.7	섬유근통
M80~M81	골다공증	M84	골연속성의 장애(스트레스 골절 등)

4. 소화기·간(K 코드)

코드	질병명	코드	질병명
K21	위-식도역류병	K63.5	결장의 폴립(대장 용종)
K25~K28	위·십이지장·소화성 궤양	K70	알코올성 간질환
K29	위염 및 십이지장염	K74	간의 섬유증 및 경변증
K31.7	위 및 십이지장의 폴립(위 용종)	K76.0	지방간

코드	질병명	코드	질병명
K35~K37	충수염(맹장염)	K80~K81	담석증, 담낭염
K40~K46	탈장	K85~K86	급성·만성 췌장염
K50~K51	크론병, 궤양성 대장염	K60~K64	항문 질환(치열, 치루, 치핵 등)
K58	과민대장증후군	K92	기타 소화기 질환(위장관 출혈)

5. 호흡기(J 코드)

코드	질병명	코드	질병명
J00~J06	급성 상기도 감염(감기, 인두염, 편도염)	J32	만성 부비동염(축농증)
J09~J11	인플루엔자(독감)	J34.2	비중격 만곡증
J12~J18	폐렴	J44	만성 폐쇄성 폐질환(COPD)
J20~J21	급성 기관지염	J45	천식
J30	혈관운동성 및 알레르기성 비염	J84	기타 간질성 폐질환(폐섬유증)

6. 내분비·대사(E 코드)

코드	질병명	코드	질병명
E03	기타 갑상선기능저하증	E11	2형 당뇨병
E04	기타 비독성 갑상선종(갑상선 결절)	E66	비만
E05	갑상선중독증(갑상선기능항진증)	E78	지질단백질 대사장애(고지혈증)
E10	1형 당뇨병	E79	퓨린 대사장애(고요산혈증, 통풍 관련)

7. 정신·신경(F / G 코드)

코드	질병명	코드	질병명
F00~F03	치매	F43	심한 스트레스 반응 및 적응장애(PTSD)
F10	알코올 사용에 의한 장애	F45	신체형 장애
F20	조현병	F51	비기질성 수면장애
F31	양극성 정동장애	F90	운동과다장애(ADHD)
F32~F33	우울에피소드, 재발성 우울장애	F95	틱장애
F40~F41	공포불안장애, 공황장애·범불안장애	G43	편두통
G35	다발경화증	G47	수면장애(수면무호흡 G47.3)

코드	질병명	코드	질병명
G51	안면신경 장애(안면마비)	G56	팔의 단일신경병증(손목터널증후군)

※ 정신질환(F코드) 진료 이력은 보험 가입 심사와 실손 보상 범위에 영향을 줄 수 있습니다(CHAPTER 03, 33).

8. 상해·골절·사고(S / T / V / W / X / Y 코드)

코드	분류	대표 예
S00~S09	머리의 손상	S06 두개내 손상(뇌진탕, 외상성 뇌출혈)
S10~S19	목의 손상	S13.4 경추 염좌(목 염좌)
S20~S39	흉부·복부·허리·골반 손상	S22 갈비뼈 골절, S32 요추·골반 골절, S33.5 요추 염좌
S40~S69	어깨·팔·손목·손 손상	S42 어깨·위팔 골절, S52 아래팔 골절, S62 손목·손 골절
S70~S99	엉덩이·다리·발목·발 손상	S72 대퇴골 골절, S82 아래다리 골절, S93 발목 염좌
T20~T32	화상 및 부식	T20 머리·목 화상, T31 체표면적에 따른 화상
V01~V99	운수사고	V03 보행자 교통사고, V43 승용차 탑승자 사고
W00~X59	기타 불의의 사고	W01 미끄러짐·넘어짐, W10 계단 낙상
X60~X84	고의적 자해	—

※ 골절 진단비는 보통 S코드 중 골절(fracture) 항목에 지급하며, 치아 파절(S02.5)은 제외하는 약관이 많습니다.

9. 눈·귀(H 코드)

코드	질병명	코드	질병명
H00~H01	다래끼, 안검염	H40~H42	녹내장
H02.4	눈꺼풀 처짐(안검하수)	H52	굴절 및 조절 장애(근시·난시 등)
H10	결막염	H65~H66	중이염
H25~H26	백내장	H81	전정기능 장애(메니에르병, 이석증)
H33	망막박리	H90~H91	난청
H35.3	황반변성	H93.1	이명

10. 감염(A / B / U 코드)

코드	질병명	코드	질병명
A00~A09	장 감염(식중독, 감염성 장염)	B16~B18	B형·C형 바이러스 간염
A15~A19	결핵	B20~B24	HIV 질환

코드	질병명	코드	질병명
A41	패혈증	B35~B37	피부사상균증(무좀), 칸디다증
B00	헤르페스 바이러스 감염	U07.1	코로나19(바이러스 확인)
B01~B02	수두, 대상포진	U07.2	코로나19(바이러스 미확인)

11. 피부·증상·검진(L / R / Z 코드)

코드	질병명	코드	질병명
L20	아토피 피부염	R10	복부 및 골반 통증
L40	건선	R42	어지럼증
L50	두드러기	R51	두통
L70	여드름(실손 미보상 항목 해당 가능)	R73	혈당 증가(공복혈당장애 등)
L72	피부·피하 조직의 소포성 낭(피지낭종)	Z00	일반 건강검진
L91	켈로이드 흉터	Z12	신생물에 대한 특수선별검사(암검진)

12. 출생기·선천기형(P / Q 코드)

코드	질병명	코드	질병명
P07	단기 임신 및 저체중 출생(미숙아)	Q00~Q07	신경계통의 선천기형
P22	신생아의 호흡곤란	Q20~Q28	순환계통의 선천기형(선천성 심장병)
P59	신생아 황달	Q35~Q37	구순·구개열
P36	신생아의 세균성 패혈증	Q65	고관절의 선천 변형
P91	신생아의 기타 대뇌 장애	Q90	다운증후군

※ P코드는 출생 전후 신생아에게만 발생하는 질환, Q코드는 태어날 때부터 존재하는 구조적 이상입니다. 태아보험·어린이보험 가입 시 선천이상 보장 여부를 확인하세요. 본 표는 KCD-8 기준이며, 실제 진단서에는 1개 또는 여러 부진단 코드가 함께 기재될 수 있습니다.

APPENDIX C

보험 용어 사전

이 책에 나온 주요 용어를 가나다순으로 정리했습니다.

용어	뜻
감액기간	가입 후 일정 기간(보통 1~2년) 동안 보험금을 일부(예: 50%)만 지급하는 기간
갱신형	일정 주기마다 나이·손해율을 반영해 보험료를 다시 계산하는 계약
경계성종양	양성과 악성의 중간 성격의 종양(D37~D48). 대부분 유사암으로 분류
계약자	보험사와 계약을 맺고 보험료를 낼 의무를 지는 사람
고지의무(알릴의무)	청약 시 보험사가 묻는 중요 사항을 사실대로 알려야 할 의무
구상권	보험금을 지급한 보험사가 사고 책임자에게 그 금액을 청구할 수 있는 권리
급여 / 비급여	건강보험이 적용되는 진료 / 적용되지 않아 환자가 전액 부담하는 진료
납입면제	약관이 정한 사유(중대한 질병, 장해 50% 이상 등) 발생 시 이후 보험료를 내지 않아도 보장이 유지되는 제도
면책기간	가입 후 보장이 시작되지 않는 기간(암 90일, 치아 질병 90일 등)
부담보	특정 부위·질병을 일정 기간 보장에서 제외하는 조건부 인수
비갱신형	납입기간 동안 보험료가 변하지 않는 계약
비례보상	여러 보험에 가입해도 실제 손해액을 한도로 보험사들이 나누어 보상하는 방식
BEP(손익분기점)	두 선택의 손익이 같아지는 지점. 실손 전환 판단에서는 '더 내는 보험료 = 더 받는 보험금'이 되는 의료비 수준
산정특례	중증·희귀질환자의 건강보험 본인부담률을 0~10%로 낮춰 주는 제도
선지급	보험금 지급 사유가 확정되기 전이나 사망 전에 보험금 일부를 먼저 지급하는 것
소멸시효	권리를 행사하지 않으면 소멸하는 기간. 보험금 청구권은 3년
수익자	보험금을 받는 사람
약관	보험계약의 구체적인 권리·의무를 정한 문서
유사암	갑상선암·제자리암·경계성종양·기타피부암 등 일반암보다 적게 지급하는 암 분류(상품별 정의 상이)
재가입 주기	실손보험에서 보장 내용이 그 시점의 상품으로 바뀌는 주기(4·5세대 5년)
정액보상	실제 손해와 관계없이 약속한 금액을 지급하는 방식
제자리암(상피내암)	암세포가 상피층 안에만 머문 상태(D00~D09)
주계약 / 특약	계약의 기본이 되는 보장 / 주계약에 덧붙여 선택하는 보장
중상해	생명에 대한 위험, 불구, 불치·난치의 질병에 이른 상해. 종합보험 가입과 무관하게 형사처벌 대상
질병분류코드(KCD)	통계청이 정한 한국표준질병·사인분류. 진단서의 알파벳+숫자 코드

용어	뜻
차등제	직전 1년 비급여 보험금에 따라 다음 해 실손 비급여 보험료를 할인·할증하는 제도
표준체 / 간편체	일반 심사를 통과한 건강한 가입자 / 간소화된 질문으로 가입하는 유병자
피보험자	보험사고의 대상이 되는 사람
해약환급금	계약을 중도 해지할 때 돌려받는 금액
현물급부	보험금(현금) 대신 서비스(예: 변호사 조력)를 직접 제공하는 보상 방식
CDR	임상치매척도. 0~5점으로 치매의 중증도를 평가
CI / GI	중대한 질병(Critical Illness) / 일반 질병(General Illness) 보장 보험
TNM	종양 크기(T)·림프절(N)·원격전이(M)로 암의 병기를 분류하는 국제 기준

APPENDIX D

우리 가족 보장분석 워크시트

이 페이지를 인쇄해 가족별로 채워 보세요. 같은 위험이라도 담보 정의가 다르면 따로 적습니다.

① 보유 계약 목록

피보험자	보험사	상품명	가입일	납입/보장기간	월 보험료
				월 보험료 합계	

② 위험별 보장 금액(만 원)

보장 항목	본인	배우자	자녀 1	자녀 2	관련 장
일반사망					04, 20
질병사망 / 상해사망					04
상해후유장해 / 질병후유장해					06
일반암 진단비					08~10
유사암 진단비					09
암 주요치료비 / 표적·면역항암					10
뇌출혈 / 뇌졸중 / 뇌혈관질환					13
급성심근경색 / 허혈성 / 심혈관					14
산정특례 진단비(뇌·심)					12
질병수술비 / 1~5종 / ADRG					11, 15
입원일당 / 간병인 지원·사용					19
치매(CDR) / 장기요양 등급					18

보장 항목	본인	배우자	자녀 1	자녀 2	관련 장
연금(국민·퇴직·개인 / 월 예상액)					21~22
상속재원(종신 사망보험금 / 예상 상속세)					20, 23
변액(종류 / 적립금 / 최저보증)					24
실손(세대 / 월 보험료)					32~38
운전자(처리지원금 / 변호사 / 벌금)					26~28
치아(보존 / 보철)					29~30
화재·배상책임(가족 단위)					31

③ 판단과 실행 계획

구분	내용
유지할 계약 (유리한 옛 조건)	
보완할 담보 (공백·부족)	
정리할 담보 (중복·과잉)	
갱신·만기 점검	
수익자 변경	
실손 유지/전환 (BEP 결과)	
정부 지원 확인	

■ 실행 순서 체크

- [ ] 새로 가입할 보험의 청약·심사 승인을 먼저 받았다.

- [ ] 보장 개시(면책기간 경과)를 확인한 뒤 기존 계약을 정리했다.
- [ ] 변경 후 가족 전체의 월 보험료가 목표 범위(가구소득의 8~10% 안팎) 안에 있다.
- [ ] 1년 뒤 다시 점검할 날짜를 달력에 적어 두었다. (____년 ____월 ____일)

EPILOGUE

맺음말 — 좋은 보험은 '이해한 보험'입니다

이 책을 끝까지 읽으셨다면, 이제 서랍 속 보험증권이 조금은 다르게 보일 것입니다. '뇌출혈'과 '뇌혈관질환'의 차이, 갱신형 특약이 노후에 어떤 부담이 될지, 내 실손이 몇 세대이고 5세대로 바꾸면 손해인지 이득인지를 스스로 따져 볼 수 있게 되었을 것입니다.

보험에 정답은 없습니다. 같은 보험도 누군가에게는 꼭 필요하고, 누군가에게는 과한 부담입니다. 그래서 중요한 것은 '남들이 많이 드는 보험'이 아니라 **'내 위험과 내 재무 상황에 맞는 보험'**을 고르는 눈입니다. 그 눈은 상품을 많이 아는 데서가 아니라, 구조와 원리를 이해하는 데서 생깁니다.

이 책에서 다룬 통계와 제도는 계속 바뀝니다. 암 통계는 해마다 새로 발표되고, 장기요양 수가는 매년 조정되며, 실손보험은 몇 년마다 새로운 세대가 나옵니다. 하지만 이 책에서 익힌 질문들 — **무엇을, 얼마나, 언제까지, 얼마에 보장받는가** — 은 바뀌지 않습니다. 1년에 한 번, 부록의 워크시트를 꺼내 이 질문들을 다시 던져 보세요. 그것만으로도 보험은 '불안해서 드는 상품'에서 '이해하고 활용하는 도구'가 됩니다.

여러분과 가족의 건강과 평안을 진심으로 바랍니다.

면책 고지

이 책은 보험에 대한 일반적인 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성되었으며, 특정 보험 상품의 가입·해지·전환을 권유하지 않습니다. 본문의 통계·제도·금액은 집필 시점(2026년 10월)의 공개 자료를 기준으로 하며 이후 변경될 수 있습니다. 개별 계약의 보장 여부와 보험금은 해당 상품의 약관과 보험증권, 보험회사의 심사에 따라 결정됩니다. 보험 계약에 관한 중요한 결정은 약관을 확인하고 필요 시 전문가와 상담한 뒤 내리시기 바랍니다.



보험이 쉬워지는 시간

내 보험, 혼자 보기 어렵다면
보험친구 박혜경에게 물어보세요

가입보다 점검이 먼저입니다. 지금 가진 보험부터 함께 살펴봐 드릴게요.

카카오톡 상담

pf.kakao.com/_AGxlFX

블로그

blog.naver.com/lake1448

010-3112-3533

박혜경 · (주)뉴니케 보험자산관리전문회사(GA) 보험설계사 · 등록번호 NK301239

평일 09:00~18:00 · 카톡 상담은 24시간 접수

이 책은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며 특정 상품의 가입을 권유하지 않습니다. 보험계약 체결 전 상품설명서와 약관을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.